



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN BULAN MARET RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

2024

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI2

BAB I4

PENDAHULUAN.....4

A. Latar belakang4

B. Tujuan.....4

BAB II.....5

GAMBARAN UMUM.....5

A. Visi.....5

B. Misi5

C. Motto.....5

Sahabat Menuju Sehat.....5

D. 7 Nilai Budi Utama5

E. Struktur Organisasi Tata Kelola Rumah Sakit.....6

BAB III.....7

LAPORAN KINERJA.....7

A. Profil Pelayanan7

 a. Kunjungan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Januari 2024.....7

 b. Rekap Kunjungan Rawat Jalan Bulan Januari 20248

 c. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA.....8

 d. Profil Tempat Tidur10

B. Profil Pelayanan Antrian Online11

 a. Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online Bulan 2024.....11

 b. Kendala.....11

C. Indikator Kinerja11

 a. BOR, LOS, BTO dan TOI 202411

 b. Evaluasi Hasil BOR, LOS, BTO dan TOI Error! Bookmark not defined.

 c. Klaim Pending12

D. Data Mutu / Keselamatan Pasien.....13

 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit yang Tidak Di inginkan10

E. Permasalahan Rumah Sakit.....64

Beberapa kendala di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo :.....64

F. Profil SDM65

 a. Komposisi dan Distribusi SDM65

 Tenaga Medis65

G. Program Nasional (PROGNAS).....72

H. Kemajuan Piutang	106
a. Data Piutang yang Belum Terbayar	106
b. Analisa Progres Penyelesaian Piutang	Error! Bookmark not defined.
c. Update IKS.....	107
BAB IV.....	114
DATA UTILITAS UNIT.....	114
A. Pelayanan Medis.....	114
a. Tabel Data Kamar Operasi.....	77
b. Tabel Data Instalasi Rawat Jalan	78
c. Tabel Data Instalasi Rawat Inap	79
d. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD)	79
B. Penunjang Medis	118
a. Tabel Data Laboratorium	80
b. Tabel Data Radiologi	81
c. Tabel Data Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)	81
d. Tabel Data Laundry	81
e. Tabel Data Instalasi Gizi.....	81
BAB V.....	118
KESIMPULAN DAN SARAN	126
BAB VI.....	127
PENUTUP.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, laporan kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Maret Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Visi

Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

B. Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

C. Motto

Sahabat Menuju Sehat

D. 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Dipercaya
3. Tanggung Jawab
4. Visioner
5. Disiplin
6. Kerjasama
7. Adil
8. Peduli

E. Struktur Organisasi Tata Kelola Rumah Sakit

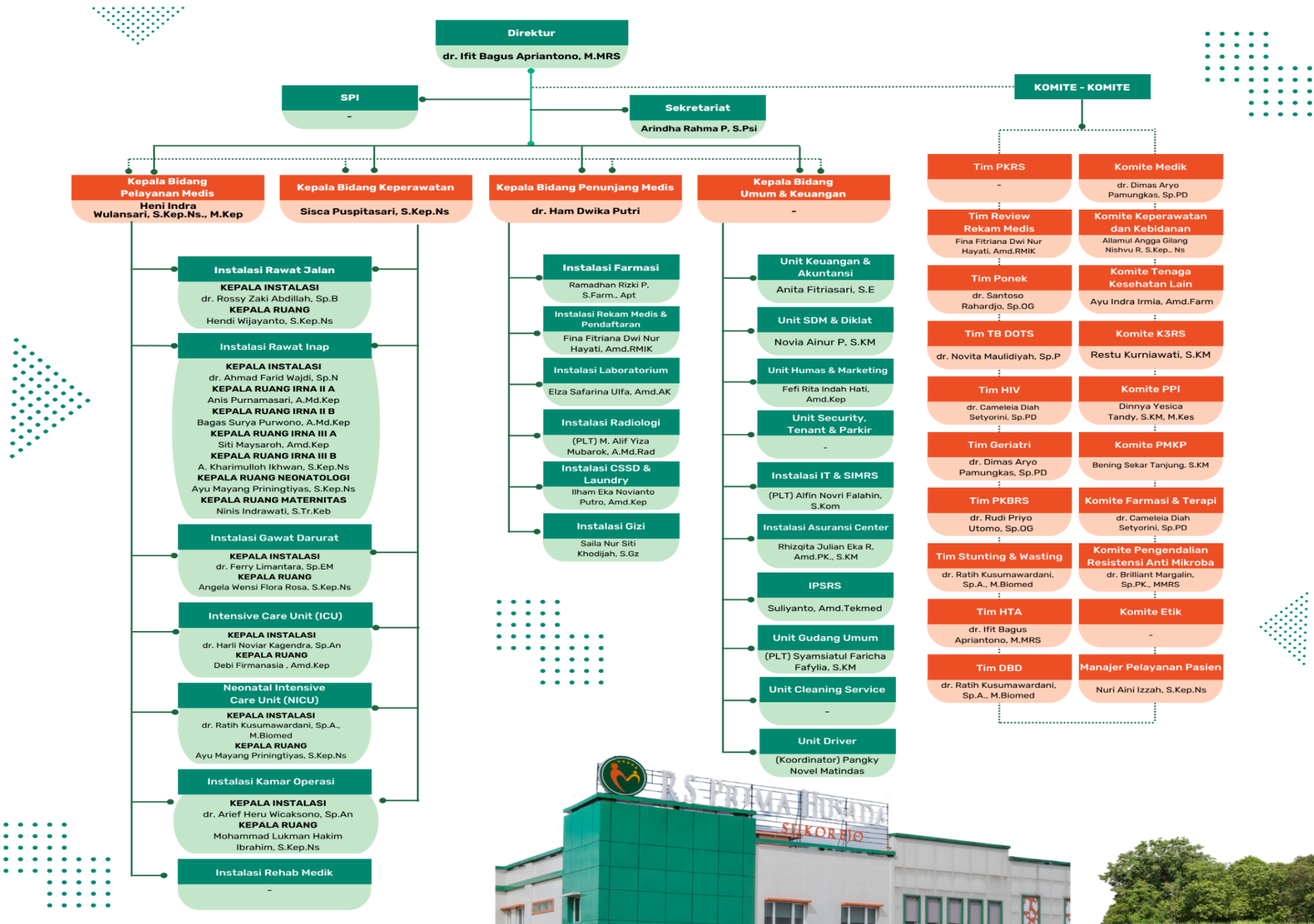


RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

STRUKTUR ORGANISASI
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO



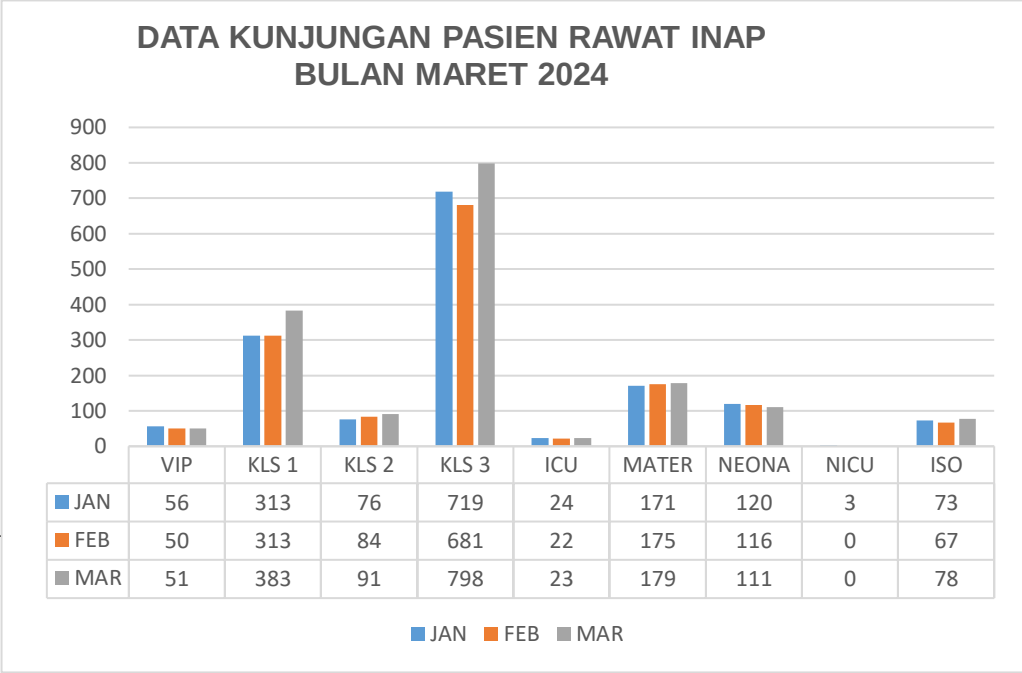
PT. DISA PRIMA MEDIKA



BAB III
LAPORAN KINERJA

A. Profil Pelayanan

1. Kunjungan Pasien Rawat Inap Maret 2024



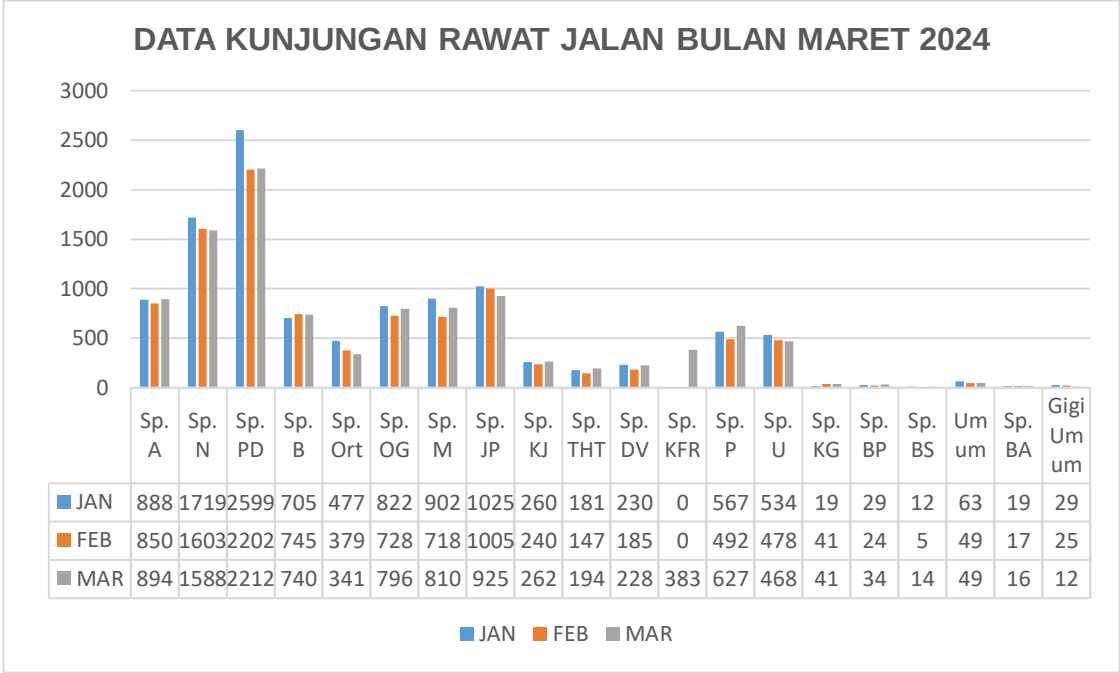
a. Analisa

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pasien pada bulan Maret yaitu sebanyak 12% dibanding dengan bulan Februari. Jumlah pasien rawat inap pada bulan Februari sejumlah 1508 pasien dan pada bulan Maret sebanyak 1714 pasien. Kenaikan terjadi pada semua jenis pelayanan rawat inap berdasarkan hak kelas rawat.

b. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA

Plan	1. Membuat video promosi 2. Promosi terkait layanan-layanan di RS Prima Husada Sukorejo 3. Mempromosikan layanan tambahan kepada pengunjung
Do	1. Komunikasi dengan PKRS untuk membuat video promosi yang menarik dan di share ke masyarakat luas melalui social media yang dimiliki oleh RS Prima Husada Sukorejo 2. Membuat daftar layanan yang ada di RS Prima Husada Sukorejo dan mempromosikan kepada masyarakat luas 3. Membuat flyer layanan tambahan seperti bimbingan kerohanian kepada pasien yang membutuhkan dan gratis
Study	Monitoring dan evaluasi
Action	1. Komunikasi dengan PKRS untuk membuat video promosi yang menarik dan di share ke masyarakat luas melalui social media yang dimiliki oleh RS Prima Husada Sukorejo 2. Membuat daftar layanan yang ada di RS Prima Husada Sukorejo dan mempromosikan kepada masyarakat luas 3. Membuat flyer layanan tambahan seperti bimbingan kerohanian kepada pasien yang membutuhkan dan gratis

2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Maret 2024



- a. Analisa
- Berdasarkan gambar diatas menunjukkan kunjungan rawat jalan pada bulan Maret mengalami kenaikan 6,5% jumlah kunjungan dibanding dengan bulan sebelumnya. Jumlah keseluruhan kunjungan pasien adalah 10634. Pada bulan Maret kunjungan paling banyak berada pada poli penyakit dalam yaitu 2212, diikuti dengan poli syaraf sebanyak 1588, dan poli jantung pada urutan ke tiga yaitu 925.
- b. Review Kunjungan dengan PDSA

Plan	1. Membuat promosi poli malam dan layanan-layanan di Poli 2. Membuat promosi terkait dokter spesialis baru yang bergabung dengan RS Prima Husada Sukorejo
Do	1. Koordinasi dengan PKRS untuk membuat video atau flyer tentang poli malam dan layanan-layanan di Poli RS Prima Husada Sukorejo 2. Mempromosikan pelayanan poli malam kepada Masyarakat melalui marketing
Study	Monitoring dan evaluasi
Action	1. Koordinasi dengan PKRS untuk membuat video atau flyer tentang poli malam dan layanan-layanan di Poli RS Prima Husada Sukorejo 2. Mempromosikan pelayanan poli malam kepada Masyarakat melalui marketing

3. Kunjungan Instalasi Kamar Operasi

a. Tabel Operasi Sesuai Kategori

No	Jenis Operasi	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	Jasa Raharja
1	Kecil	0	20	0	0	0
2	Sedang	1	94	0	1	0
3	Besar	3	214	7	2	5
4	Khusus	2	63	9	0	6

b. Tabel Jenis Pelayanan Berdasarkan DPJP

No	Jenis Pelayanan Berdasarkan DPJP	Cara Bayar				Jumlah
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Lain-Lain	
1	Bedah Umum	2	153	0	1	156

2	Bedah Obgyn	2	97	0	1	100
3	Orthopedi	2	28	14	9	53
4	Bedah Plastik	0	8	2	3	13
5	Urologi	0	79	0	0	79
6	Bedah Saraf	0	0	0	0	0
7	Mata	0	56	0	0	56
8	Bedah Mulut	0	0	0	0	0
9	Kulit dan Kelamin	0	0	0	0	0
10	Telinga Hidung dan Tenggorokan	0	9	0	0	9
11	Bedah Anak	0	6	0	0	6

c. Tabel 10 Besar Tindakan Operasi

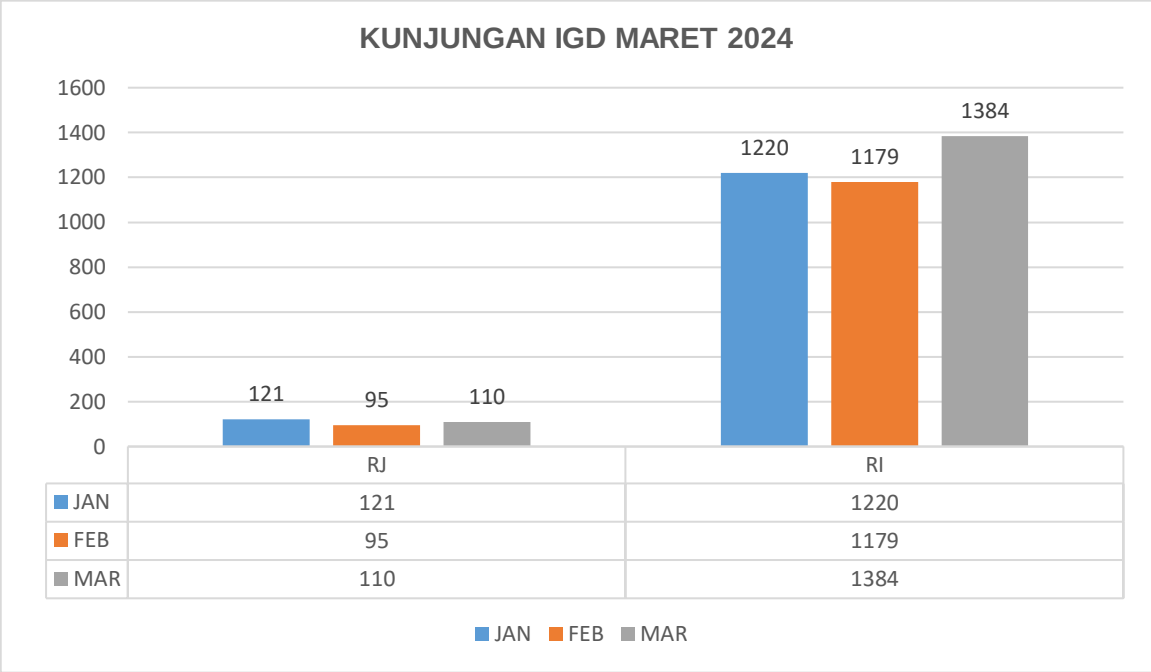
No	Kode ICD 9 CM	Deskripsi	Jumlah
1	SC (74.4), SCTP (74.0), LSCS (74.1)	Sectio Caesarea	91
2	83.39	Excisi	56
3	86.22	Debridement	48
4	56.0	URS	35
5	13.41	Phaco	30
6	79.3 (point 0-9, regionya)	ORIF	27
7	53.00	Herniotomy	24
8	10.42	Eksterpasi dan Graft	20
9	60.29	TURP	19
10	54.21	Laparotomy	13

d. Tabel 10 Besar Diagnosis Operasi

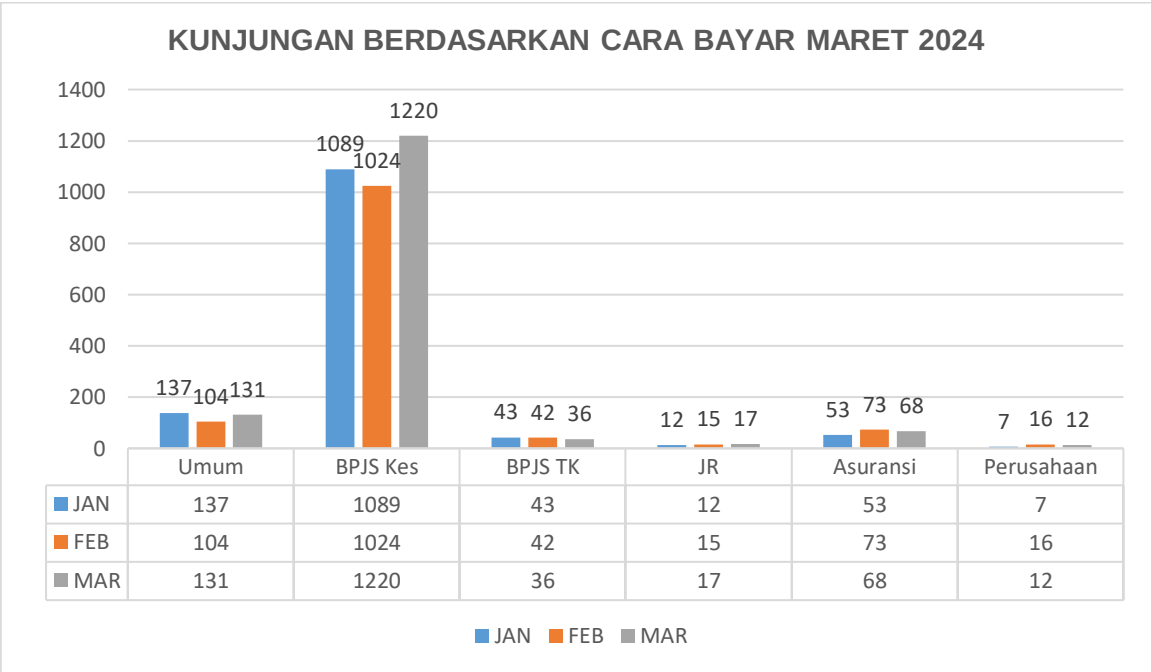
No	Kode ICD 10	Deskripsi	Jumlah
1	D21.9	Soft Tissue Tumor	45
2	N13.2, R33	Hidronefrosis + Batu Ureter	30
3	H25.9	Katarak	30
4	E11.621	Diabetic Foot	28
5	O34.2	Gravida dengan Penyulit BSC	25
6	K46.9	Hernia	24
7	H11.0	Pterygium	20
8	N40	BPH	19
9	O63.0	Gravida dengan Penyulit Kala 1 Fase Laten	19
10	O42.02	Gravida dengan Penyulit KPD	15

3.1.2 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat

a. Grafik Jumlah Kunjungan Pasien IGD



b. Tabel Jumlah Kunjungan Berdasarkan Cara Bayar

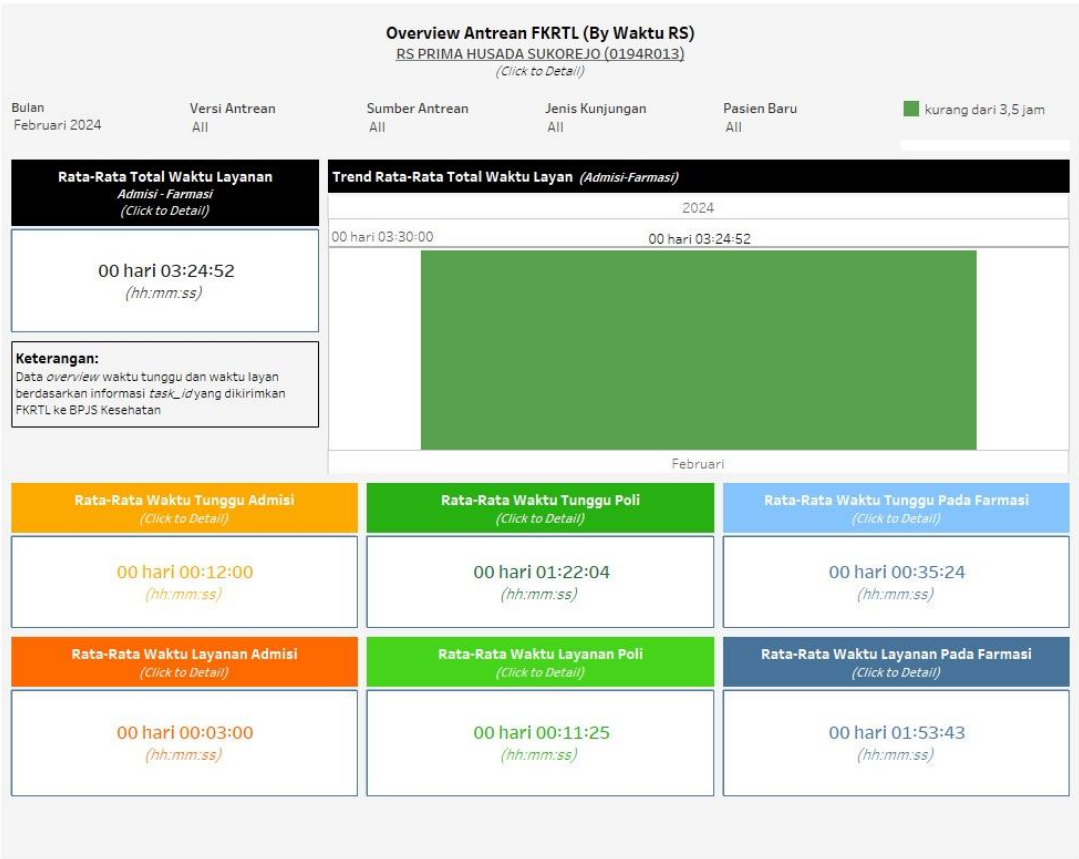


4. Profil Tempat Tidur

- a. Jumlah Real Tempat Tidur : 172 TT
- b. Jumlah Tempat Tidur yang dioperasikan : 136 TT

B. Profil Pelayanan Antrian Online

a. Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online Bulan Maret 2024



b. Kendala

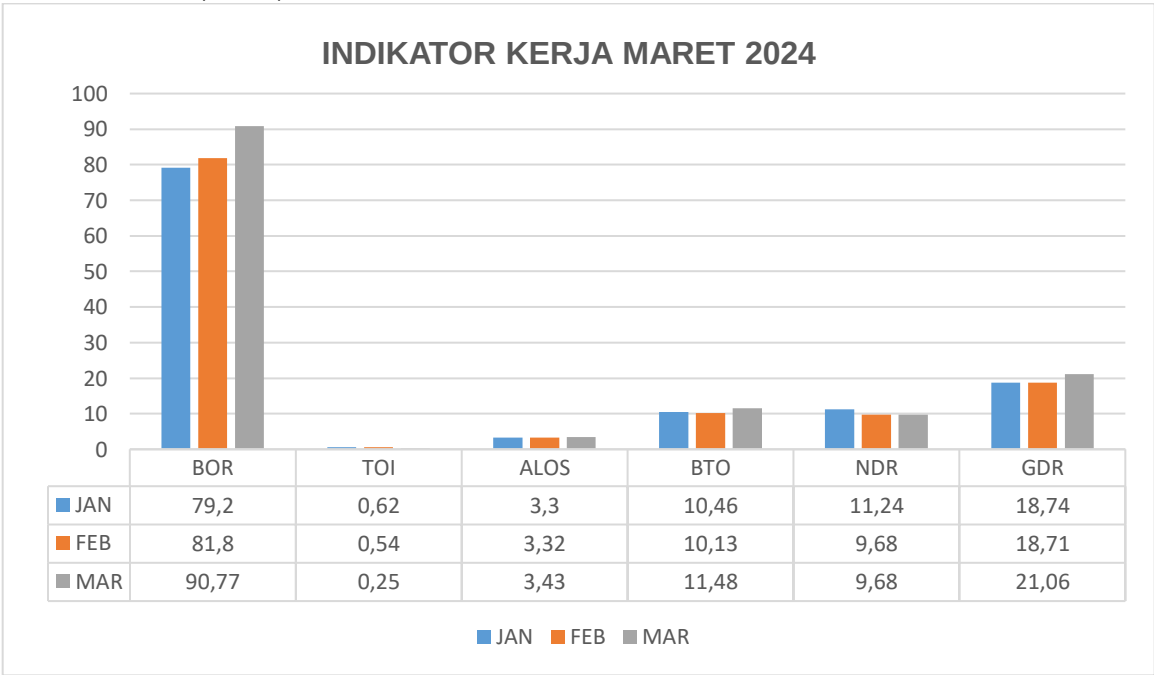
- 1. Pasien tidak semuanya memahami cara penggunaan, sehingga terkadang butuh bantuan dan membutuhkan waktu
- 2. Jaringan internet yang kurang stabil sehingga pemrosesan sedikit tertunda
- 3. Jaringan internet handphone pasien yang kurang stabil

c. Kelebihan Mobile JKN

- 1. Pemanggilan pasien lebih cepat dan efektif
- 2. Pemberkasan data pasien lebih mudah karena sudah masuk dalam system
- 3. Waktu tunggu di pendaftaran lebih cepat karena sudah tersistem

C. Indikator Kinerja

a. BOR, LOS, BTO dan TOI 2024



Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan Maret 2024 didapatkan nilai indikator:

- BOR sebesar 90.77 % (standar : 60-85%)
- LOS sebesar 3.43 hari sesuai dengan standard RSPHS terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari),
- TOI sebesar 0.25 hari (standar : 1-3 hari)
- BTO sebesar 11.48 kali (standar : 40-50 kali)

Analisa :

Berdasarkan standart indikator diatas nilai BOR sudah sesuai standar.

Adanya kenaikan nilai BOR di Bulan Maret 2024 di bandingkan dengan Bulan Februari 2024, hal ini dikarenakan jumlah pasien rawat inap menaik secara signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah mencapai efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit.

Masalah :

Indikator BOR, TOI, LOS dan BTO belum memenuhi standar, adanya penggunaan tempat tidur yang sangat tinggi mengakibatkan BOR melebihi standar, terkait TOI sebesar 0.25 hari menandakan bahwa waktu tempat tidur tidak terisisangat pendek, ini bisa menjadi salah satu faktor nosocomial, begitupun dengan beban kerja perawat yang cukup tinggi. Terkait LOS yang belum memenuhi standar ini bisa dipengaruhi oleh adanya kualitas pelayanan yang baik serta adanya kendali mutu dan kendali biaya sehingga lama perawatan pasien lebih cepat. Sedangkan BTO standar tersebut digunakan untuk satu tahun penuh, angka 11.48 mencerminkan bahwa 1 tempat tidur bisa digunakan 11.48 kali perawatan dalam sebulan.

RTL :

1. Mengevaluasi jumlah tempat tidur sesuai kebutuhan di rumah sakit
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap

b. Klaim Pending

BULAN	KLAIM PENDING RJ	BERKAS KLAIM RJ	KLAIM PENDING RI	BERKAS KLAIM RI
Jan-24	7/9552	9552	57/1376	1376
Feb-24	15/8503	8503	31/1323	1323
Mar-24		9124		1544

a) Analisis

1. Bayi baru lahir dengan RDS untuk dapat melampirkan hasil BGA
2. Pada kasus pasien gizi buruk marasmus agar dapat melampirkan antropometri pasien yang menunjukkan gizi buruk marasmus
3. Kasus sepsis diminta untuk dapat melampirkan hasil kultur
4. Kriteria pemasangan ventilator apakah sesuai dengan pedoman dnr
5. Pasien dengan kasus flap dimana belum dituliskan kedalam luka pada laporan operasi
6. Kasus administrasi berupa surat penolakan/penjaminan dari jasa raharja serta kronologi yang belum terupload pada berkas pasien

b) Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan dpjp terkait dengan PPK pasien dengan kasus RDS dan asphexia
2. Berkoordinasi dengan ahli gizi untuk dapat menuliskan antropimetri secara lengkap pada lembar ass gizi di rekam medis pasien
3. Koordinasi dengan dpjp terkait dengan kriteria penggunaan ventilator serta melampirkan SOP/penduan terkait dengan kriteria penggunaan ventilator
4. Malakukan koordinasi dengan dpjp untuk menggambarkan dan menjelaskan kedalam luka yang dilakukan tindakan flap
5. Koordinasi dengan IT terkait dengan pemberian link dokumen yang aman kepada verifikator bpjs kesehatan sehingga seluruh dokumen yang dikiirmkan dapat terbaca secara keseluruhan

D. Data Mutu / Keselamatan Pasien

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2024.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit	≥80%
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	≥80%
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	≥80%
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	≥76.61%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

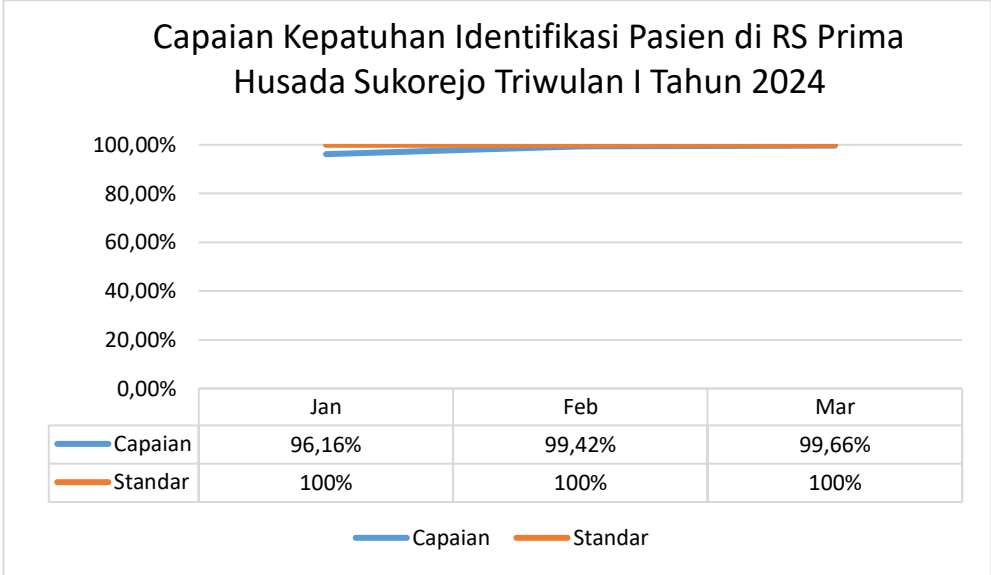
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo pada Triwulan 1 Tahun 2024

No	Judul Indikator	Bulan			Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,16%	99,42%	99,66%	100%	98,41%	PDSA
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency ≤ 30 menit	92,86%	100%	93,33%	≥80%	95,40%	Tercapai
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	61,60%	49,52%	53,64%	≥80%	54,92%	PDSA
4	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	2,17%	0.97%	0%	≤5%	1,05%	Tercapai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	73,96%	73,15%	79,48%	≥80%	75,53%	Tidak tercapai
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Tercapai
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	75,36%	73,57%	73,20%	≥85%	74,04%	Tidak tercapai
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	92,43%	94,%	97,11%	100%	94,55%	Tidak tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	88%	90%	63%	≥80%	80,33%	Tercapai
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	82,26%	75,61%	61.11%	≥ 76.61%	72,99%	Tidak tercapai
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Tercapai
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	91,78%	95,56%	93,68%	100%	93,67%	Tidak tercapai

3.1.2

Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional yang Tidak Diinginkan

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di RS. Prima Husada Sukorejo pada bulan Maret Tahun 2024 mencapai 98,41%. Dari 5250 pasien yang diobservasi pada 14 unit ditemukan 5232 pasien yang dilakukan tindakan identifikasi pasien secara tepat dan 18 pasien tidak dilakukan identifikasi dengan tepat. Berikut merupakan rata-rata capaian untuk setiap unit:

a. IGD

: 100%

b. Instalasi Rawat Jalan

: 100%

c. Instalasi Rawat Inap 2A

: 80%, dari 110 pasien yang di observasi ditemukan 12 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar, 6 pasien tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja dan 6 pasien tidak dilakukan identifikasi secara lisan hanya visual saja.

d. Instalasi Rawat Inap 2B

: 100%

e. Instalasi Rawat Inap 3A

: 100%

f. Instalasi Rawat Inap 3B

: 100%

g. Instalasi Kamar Operasi

: 100%

h. ICU

: 100%

i. Ponak

: 100%

j. Maternitas

: 96,13%, dari 155 pasien yang di observasi ditemukan 6 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar, yaitu tidak diidentifikasi secara visual (melihat gelang identitas pasien) tetapi dilakukan secara lisan saja

k. Neonatologi

: 100%

l. Laboratorium

: 100%

m. Radiologi

: 100%

n. Rehab Medik

: 100%

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada triwulan 1 Tahun 2024 adalah 98,41% dan belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : Merubah kebiasaan individu agar selalu patuh terhadap identifikasi pasien Harapan : Petugas yang namanya masuk dalam kategori tidak patuh dapat dilakukan pemantauan kepatuhan saat identifikasi ke pasien. Tindakan : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Koordinasi dengan kabid keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh d. Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang

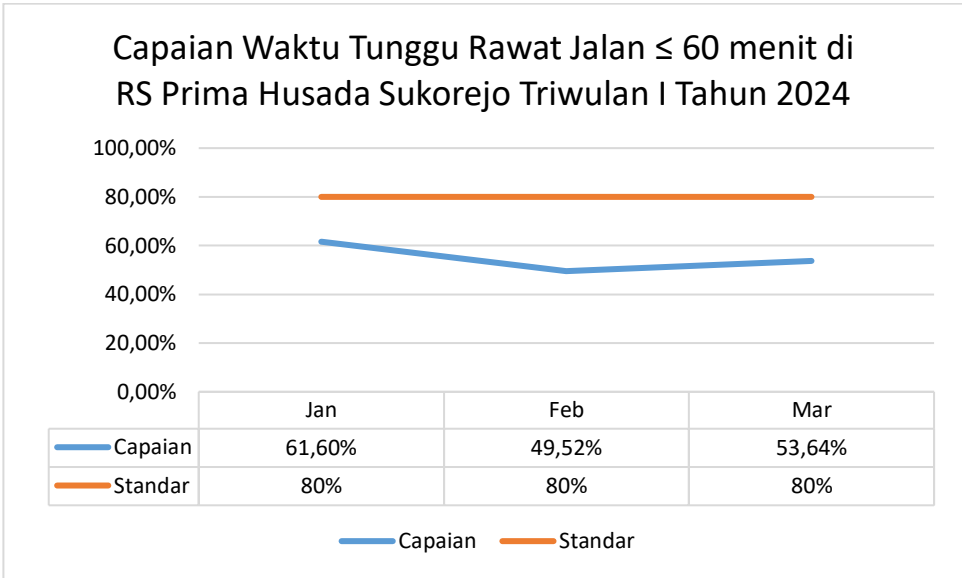
	mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 2. Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 98,41% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan identifikasi pasien belum mencapai standar 100%. Ini dikarenakan masih ditemukan: a. 18 petugas tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien dengan rincian : 1) 0,23% (12 petugas) yang tidak melakukan identifikasi secara visual 2) 0,11% (6 petugas) yang tidak melakukan identifikasi secara lisan 3) 0,27% (14 petugas) yang tidak melakukan identifikasi saat pemberian pengobatan 4) 0,19% (10 petugas) yang tidak melakukan identifikasi saat melakukan prosedur Tindakan 5) 0,11% (6 petugas) yang tidak melakukan identifikasi saat melakukan prosedur diagnostik b. Adapun nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien antara lain: 1) Nanda Diah Fibrianti, S.Kep., Ns (4 kali) 2) Novita Febri Setiyani, S.Kep., Ns (3 kali) 3) Sri Rahayu Kurniawati., S.Kep Ns (1 kali) 4) Antika Setya Narutama, S.Kep., Ns (1 kali) 5) Nanda Daeng Pamungkas, A.Md.Kep (1 kali) 6) Intania Cahya Andini, A.Md.Kep (1 kali) 7) Rodeyah A.Md.Kep (1 kali) 8) Yulia Noer Rohmah, S.Tr., Keb (2 kali) 9) Intan Nur Rohmawati, A.Md.Keb (2 kali) 10) Iga Octanesya Iksahadi A.Md Keb (1 kali) 11) Nurul Komariyah, Amd. Keb (1 kali)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Maret tahun 2024 mencapai 98,41%, masih ditemukan beberapa petugas di unit IRNA 2A dan Maternitas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala unit untuk melakukan pemanggilan staff yang tercatat tidak patuh melakukan identifikasi pasien 2. Koordinasi dengan Kabid Keperawatan dan SDM terkait staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 3. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin. 4. Memberikan catatan khusus tentang ketidak patuhan diarsipkan dalam berkas SDM. 5. Karu mencatatnya juga dalam Form Evkin yang terbaru by name masing2 staf untuk nantinya direkap semesteran bukti tsb harus di tandatangani staf ybs 6. Rapat Mutu dengan karu 7. Pemantauan rapat unit di notulen tercatat membahas mutu 8. Karu memberikan proses pembelajaran yang mendidik

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan staff yang tidak melakukan identifikasi dengan benar untuk menganalisis faktor yang mendasari	Merubah kebiasaan individu agar terbiasa melakukan identifikasi	Staff yang terdaftar tidak patuh melakukan identifikasi pasien	Rapat – koordinasi dan monitoring kepatuhan staff setelah	Ka. Ruangan, Tim SKP, Kabid Keperawatan, SDM dan Mutu	Satu bulan

	tidak melakukan identifikasi pasien	pasien dengan benar		peneguran		
--	-------------------------------------	---------------------	--	-----------	--	--

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, waktu tunggu rawat jalan mengalami peningkatan pada bulan Maret 2024 yakni 53,64% dibandingkan dengan bulan Februari 2024 yakni 49,52% tetapi capaian yang paling tinggi yaitu pada bulan Januari 61,6%. Adapun rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS Prima Husada Sukorejo sampai bulan Maret Tahun 2024 mencapai 54,92%. Di Bulan Maret 2024, dari 110 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 49 pasien yang harus menunggu lebih dari 60 menit yaitu dengan rata-rata 102 menit (1 jam 42 menit). Berikut merupakan jumlah pasien yang menunggu lebih dari 60 menit sampai dilayani oleh dokter diantaranya sebagai berikut:

Nama Dokter	Jumlah Pasien yang menunggu lebih dari 60 menit	Nama Dokter	Jumlah Pasien yang menunggu lebih dari 60 menit
dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	2	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	1
dr. Andika Widianti, Sp.K.J	4	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	9
dr. Arianto Prabowo, Sp. OT	3	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	4
dr. Nyoman Indra Bayu, Sp.M	5	dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	8
dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	2	dr. Heriyatmo, Sp. PD	2
dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U	6	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT.	3

Tabel 3.5 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan 1 Tahun 2024

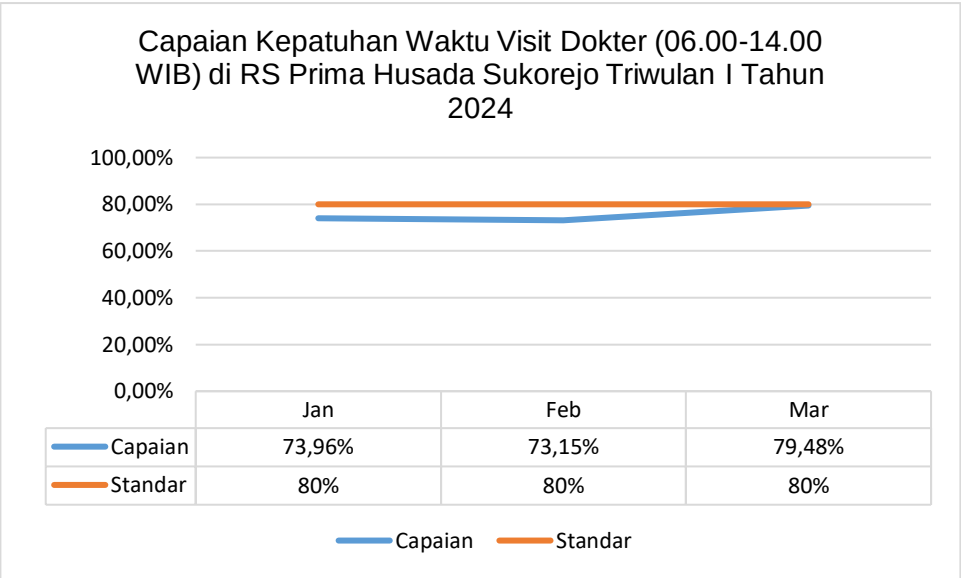
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit Triwulan I Tahun 2024 adalah 54,92%, belum mencapai target 80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan pasien
Plan	Rencana :

	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien Harapan : Semua pasien mendapatkan pelayanan dokter kurang dari 60 menit Tindakan : - Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien - Koordinasi dengan CSO, Pendaftaran terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Waktu pasien rawat jalan yang didaftarkan di tempat pendaftaran sampai dilakukan oleh pemeriksaan oleh dokter
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 54,92%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target $\geq 80\%$. Dari 110 pasien yang diobservasi ditemukan 49 pasien yang menunggu lebih dari 60 menit dengan rata-rata 102 menit (1 jam 42 menit). Ini dikarenakan: - Adanya pasien yang daftar awal sebelum jadwal praktek poli - Adanya pendaftaran melalui Mobile JKN yang menyebabkan pasien yang daftar secara langsung ke Rumah Sakit yang menyebabkan nomor antriannya mundur. - Adanya dokter poli yang melakukan kegiatan operasi ketika ada jadwal poli sehingga menimbulkan waktu tunggu yang lama di poli
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 54,92%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan - Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien - Koordinasi dengan CSO dan Pendaftaran terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn yang bias diakses dimana pun. - Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Irna, jam Operasi adakah yg beririsan - Menggunakan kartu untuk mengukur pasien masuk dalam SIM (saat keluarnya SEP) dengan pemanggilan ke Poly (menggunakan sampel) - Monev khusus progress tiap minggu

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Satu bulan

3. Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap Triwulan I 2024 mencapai 75,53%. Capaian tersebut belum mencapai standar $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 804 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 153 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan sebanyak 12 pasien yang tidak di visite oleh dokter. Berikut merupakan daftar pasien yang mendapatkan visite ≥ 14.00 dan tidak dilakukan visit oleh dokter:

Penjamin	Frequency
BPJS	142
UHC	4
Umum	3
Lain-lain	16

Dokter	Frequency	Dokter	Frequency
dr. Aditya Purwaka, SP.PD	5	dr. Heriyatmo, Sp. PD	1
dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	2	dr. Muhammad Irawan, Sp.A	14
dr. Adhika Prastya Wikananda, Sp.JP	4	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P.	8
dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	3	dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed	8
dr. Bambang Praseno Ardiansyah, Sp.B	8	dr. Rifta Yustiardi sudjoko, Sp.B	1
dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD	18	dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B	1
dr. Dio Mafazi, SP.U	2	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	49
dr. Esti Purwaningrum, Sp,A	12	dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG	3
dr. Fauzia Risma Rahayu, Sp.N	14	dr. Zaki Yamani, Sp.B	2
dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	4	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	2
dr. Fitri Indahyanti, Sp.P, MMRS	4		

Tabel 3.7 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB) pada Triwulan 1 Tahun 2024

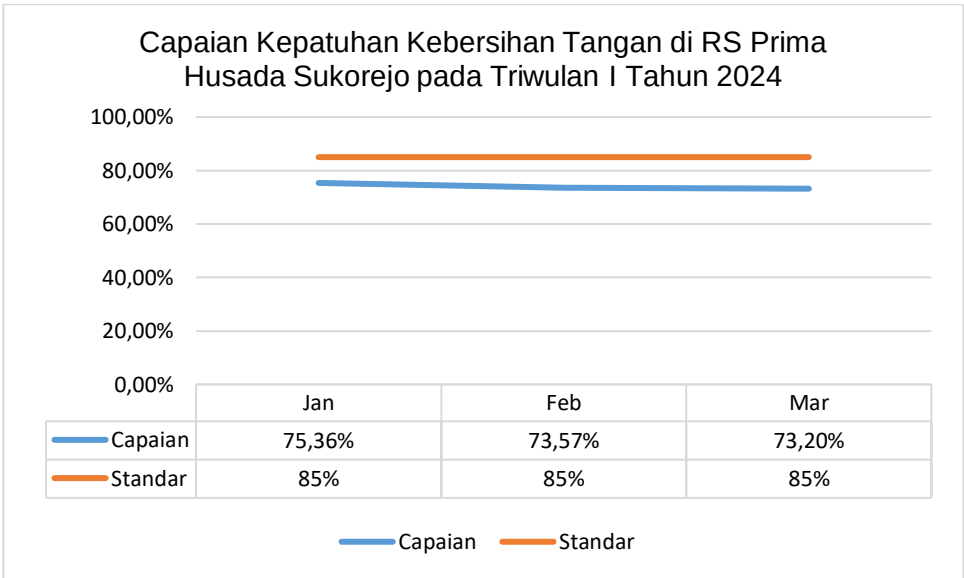
Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Bulan Maret Tahun 2024 adalah 75,53%, belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu visite dokter kepada pasien rawat inap Harapan : Semua pasien rawat inap dapat tervisite oleh dokter Tindakan : d. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan komite medik e. Pemaparan jumlah dokter yang tidak visite dengan tepat waktu

Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. kesesuaian waktu visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 75,53% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 804 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 153 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan 12 pasien yang tidak di visite oleh dokter. Ini dikarenakan: a. Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB b. Adapun nama-nama dokter yang tidak melakukan visit ke pasien adalah sebagai berikut: 1) dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG (5 kali)-----RSSA 2) dr. Aan Dwi Prasetio, Sp.N (1 kali) 3) dr. Dio Mafazi, SP.U (1 kali) 4) dr. Zaki Yamani, Sp.B (1 kali) 5) dr. Fauzia Risma Rahayu, Sp.N (1 kali) 6) dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed (1 kali) 7) dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP (1 kali) 8) dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N (1 kali)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 75,53% dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini diakibatkan karena dari 804 pasien rawat inap yang di observasi ditemukan 153 pasien yang di visite oleh dokter lebih dari jam 14.00 dan 12 pasien yang tidak di visite oleh dokter. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik untuk melakukan peneguran pada dokter yang tidak visit dan tidak konfirmasi ke dokter jaga. 2. Mengatur waktu DPJP antara jam Poly, Jam Visite Irna , jam Operasi adakah yg beririsan termasuk dengan jam praktek DPJP di RS lain 3. Merekrut Home doctor

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan dan komite medik untuk mengingatkan visit ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang tidak visit ke pasien	Rapat koordinasi dengan komite medik	komite medik	Satu bulan

4. Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan I belum mencapai $\geq 85\%$, yaitu 74,04%. Dari 14 unit yang di observasi Masih ditemukan 12 unit yang capaiannya < 85% yakni IRNA 3A 41%, IRNA 3B 80%, IRNA 2A 74%, IRNA 2B 77%, ICU 63%, Maternitas 77%, Neonatologi 79%, IGD 83%, IKO 43%, IRJA 60%, Farmasi 73%, Radiologi 68%.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Kepatuhan Kebersihan tangan petugas pada Triwulan 1 Tahun 2024

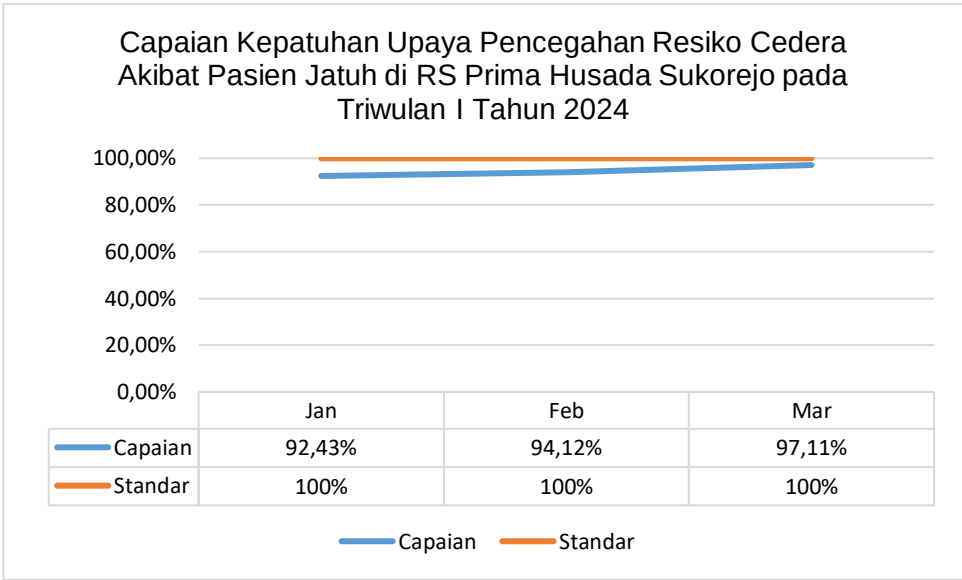
Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan I kurang dari 85% yakni 74,04%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kebersihan tangan pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kebersihan tangan c. Koordinasi dengan PJ PPI di unit untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.
Do	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen yaitu: a. Sebelum kontak dengan pasien b. Sebelum tindakan aseptic c. Setelah terkena cairan tubuh pasien d. Setelah kontak dengan pasien e. Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan kebersihan tangan triwulan I mencapai 74,04% yang belum mencapai standar 85 %. Ini disebabkan dari 3616 petugas yang melakukan kebersihan tangan selama 1 bulan, 2647 petugas yang patuh dan mempraktekan teknik 6 langkah dan 5 momen yang sesuai. 2. Fasilitas kebersihan tangan bulan Maret 2024 sudah 100% terpenuhi 3. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan kebersihan tangan sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	1. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 2. Kolaborasi antara Komite PPI dan kbid keperawatan terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 3. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 5. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 6. Pemberian proses pembelajaran

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Komite PPI	Satu bulan
2	Koordinasi antara Komite PPI, Kabid	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama	Rapat rutin antara Komite PPI,	Komite PPI, Kabid Keperawatan	Satu bulan

	Keperawatan dan SDM terkait petugas yang tidak patuh dalam upaya kebersihan tangan		petugas medis	Kabid Keperawatan dan SDM	dan SDM	
3	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Komite PPI	Satu bulan

5. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Triwulan I tahun 2024 adalah 94.55%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1282 pasien yang di observasi ditemukan 29 petugas yang tidak patuh dalam melakukan skrinning awal dan 8 petugas yang tidak patuh dalam asesmen ulang. Berikut merupakan jumlah ketidakpatuhan dalam pencegahan risiko jatuh yang dilakukan oleh petugas di unit :

Tabel 3.11 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan 1 Tahun 2024

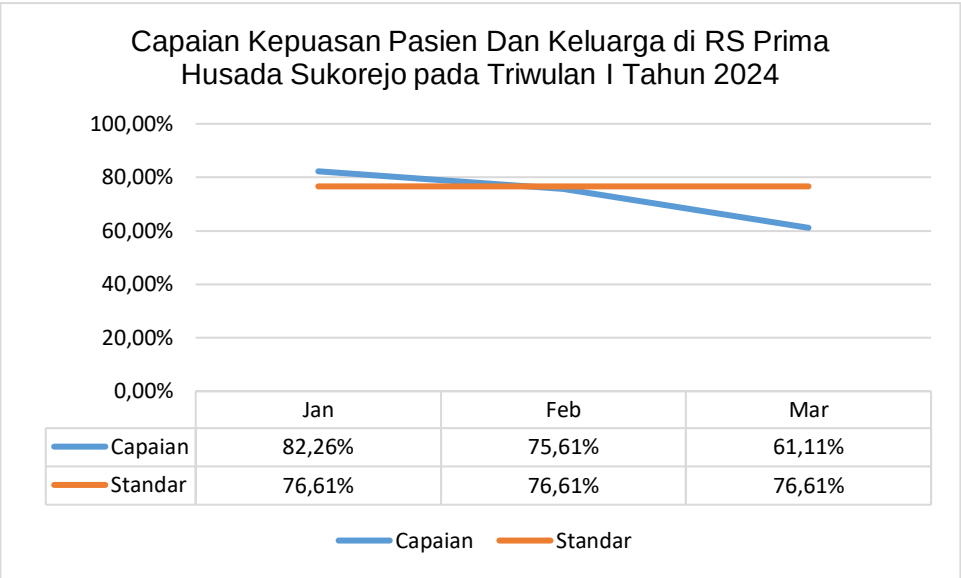
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 94,55%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Harapan : Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien cedera akibat pasie jatuh dapat tercapai 100% Tindakan : a. koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh b. melaksanakan pelatihan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam skrinning awal pasien jatuh di pintu masuk 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen awal pasien 3. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen ulang pasien indikasi

	resiko jatuh 4. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 94,55%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang tidak patuh dalam melakukan skrinning awal dan ulang maupun intervensi pada pasien yang berisiko jatuh. Adapun nama-nama yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh antara lain: 1. Indah Wulan Suci, A.Md.Kep 2. Dimas Ragil Anarkie, A.Md.Kep 3. Selly Mercelia Prasisti, Amd. Kep 4. Vira Agustin Sintia Putri, A.Md.Kep 5. Rezza Anggela Santoso., S.Kep.Ns. 6. Istighosah, A.Md.Kep 7. Firdhausi Nuzula., Amd Kep 8. Ana Nurul Firdausi, A.Md.Kep
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Triwulan I tahun 2024 adalah 94.55%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1282 pasien yang di observasi ditemukan 29 petugas yang tidak patuh dalam melakukan asesmen awal dan 8 petugas yang tidak patuh dalam asesmen ulang. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Ruang, Kepala Bidang Keperawatan dan SDM terkait nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Koordinasi dengan kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	kepala ruang Unit, Kepala Bidang Keperawatan, SDM	Satu Bulan
2	Monitoring dan Evaluasi terkait nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Nama-nama staff yang tidak patuh dalam upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruangan, Komite Mutu	Satu Bulan

6. Kepuasan Pasien dan Keluarga



Hasil Capaian:

Pada grafik tersebut diketahui bahwa Kepuasan Pasien dan Keluarga pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 72,99. Angka tersebut belum mencapai target 76,61%. Dari 18 pasien yang menyecan barcode survey kepuasan pasien, 7 pasien menyatakan ketidakpuasan dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dan 11 pasien yang lain menyatakan puas dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

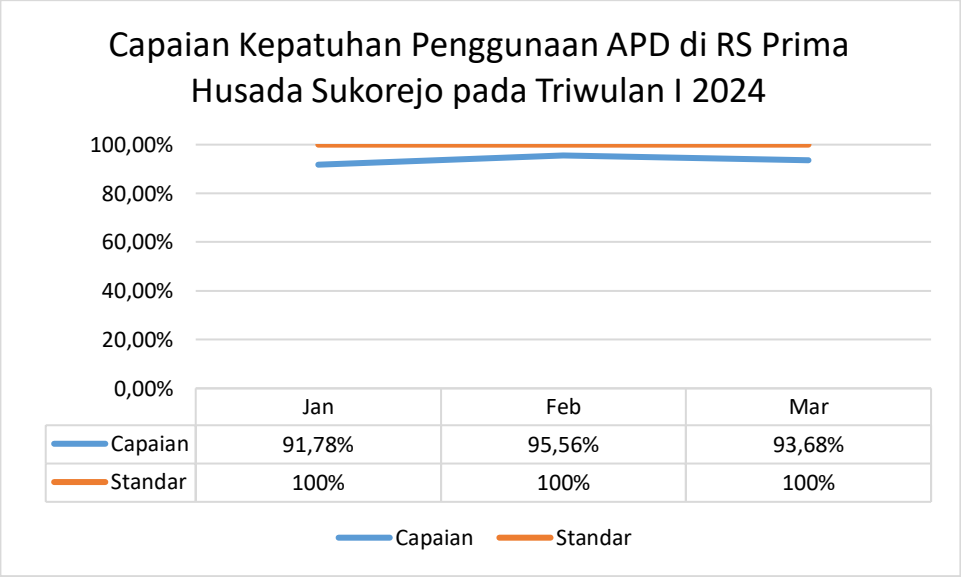
Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepuasan pasien dan keluarga pada Triwulan I yaitu 72,99%, angka tersebut tidak mencapai standar 76,61%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit untuk meminta pasien atau keluarga pasien menyecan barcode survey kepuasan pasien setelah terlayani di masing-masing unit
Plan	1. Rencana: Meningkatkan capaian kepuasan pasien dan keluarga di RS Prima Husada Sukorejo 2. Harapan Pasien dan keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan di RS Prima Husada Sukorejo 3. Tindakan a. Berkoordinasi dengan Kepala Ruangan Unit agar mengarahkan pasien menyecan barcode kepuasan setelah dilayani di masing-masing unit b. Berkoordinasi dengan kbid penunjang terkait pelayanan petugas farmasi c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil survey kepuasan pasien
Do	Pasien dapat menyecan barcode survey kepuasan pasien dan keluarga sehingga dapat menilai pelayanan dari Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Study	Berdasarkan capaian kepuasan pasien dan keluarga pada Triwulan I tahun 2024 adalah 72,99%. Angka tersebut belum mencapai target 76,61%. Dari 18 pasien yang menyecan barcode survey kepuasan pasien, 7 pasien menyatakan ketidakpuasan dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Adapun ketidakpuasan pasien adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Petugas dengan attitude yang kurang ramah 2. Waktu tunggu pelayanan obat yang lama
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kepuasan pasien dan keluarga pada Triwulan I tahun 2024 adalah 72,99%. Angka tersebut belum mencapai target 76,61%. Dari 18 pasien yang menyecan barcode survey kepuasan pasien, 7 pasien menyatakan ketidakpuasan dengan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Berkoordinasi dengan kepala ruangan agar mengarahkan pasien menyecan barcode kepuasan setelah dilayani di masing-masing unit 2. Berkoordinasi dengan kbid penunjang terkait pelayanan petugas farmasi 3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil survey kepuasan pasien

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruangan agar mengarahkan pasien menyecan barcode kepuasan setelah dilayani di masing-masing unit	Survey kepuasan pasien dan keluarga dapat berjalan optimal	Seluruh pasien dan keluarga yang mendapatkan pelayanan di RS Prima Husada Sukorejo	Koordinasi dengan Kepala Ruangan di Unit masing-masing	Komite Mutu dan semua Kepala ruang unit	Satu bulan
2	Berkoordinasi dengan kabisid penunjang, dan kepala ruang farmasi terkait pelayanan petugas farmasi dalam pemberian obat	Kepuasan pasien dan keluarga dapat optimal	Seluruh petugas farmasi	Koordinasi dengan Kabisid Penunjang, Kepala Ruang Farmasi	Kabisid Penunjang, Kepala Ruang Farmasi	Satu bulan
3	Monitoring dan evaluasi survey kepuasan pasien dan keluarga di setiap unit pelayanan.	Survey kepuasan pasien dan keluarga dapat berjalan optimal	Seluruh pasien dan keluarga yang mendapatkan pelayanan di RS Prima Husada Sukorejo	Monitoring dan evaluasi berkala	Kepala Ruangan dan Komite Mutu	Satu bulan

7. Kepatuhan Penggunaan APD



Hasil Capaian :
Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan I 2024 adalah 93,67%. Dari 18 unit yang di observasi masih ditemukan 8 unit yang angka capaiannya belum 100% yakni IRNA 3A 90%, IRNA 3B 97%, IRNA 2A 97%, IRNA 2B 97%, IKO 87%, Laboratorium 53%, Gizi & Dapur 83%, dan CS 83%.

Tabel 3.15 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan I yaitu 93,67%, angka tersebut tidak mencapai standar 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.

Plan	1. Rencana:Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD oleh petugas di RS Prima Husada Sukorejo 2. HarapanSeluruh staf pelayanan patuh dalam penggunaan APD sehingga target kepatuhan dapat dicapai 3. Tindakan a) Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD c) Koordinasi dengan Komite PPI untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	1. Masih ditemukan petugas yang tidak tepat dalam penggunaan masker dan handscoon sesuai indikasi (IRNA). 2. Petugas tidak menggunakan APD yang tepat di area dapur.
Action	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk monitoring penggunaan APD di unit. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 5. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Tabel 3.16 Rencana Tindak Lanjut

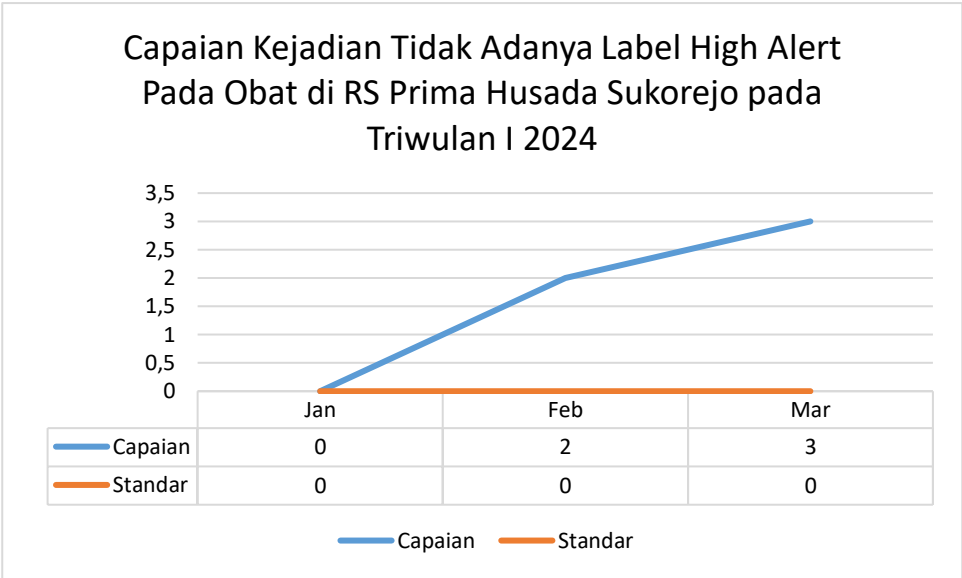
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Komite PPI	Satu bulan
2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Komite PPI	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebutuhan penggunaan APD	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Komite PPI dan komite keperawatan	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi	Komite PPI	Satu bulan

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit
Tabel 3.17 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Triwulan 1 Tahun 2024

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Std	Bulan			Rata-rata	KET
				Jan	Feb	Mar		
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	Identifikasi pasien : Tidak adanya kejadian salah pengambilan obat	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
		Komunikasi Efektif : Ketidakpatuhan pemberian KIE interaksi obat pada pasien rawat jalan	0%		0%	0%	0%	Dipertahankan
		Pelabelan High Alert : Kejadian tidak adanya label high alert pada obat	0		2	3	2	PDSA
		Hand Hygiene : Kepatuhan petugas terhadap hand hygiene	100%	82%	95%	73%	83,33%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	a. waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit b. waktu tunggu pelayanan Racikan ≤ 60 menit	100%		66,67 %	81,52%	74,10%	PDSA
3	Renstra RS	Kepuasan pelanggan	≥80%					Belum mengisi
4	Perbaikan Sistem	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 kejadian		32 kejadian	11 Kejadian	14 kejadian	PDSA
5	Manajemen Resiko	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	0 kejadian	0 kejadian	42 kejadian	15 kejadian	19 kejadian	PDSA

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit yang Tidak Di inginkan

1. Kejadian Tidak Adanya Label High Alert Pada Obat



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kejadian tidak adanya label high alert di Instalasi Farmasi Triwulan I Tahun 2024 yaitu 2 kejadian. Angka tersebut belum mencapai target yaitu 0 kejadian. Ini disebabkan adanya 3 obat high alert yang belum terlabeli diantaranya adalah:

- a. Tricagrelor 90 mg
- b. Vildagliptin 50 mg
- c. Aspilets Chewable 80 mg

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kejadian Tidak Adanya Label High Alert di Instalasi Farmasi pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kejadian tidak adanya label high alert pada triwulan I tahun 2024 adalah 2 kejadian, capaian tersebut belum mencapai target 0 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian tidak adanya label high alert
Plan	Rencana : Obat High Alert terlabeli semua dengan penanda obat high alert Harapan : Tidak adanya kejadian obat high alert yang tidak terlabeli Tindakan : 1. Koordinasi dengan kepala ruangan Farmasi dan Kabid Penunjang untuk menindaklanjuti obat high alert yang tidak terlabeli. 2. Monitoring dan evaluasi terhadap label pada obat high alert .
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Label pada obat high Alert
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada triwulan I tahun 2024 adalah 2 kejadian, capaian tersebut belum mencapai target 0 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan 3 obat high alert yang terlabeli yakni: 1. Tricagrelor 90 mg 2. Vildagliptin 50 mg 3. Aspilets Chewable 80 mg
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian pada triwulan I tahun 2024 adalah 2 kejadian, capaian tersebut belum mencapai target 0 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan 3 obat high alert Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruangan Farmasi dan Kabid Penunjang untuk menindaklanjuti obat high alert yang tidak terlabeli. 2. Monitoring dan evaluasi terhadap label pada obat high alert .

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

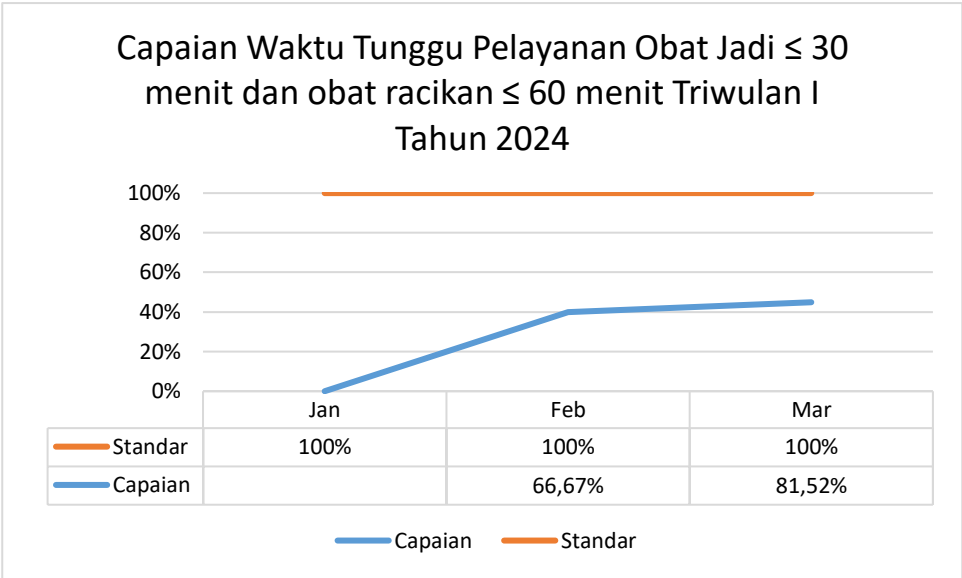
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruangan Farmasi dan Kabid Penunjang untuk	Obat high alert dapat terlabeli secara keseluruhan	Petugas Farmasi yang melayani obat	Rapat koordinasi dengan kabid penunjang, kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang, Kepala Ruangan Farmasi	Satu bulan

	3. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan <i>hand hygiene</i> sebelum mengambil obat.
Action	1. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 2. Kolaborasi antara Komite PPI dan kbid keperawatan terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 3. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 5. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 6. Pemberian teguran saat melakukan supervisi kebersihan tangan

Tabel 3.21. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Komite PPI	Satu bulan
2	Koordinasi antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM terkait petugas yang tidak patuh dalam upaya kebersihan tangan	Menjalin koordinasi secara berkesinambungan	Semua petugas terutama petugas medis	Rapat rutin antara Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Komite PPI, Kabid Keperawatan dan SDM	Satu bulan
3	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Komite PPI	Satu bulan
4	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Komite PPI	Satu bulan

3. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit dan Racikan ≤ 60 Menit .



Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan waktu tunggu pelayanan obat jadi Obat Jadi ≤ 30 Menit dan Racikan ≤ 60 menit pada bulan Maret tahun 2024 adalah 74,10%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Adapun dari 90 pasien yang di observasi ditemukan 20 pasien yang menunggu obat jadi > 30 Menit dengan rata-rata waktu 55 menit dan 10 pasien yang menunggu obat racikan > 60 menit dengan rata-rata 1 jam 37 menit. Berikut List Nama Petugas yang melayani lebih Obat Jadi > 30 Menit dan Racikan > 60 menit.

Nama petugas dalam Pelayanan Obat jadi > 30 Menit	Nama petugas dalam Pelayanan Obat Racikan> 60 Menit
Mifta	Mifta
Shinta	Shinta
Yolanda	Yolanda
	Lilis

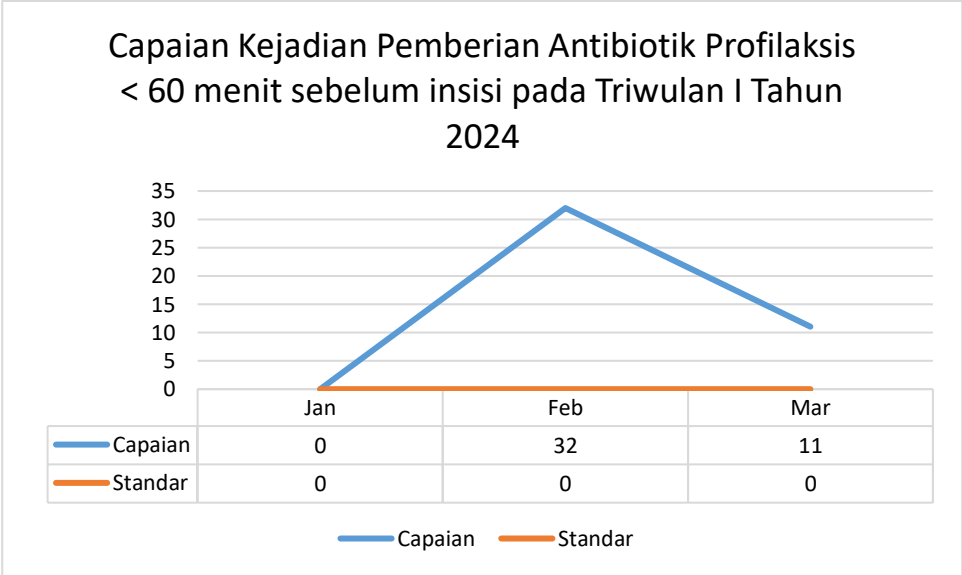
Tabel 3.22 PDSA Capaian Kepatuhan Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi Obat Jadi ≤ 30 Menit Dan Racikan ≤ 60 Menit Di Unit Farmasi pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit dan Racikan ≤ 60 menit pada bulan Maret tahun 2024 adalah 74,10%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit dan Racikan ≤ 60 menit
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit dan Racikan ≤ 60 menit Harapan : Kepatuhan waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 Menit dan Racikan ≤ 60 menit dapat tercapai 100% Tindakan : 1. Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar melakukan pelayanan obat jadi > 30 menit dan racikan > 60 menit. 2. Koordinasi dengan Kabid Penunjang terkait pelayanan petugas dalam melakukan pelayanan obat jadi > 30 menit dan racikan > 60 menit.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Melihat kepatuhan petugas dalam melayani obat dari SIMRS sampai obat dilayani
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada triwulan I tahun 2024 belum mencapai target 100% yakni 74,10%, hal ini disebabkan masih ditemukan petugas yang melayani obat jadi > 30 menit dan obat racikan > 60 menit.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada bulan Maret Tahun 2024 belum sesuai standar dimana waktu pelayanan obat jadi > 30 menit dengan rata-rata 55 menit dan racikan > 60 menit dengan rata-rata waktu 1 jam 37 menit. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.23 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang penunjang dan kepala ruangan farmasi untuk mengingatkan petugas dalam pelayanan obat jadi dan racikan.	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pelayanan obat jadi dan obat racikan	Petugas Farmasi yang melayani obat jadi >30 menit dan obat racikan > 60 menit	Rapat koordinasi dengan kabid penunjang, kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan

4. Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi



Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kejadian pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi pada Triwulan I tahun 2024 adalah 11 kejadian, angka tersebut belum mencapai target yakni 0 kejadian. Adapun dari 41 pasien yang di observasi ditemukan 11 kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi. Kejadian ini disebabkan 2 faktor yakni 6 kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi dan 5 kejadian karena Unit IKO tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien.

Tabel 3.24 PDSA Capaian Kejadian Pemberian Antibiotic Profilaksis < 60 Menit Sebelum Insisi Di Unit Farmasi pada Triwulan 1 Tahun 2024

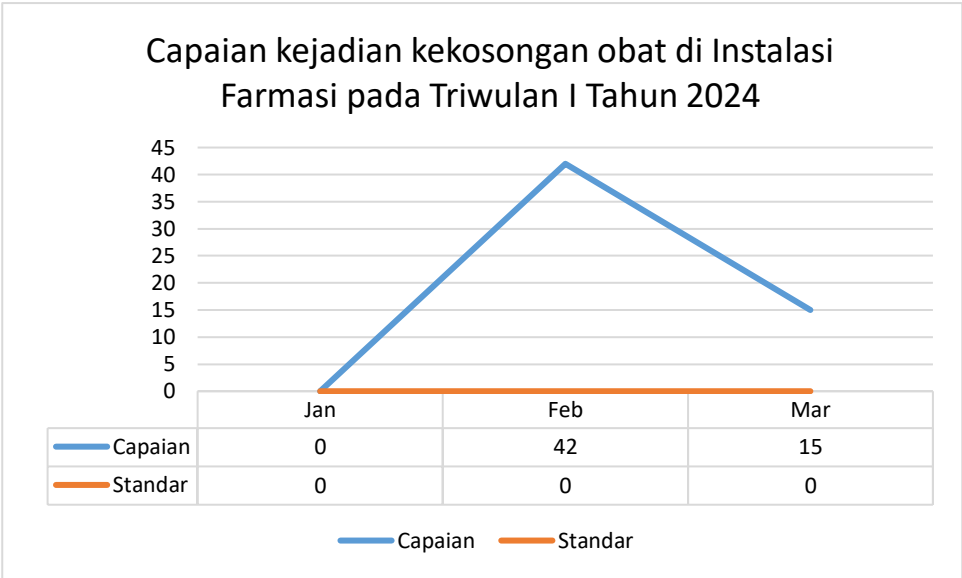
Problem	Rata-rata capaian kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi pada Triwulan I 2024 adalah 11 kejadian dimana tidak mencapai target yakni 0 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi
Plan	1. Rencana : Menurunkan capaian kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi 2. Harapan : Kepatuhan kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi dapat tercapai 0 kejadian. 3. Tindakan : a. Koordinasi dengan kepala ruangan untuk menindaklanjuti petugas yang

	terdaftar keterlambatan pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit. b. Koordinasi dengan Unit IKO dalam kelengkapan penulisan di Rekam Medik terkait jadwal pasien Operasi c. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan terkait pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit. d. Supervisi terkait pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis 2. Melihat penulisan RM terkait jadwal pasien Operasi
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan I belum mencapai target 0 kejadian yakni 11 kejadian. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yakni 6 kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi dan 5 kejadian karena Unit IKO tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan I belum mencapai target 0 kejadian yakni 11 kejadian. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yakni 6 kejadian diakibatkan keterlambatan pemberian oleh petugas farmasi dan 5 kejadian karena Unit IKO tidak menuliskan jadwal waktu pasien operasi di Rekam Medis Pasien. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.25 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala bidang penunjang dan kepala ruangan farmasi dalam kejadian pasien pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit sebelum insisi	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Petugas Farmasi yang terlambat dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Rapat koordinasi dengan kabid pelayanan, kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan
2.	Koordinasi dengan kepala bidang keperawatan kepala ruang farmasi dan kepala ruang IKO dalam kelengkapan penulisan jadwal pasien operasi di RM	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Perawat IKO yang tidak lengkap dalam penulisan jadwal pasien operasi di RM	Rapat koordinasi dengan kabid keperawatan, karu farmasi dan karu IKO	Kabid Keperawatan, Karu Farmasi, dan Karu IKO	Satu bulan
3.	Supervisi terkait kepatuhan petugas dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Memastikan bahwa petugas patuh dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Petugas Farmasi yang terlambat dalam pemberian antibiotic profilaksis < 60 menit	Monitoring dan Evaluasi berkala	Karu Farmasi, Komite PMKP	Satu bulan

5. Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi



Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi pada Triwulan I tahun 2024 adalah 15 kejadian, angka tersebut belum mencapai target yakni 0 kejadian. Adapun jenis obat-obatan yang mengalami kekosongan adalah Aspilet, Clonidine, dan Ring-As. Kejadian ini disebabkan karena distributor mengalami kekosongan jenis obat-obatan tersebut.

Tabel 3.26 PDSA Capaian Kejadian Kekosongan Obat Di Instalasi Farmasi pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi pada bulan Maret tahun 2024 adalah 15 kejadian dimana tidak mencapai target yakni 0 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi
Plan	Rencana : Menurunkan capaian kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi Harapan : Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi dapat tercapai 0 kejadian. Tindakan : Koordinasi dengan Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Ruang Farmasi untuk menindaklanjuti kekosongan obat dari pihak distributor.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Daftar Obat yang mengalami kekosongan di Instalasi Farmasi
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian pada bulan Maret belum mencapai target 0 kejadian yakni 15 kejadian. Hal ini disebabkan masih ditemukan jenis obat-obatan yang mengalami kekosongan adalah Aspilet, Clonidine, dan Ring-As. Kejadian ini disebabkan karena distributor mengalami kekosongan jenis obat-obatan tersebut.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian kejadian kekosongan obat sebelum insisi pada bulan Maret Tahun 2024 belum sesuai standar dimana masih ditemukan jenis obat-obatan yang mengalami kekosongan adalah Aspilet, Clonidine, dan Ring-As. Kejadian ini disebabkan karena distributor mengalami kekosongan jenis obat-obatan tersebut. Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.27 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Ruang Farmasi untuk menindaklanjuti kekosongan obat dari pihak distributor.	Menurunkan kejadian kekosongan obat di Unit Farmasi	Daftar obat yang kosong dari depo dan Gudang Farmasi	Rapat koordinasi dengan kabid penunjang dan kepala ruangan farmasi	Kabid Penunjang dan Karu Farmasi	Satu bulan

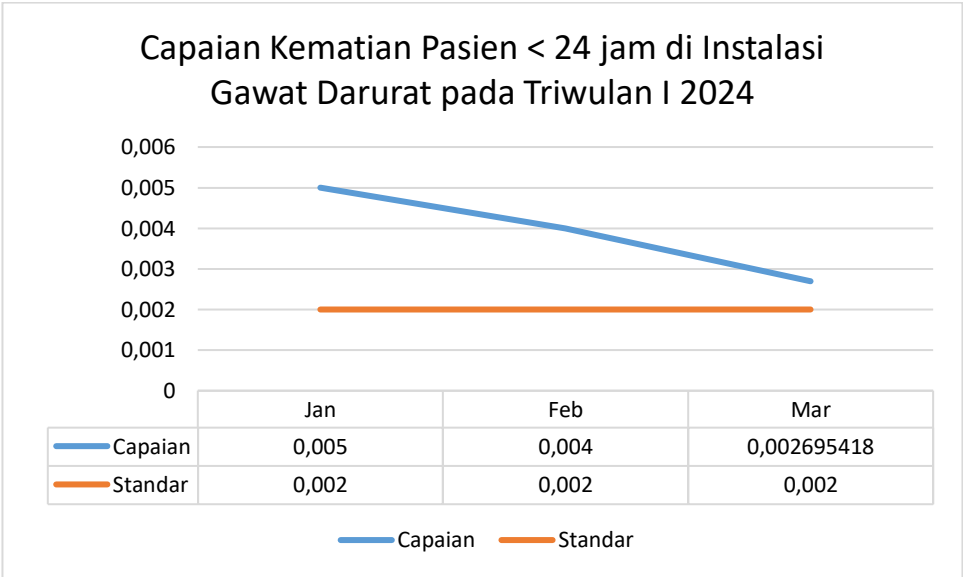
3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.24 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan 1 Tahun 2024

No	Judul Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,31%	100%	100%	99,77%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1	Waktu tanggap pelayanan dokter <5 menit setelah pasien datang	100%	96,49%	100%	100%	98,25%	Dipertahankan
2	Kematian pasien < 24 jam (sebelum 8 jam)	≤ dua per seribu	7/ 1341	6/1274	4/1484		PDSA
3	Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian medis IGD	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
5	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian keperawatan IGD	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6	Ketidaklengkapan formulir rujukan pasien	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7	Ketidaklengkapan dokumen casemix BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

a. Analisis Capaian yang Tidak Diinginkan di Instalasi Gawat Darurat pada Bulan Maret 2024



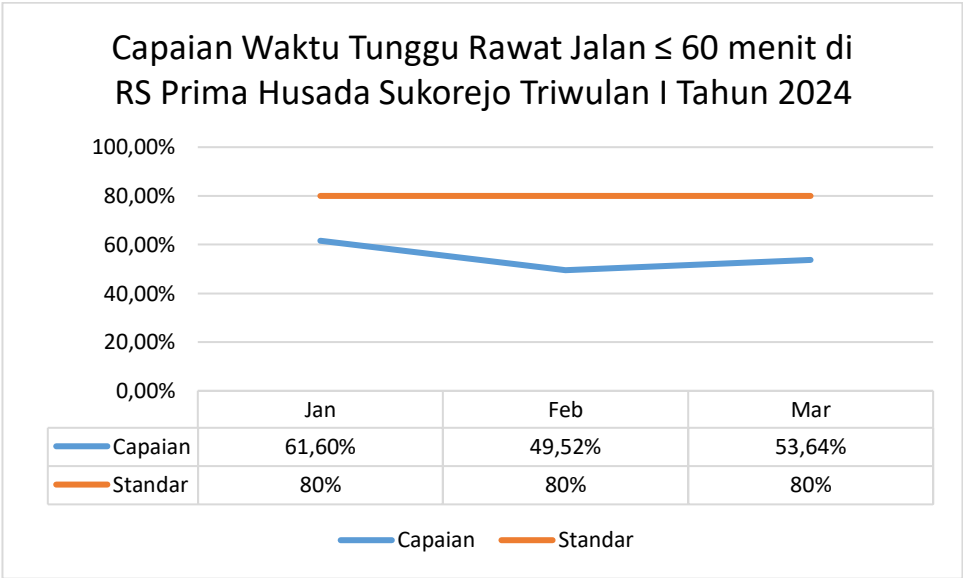
Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan capaian kematian pasien < 24 jam di Instalsai Gawat Darurat belum mencapai target yakni 4/1484 dari standar 2/1000. Dari 1484 pasien yang diobservasi 4 ditemukan meninggal dikarenakan ADHF, KDK DD Epilepsi, Tetanus dan Koma Hipoglikemia + Asidosis Laktat ulkus dekubitus + syok Hipovolemik + Hiponatremia .

Tabel 3.25 PDSA Capaian Kematian Pasien < 24 jam (sebelum 8 jam) pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase kematian pasien < 24 jam adalah 4/1484 lebih dari 2/1000
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kematian pasien di IGD ≤ 24 jam
Plan	1. Rencana: Mengurangi jumlah kematian pasien < 24 jam di ruang IGD dengan melaksanakan peningkatan skill maupun kinerja petugas IGD dan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja oleh kepala ruang.

1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan $\geq$ 30 menit	0%	25,26%	18,95%	12,50%	18,90%	PDSA
2.	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian awal medis RJ	0%	13,85%	0%	0%	4,62%	Dipertahankan
3.	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan RJ	0%	9,23%	0%	0%	3,08%	Dipertahankan
4.	Ketidaklengkapan PRMRJ pasien	0%	100%	100%	100%	100%	PDSA

a. Analisis Capaian yang Tidak Diinginkan di Instalasi Rawat Jalan pada Bulan Maret 2024



Berdasarkan hasil capaian di atas, waktu tunggu rawat jalan mengalami peningkatan pada bulan Maret 2024 yakni 53,64% dibandingkan dengan bulan Februari 2024 yakni 49,52% tetapi capaian yang paling tinggi yaitu pada bulan Januari 61,6%. Adapun rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS Prima Husada Sukorejo sampai bulan Maret Tahun 2024 mencapai 54,92%. Di Bulan Maret 2024, dari 110 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 49 pasien yang harus menunggu lebih dari 60 menit yaitu dengan rata-rata 102 menit (1 jam 42 menit). Berikut merupakan jumlah pasien yang menunggu lebih dari 60 menit sampai dilayani oleh dokter diantaranya sebagai berikut:

Nama Dokter	Jumlah Pasien yang menunggu lebih dari 60 menit	Nama Dokter	Jumlah Pasien yang menunggu lebih dari 60 menit
dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	2	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	1
dr. Andika Widiанти, Sp.K.J	4	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	9
dr. Arianto Prabowo, Sp. OT	3	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	4
dr. Nyoman Indra Bayu, Sp.M	5	dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	8
dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	2	dr. Heriyatmo, Sp. PD	2
dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U	6	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT.	3

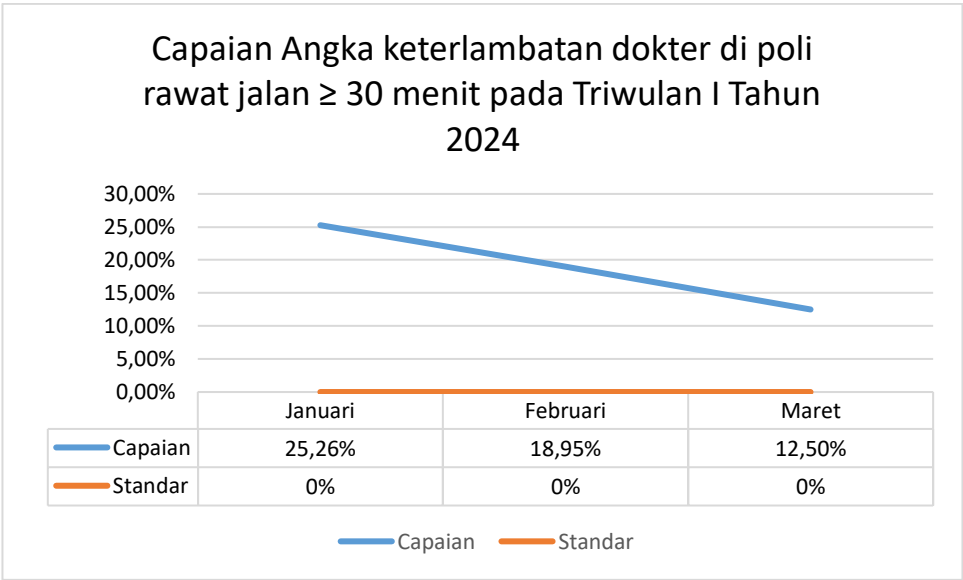
Tabel 3.31 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan $\leq$ 60 menit pada Bulan Maret Tahun 2024

Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan $\leq$ 60 menit Triwulan I Tahun 2024 adalah 54,92%, belum mencapai target 80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan pasien
Plan	Rencana : Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien Harapan :

	Semua pasien mendapatkan pelayanan dokter kurang dari 60 menit Tindakan : c. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien d. Koordinasi dengan CSO, Pendaftaran terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Waktu pasien rawat jalan yang didaftarkan di tempat pendaftaran sampai dilakukan oleh pemeriksaan oleh dokter
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 54,92%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target $\geq 80\%$. Dari 110 pasien yang diobservasi ditemukan 49 pasien yang menunggu lebih dari 60 menit dengan rata-rata 102 menit (1 jam 42 menit). Ini dikarenakan: a) Adanya pasien yang daftar awal sebelum jadwal praktek poli b) Adanya pendaftaran melalui Mobile JKN yang menyebabkan pasien yang daftar secara langsung ke Rumah Sakit yang menyebabkan nomor antriannya mundur. c) Adanya dokter poli yang melakukan kegiatan operasi ketika ada jadwal poli sehingga menimbulkan waktu tunggu yang lama di poli
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian triwulan I yakni 54,92%, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan pasien yang kurang dari 60 menit belum mencapai target $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruang rawat jalan dan kepala bidang pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan pasien 2. Koordinasi dengan CSO dan Pendaftaran terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn yang bias diakses dimana pun.

Tabel 3.32 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi terkait pendaftaran yang bisa diakses melalui mobile jkn	Menurunkan angka capaian waktu tunggu rawat jalan pasien	Seluruh pasien dapat mendapat perawatan dari dokter poli kurang dari 60 menit	Rapat koordinasi dengan kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Komite PMKP, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Ruang Pendaftaran	Satu bulan



Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan capaian Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit di Rawat Jalan pada Bulan Maret Tidak Mencapai 0% yaitu 12,5%. Dari 104 jadwal dokter yang

Tabel 3.35 PDSA Capaian Angka Ketidaklengkapan PRMRJ pasien Rawat Jalan pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Capaian Persentase Angka Ketidaklengkapan PRMRJ pasien rawat jalan pada Triwulan I yaitu 100%, angka capaian ini tidak mencapai standar 0%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Ketidaklengkapan PRMRJ pasien rawat jalan
Plan	1. Rencana: Mengurangi angka Ketidaklengkapan PRMRJ pasien rawat jalan 2. Harapan Ketidaklengkapan PRMRJ pasien rawat jalan dapat tercapai 0% 3. Tindakan Koordinasi dengan Tim IT PT untuk melakukan pengecekan pada aplikasi ERM
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? kemudahan akses dalam pengisian PRMRJ pada ERM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Ketidaklengkapan PRMRJ pasien rawat jalan belum mencapai 0%, dari 85 ERM yang di observasi semua ERM belum terisi lengkap pada PRMRJ setiap pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Ketidaklengkapan PRMRJ pasien rawat jalan disebabkan pada aplikasi ERM ketidakpetugas sudah mengisikan PRMRJ namun tidak tersimpan pada ERM pasien Follow-up dan Rencana Lanjutan Koordinasi dengan kepala ruangan dan IT PT untuk mengecek ERM (PRMRJ)

Tabel 3.36 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruangan dan IT PT untuk mengecek ERM (PRMRJ)	Agar penginputan pada PRMRJ dapat tersimpan	IT PT dapat menyelesaikan kendala ERM agar PRMRJ dapat terinput	Laporan pada grup ERM	Kepala ruangan rawat jalan dan IT PT	1 Bulan

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.37 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	64,35%	78%	80%	74,12%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	66,96%	73%	93,64%	77,87%	PDSA
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	≥ 80%	47,96%	43%	45,45%	45,75%	PDSA
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	-	-	-		
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0,87%	1%	0%	0,94%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	3 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	3 kejadian	PDSA
3.	Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	0%	35,34%	36,00%	14,55%	35,67%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan	100%	38,46%	25%	93,59%	31,73%	PDSA

	SBAR						
5.	Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan tepat waktu (kemenkes, direktur, dinkes)	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rawat Inap 2A pada bulan Maret Tahun 2024 mecapai 80%. dari 110 pasien yang di observasi ditemukan 12 pasien yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar, 6 pasien tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja dan 6 pasien tidak dilakukan identifikasi secara lisan hanya visual saja

sssssTabel 3.39 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di Rawat Inap 2A pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Kepatuhan Identifikasi pasien rawat inap 2A Tidak Mencapai 100%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas rawat inap 2A dalam melakukan identifikasi pasien
Plan	1. Rencana: Meningkatkan perilaku patuh petugas Rawat inap 2A terhadap identifikasi pasien 2. Harapan Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SPO 3. Tindakan a. Koordinasi dengan Ka.ruang mengenai SPO identifikasi pasien b. Refresh SPO identifikasi pasien kepada petugas rawat inap
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kepatuhan petugas rawat inap dalam melakukan identifikasi pasien 2. Kesesuaian cara identifikasi pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian identifikasi pasien di bulan Maret belum mencapai standar 100%, dari 100 staff yang di observasi ditemukan 22 petugas yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien 11 petugas tidak melakukan identifikasi secara lisan dan 11 petugas tidak melakukan identifikasi secara visual saat pemberian pengobatan, prosedur Tindakan dan prosedur diagnostic
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Proses identifikasi pasien di rawat jalan belum sesuai dengan SPO Follow-up dan Rencana Lanjutan Refresh spo identifikasi pasien kepada petugas di rawat jalan

Tabel 3.40 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Refresh spo identifikasi pasien kepada petugas di rawat jalan	Seluruh staff rawat jalan dapat melakukan identifikasi sesuai SPO	Identifikasi pasien rawat jalan dapat dilakukan sesuai SPO	Zoom meeting untuk pemaparan kebijakan	Komite Mutu	1 minggu

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh di IRNA 2A pada bulan Maret tahun 2024 adalah 93,64%. Dari 100 pasien & RM pasien yang di observasi ditemukan 27 pasien & RM yang tidak sesuai intervensi risiko jatuh.

Tabel 3.41 PDSA Capaian Angka Kepatuhan Upaya pencegahan risiko cedera pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan Upaya pencegahan risiko cedera Tidak Mencapai 100%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan Upaya pencegahan risiko cedera
Plan	1. Rencana: Mengurangi angka Kepatuhan Upaya pencegahan risiko cedera 2. Harapan Kepatuhan Upaya pencegahan risiko cedera dapat tercapai 100% 3. Tindakan a. Refresh materi tentang risiko jatuh

	b. Supervisi kepatuhan petugas dalam pencegahan risiko jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Upaya pencegahan risiko jatuh yang dilakukan petugas Intervensi dalam asesmen ulang petugas
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Kepatuhan Upaya pencegahan risiko cedera Tidak Mencapai 100%, dari 100 pasien & RM pasien yang di observasi ditemukan 27 pasien & RM yang tidak sesuai intervensi risiko jatuh. Berikut merupakan rician ketidakpatuhan petugas : 1. Tanda risiko jatuh tidak terpasang 10 pasien 2. Hand rail tidak terpasang 15 pasien 3. Edukasi tidak dilakukan 2 pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Kepatuhan Upaya pencegahan risiko cedera Tidak Mencapai 100% disebabkan masih adanya intervensi risiko jatuh yang tidak dilakukan pada pasien, selain itu terkadang KIE risiko jatuh sudah dilakukan namun pasien lupa / keluarga pasien sering berganti-ganti Follow-up dan Rencana Lanjutan Supervisi kepatuhan petugas dalam pencegahan risiko jatuh

Tabel 3.42 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi kepatuhan petugas dalam pencegahan risiko jatuh	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melakukan intervensi risiko jatuh	Seluruh pasien dapat dilakukan intervensi sesuai kategori risiko jatuh	Observasi langsung dan pengarahan cara yang sesuai	Kepala ruang – komite mutu	1 minggu

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan visite dokter spesialis Pada Bulan Maret Tahun 2024 adalah 43%. Dari 100 pasien yang di observasi sebanyak 29 dokter tidak visite dan 28 dokter lainnya visite jam 16.00 – 20.00.

Tabel 3.43 PDSA Capaian Angka Kepatuhan visite dokter spesialis pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai ≥80%
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai ≥80%
Plan	1. Rencana: Meningkatkan angka Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai ≥80% 2. Harapan Kepatuhan visite dokter spesialis Mencapai target ≥80% 3. Tindakan Koordinasi dengan komite medik & Kepala bidang pelayanan
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kedatangan visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian visite dokter spesialis belum mencapai ≥80% dari 100 pasien yang di observasi sebanyak 29 dokter tidak visite dan 28 dokter lainnya visite jam 16.00 – 20.00.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Tidak tercapaiannya kepatuhan visite dokter spesialis disebabkan oleh masih adanya jam praktik dokter di luar rs / dokter masih operasi Follow-up dan Rencana Lanjutan Reminder dokter oleh komite medik dan kabid pelayanan

Tabel 3.44 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reminder dokter oleh komite medik dan kabid pelayanan	Meningkatkan angka visite dokter	Semua pasien di rawat inap dapat tervisite 1x sehari	Pengaktifan kembali rapat koordinasi komite medik	Komite medik	1 minggu

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Kejadian pulang paksa pasien rawat inap 2A Pada Bulan Maret Tahun 2024 Tidak Mencapai 0 kejadian. Dari 100 pasien yang di observasi ditemukan 2 pasien menyatakan pulang paksa dengan alasan pribadi.

Tabel 3.45 PDSA Capaian Kejadian pulang paksa pasien Rawat Inap 2A pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Kejadian pulang paksa pasien rawat inap 2A Tidak Mencapai 0 kejadian.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan pasien meminta pulang paksa
Plan	1. Rencana: Mengurangi Kejadian pulang paksa pada pasien rawat inap 2A 2. Harapan Kejadian pulang paksa dapat sesuai standar 0 kejadian 3. Tindakan Koordinasi dengan Ka. Tim untuk memaksimalkan KIE kepada pasien untuk mencegah terjadinya pulang paksa
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Jumlah dan penyebab pasien melakukan pulang paksa
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Kejadian pulang paksa belum mencapai 0 kejadian, dari 100 pasien yang di observasi ditemukan 2 pasien menyatakan pulang paksa dengan alasan pribadi
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Proses KIE pada pasien sudah dilakukan dengan maksimal namun pasien tetap ingin KRS sebelum advice KRS diberikan Follow-up dan Rencana Lanjutan Peningatan edukasi pasien APS terkait risiko yang terjadi karena perawatan yang belum paripurna

Tabel 3.46 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan edukasi pasien APS	Mencegah terjadinya APS pada pasien rawat inap 2A	Seluruh pasien IRNA 2A dapat diberikan perawatan sampai selesai	Peningkatan KE mengenai KIE terkait risiko APS	PKRS	1 minggu

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam di Rawat Inap 2A Pada Bulan Maret Tahun 2024 adalah 36%. Dari 100 pengkajian awal medis yang di observasi ditemukan 37 pengkajian awal medis yang tidak di isi lengkap. Tabel 3.47 PDSA Capaian Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam di Rawat Inap 2A pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam Tidak Mencapai 0%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam
Plan	1. Rencana: Mengurangi angka Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam 2. Harapan Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam dapat tercapai 0% 3. Tindakan Mengingatkan kepada perawat asisten bahwa sebelum dokter selesai visite semua berkas pasien harus dilengkapi
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kelengkapan pengkajian awal medis rawat inap ≤ 24 jam
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam belum mencapai 0%, dari 100 pengkajian awal medis yang di observasi ditemukan 37 pengkajian awal medis yang tidak di isi lengkap pada bagian di bawah ini : 1. Riwayat Alergi 3 Rekam Medis

	2. Riwayat penggunaan obat 6 Rekam Medis 3. Vital sign 19 Rekam Medis 4. Status Fisik 10 Rekam Medis 5. Edukasi pada lembar KIE 11 Rekam Medis 6. TTD pasien 15 Rekam Medis 7. TTD dokter 17 Rekam Medis
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP $\geq$ 24jam disebabkan oleh masih banyaknya kolom pada pengkajian awal medis yang belum terisi lengkap Follow-up dan Rencana Lanjutan Mengingatkan kepada perawat asisten bahwa sebelum dokter selesai visite semua berkas pasien harus dilengkapi

Tabel 3.48 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Mengingatkan dokter melalui perawat asistennya Ketika di rawat inap	Dokter dapat patuh dalam pengisian asesmen awal medis	Semua pengkajian awal medis pasien dapat terisi < 24 jam	Koordinasi bersama kepala ruang untuk meningkatkan budaya mengingatkan dokter	Kepala ruangan komite mutu	1 minggu

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di Rawat Inap 2A pada Bulan Maret Tahun 2024 adalah 25%. Dari 4 pasien yang diobservasi ditemukan 1 Form SBAR yang tidak terisi secara lengkap yakni di bagian tanda tangan dokter.

Tabel 3.49 PDSA Capaian Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di Rawat Inap 2A pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR Tidak Mencapai 100%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Rencana: Meningkatkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR 2. Harapan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR dapat tercapai 100% 3. Tindakan Peningkatan supervisi Sbar oleh PKRS
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pengisian SBAR oleh petugas rawat inap 2A
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar 100% dari 4 form yang di observasi ditemukan 1 SBAR yang tidak terisi lengkap pada : 1. Tidak terisi untuk bagian tanda tangan dokter
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar disebabkan oleh masih banyaknya SBAR yang tidak terisi lengkap Follow-up dan Rencana Lanjutan Supervise kepatuhan dan peneguran staff secara langsung

Tabel 3.50 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervise kepatuhan dan peneguran staff secara langsung	Agar kepatuhan PPA dalam mengisi SBAR dapat	Kelengkapan SBAR dapat terisi 100%	Supervise dan peneguran secara langsung	PKRS	1 minggu

		meningkat				
--	--	-----------	--	--	--	--

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.51 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		PDSA
4	Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 – 14.00)	≥ 80%	65,71%	56,14%	81,51%	67,87%	PDSA
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	-	-	-		PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0%	2,54%	4,2%	%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	5 kejadian	3 kejadian	7 kejadian	kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	100%	100,00%	73,33%	70,27%	%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan waktu visit dokter pada Bulan Maret di Rawat Inap 2B adalah 59,79%. Dari 97 pasien yang diobservasi ditemukan sebanyak 39 dokter tidak visite kepada pasien BPJS dengan waktu dokter visite jam 15.30 – 20.00.

Tabel 3.53 PDSA Capaian Angka Kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan waktu visite dokter spesialis Tidak Mencapai ≥80%
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai ≥80%
Plan	1. Rencana: Meningkatkan angka Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai ≥80% 2. Harapan Kepatuhan visite dokter spesialis Mencapai target ≥80% 3. Tindakan Koordinasi dengan komite medik & Kepala bidang pelayanan
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kedatangan visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian visite dokter spesialis belum mencapai ≥80% dari 97 pasien yang di observasi sebanyak 39 dokter tidak visite kepada pasien BPJS dengan waktu dokter visite jam 15.30 – 20.00.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Tidak tercapaiannya kepatuhan visite dokter spesialis disebabkan oleh masih adanya jam praktik dokter di luar rs / dokter masih operasi Follow-up dan Rencana Lanjutan Reminder dokter oleh komite medik dan kapid pelayanan

Tabel 3.54 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reminder dokter oleh komite	Meningkatkan angka visite	Semua pasien di rawat inap	Pengaktifan kembali rapat	Komite medik	1 minggu

	medik dan kabisid pelayanan	dokter	dapat tervisite 1x sehari	koordinasi komite medik		
--	-----------------------------	--------	---------------------------	-------------------------	--	--

Tabel 3.54 PDSA Capaian Kejadian pulang paksa pasien Rawat Inap 2B pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Kejadian pulang paksa pasien rawat inap 2B Tidak Mencapai 0 kejadian.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan pasien meminta pulang paksa
Plan	1. Rencana: Mengurangi Kejadian pulang paksa pada pasien rawat inap 2B 2. Harapan Kejadian pulang paksa dapat sesuai standar 0 kejadian 3. Tindakan Koordinasi dengan Ka. Tim untuk memaksimalkan KIE kepada pasien untuk mencegah terjadinya pulang paksa
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Jumlah dan penyebab pasien melakukan pulang paksa
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Kejadian pulang paksa belum mencapai 0 kejadian, dari 70 pasien yang di observasi ditemukan 3 pasien menyatakan pulang paksa dengan: 1 pasien BPJS menolak rujuk 1 pasien BPJS menolak di infus 1 pasien umum tidak ada yang menunggu
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Proses KIE pada pasien sudah dilakukan dengan maksimal namun pasien tetap ingin KRS sebelum advice KRS diberikan Follow-up dan Rencana Lanjutan Peningatan edukasi pasien APS terkait risiko yang terjadi karena perawatan yang belum paripurna

Tabel 3.55 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan edukasi pasien APS	Mencegah terjadinya APS pada pasien rawat inap 2B	Seluruh pasien IRNA 2B dapat diberikan perawatan sampai selesai	Peningkatan KE mengenai KIE terkait risiko APS	PKRS	1 minggu

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		PDSA
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	≥ 80%	64,52%	66,21%	87,74%	72,82%	PDSA
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	-	-	-		PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	8 Kejadian	5 kejadian	1 kejadian	5 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	100%	90,13%	93,79%	98,71%		PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi	100%	15,33%	23,45%	0%		PDSA

	efektif menggunakan SBAR						
5.	Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan tepat waktu (kemenkes, direktur, dinkes)	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

Tabel 3.58 PDSA Capaian Angka Kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan waktu visite dokter spesialis Tidak Mencapai $\geq 80\%$ yakni 66,2%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai $\geq 80\%$
Plan	1. Rencana: Meningkatkan angka Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai $\geq 80\%$ 2. Harapan Kepatuhan visite dokter spesialis Mencapai target $\geq 80\%$ 3. Tindakan Koordinasi dengan komite medik & Kepala bidang pelayanan
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kedatangan visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian visite dokter spesialis yang belum mencapai $\geq 80\%$ dari 145 pasien yang di observasi sebanyak 49 dokter visite kepada pasien BPJS dengan waktu visite jam 16.00 – 19.30.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Tidak tercapaiannya kepatuhan visite dokter spesialis disebabkan oleh masih adanya jam praktik dokter di luar rs / dokter masih operasi Follow-up dan Rencana Lanjutan Reminder dokter oleh komite medik dan kapid pelayanan

Tabel 3.59 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reminder dokter oleh komite medik dan kapid pelayanan	Meningkatkan angka visite dokter	Semua pasien di rawat inap dapat tervisite 1x sehari	Pengaktifan kembali rapat koordinasi komite medik	Komite medik	1 minggu

Tabel 3.60 PDSA Capaian Kejadian pulang paksa pasien Rawat Inap 3A pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Kejadian pulang paksa pasien rawat inap 3A Tidak Mencapai 0 kejadian.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan pasien meminta pulang paksa
Plan	1. Rencana: Mengurangi Kejadian pulang paksa pada pasien rawat inap 3A 2. Harapan Kejadian pulang paksa dapat sesuai standar 0 kejadian 3. Tindakan Koordinasi dengan Ka. Tim untuk memaksimalkan KIE kepada pasien untuk mencegah terjadinya pulang paksa
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Jumlah dan penyebab pasien melakukan pulang paksa
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Kejadian pulang paksa belum mencapai 0 kejadian, dari 145 pasien yang di observasi ditemukan 6 pasien menyatakan pulang paksa dengan: 1. 2 pasien asuransi reliabilitas merasa membaik 2. 1 pasien Umum merasa membaik 3. 1 pasien Umum VIP kurang puas dengan pelayanan di RS 4. 1 pasien Umum VIP kendala biaya
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Proses KIE pada pasien sudah dilakukan dengan maksimal namun pasien tetap ingin KRS sebelum advice KRS diberikan Follow-up dan Rencana Lanjutan

	Peningkatan edukasi pasien APS terkait risiko yang terjadi karena perawatan yang belum paripurna
--	--

Tabel 3.61. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan edukasi pasien APS	Mencegah terjadinya APS pada pasien rawat inap 3A	Seluruh pasien IRNA 3A dapat diberikan perawatan sampai selesai	Peningkatan KE mengenai KIE terkait risiko APS	PKRS	1 minggu

Tabel 3.62 PDSA Capaian Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam di Rawat Inap 3A pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam Tidak Mencapai 0%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam
Plan	3. Rencana: Mengurangi angka Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam 4. Harapan Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam dapat tercapai 0% 5. Tindakan Meningatkan kepada perawat asisten bahwa sebelum dokter selesai visite semua berkas pasien harus dilengkapi
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kelengkapan pengkajian awal medis rawat inap ≤ 24 jam
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam belum mencapai 0%, dari 145 pengkajian awal medis yang di observasi ditemukan 15 pengkajian awal medis yang tidak di isi lengkap pada bagian di bawah ini : 1. Riwayat Alergi (13 RM) 2. Riwayat Kesehatan (11 RM) 3. Alloanamnesis (13 RM) 4. Riwayat penggunaan obat(13 RM) 5. Vital sign (13 RM) 6. Status Fisik (11 RM) 7. Edukasi pada lembar KIE (13 RM) 8. TTD pasien (14 RM) 9. TTD dokter (13 RM)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam disebabkan oleh masih banyaknya kolom pada pengkajian awal medis yang belum terisi lengkap Follow-up dan Rencana Lanjutan Mengingatkan kepada perawat asisten bahwa sebelum dokter selesai visite semua berkas pasien harus dilengkapi

Tabel 3.63 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Mengingatkan dokter melalui perawat asistennya Ketika di rawat inap	Dokter dapat patuh dalam pengisian asesmen awal medis	Semua pengkajian awal medis pasien dapat terisi < 24 jam	Koordinasi bersama kepala ruang untuk meningkatkan budaya mengingatkan dokter	Kepala ruangan komite mutu	1 minggu

Tabel 3.64 PDSA Capaian Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di Rawat Inap 3A pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR Tidak Mencapai 100%.
---------	--

Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Rencana: Meningkatkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR 2. Harapan: Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR dapat tercapai 100% 3. Tindakan Peningkatan supervisi Sbar oleh pkrs
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pengisian SBAR oleh petugas rawat inap 3A
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar 100% dari 145 form yang di observasi ditemukan 33 SBAR yang tidak terisi lengkap pada bagian recommendation
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum encapai standar disebabkan oleh masih banyaknya SBAR yang tidak terisi lengkap Follow-up dan Rencana Lanjutan Supervise kepatuhan dan peneguran staff secara langsung

Tabel 3.65 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi kepatuhan dan peneguran staff secara langsung	Agar kepatuhan PPA dalam mengisi SBAR dapat meningkat	Kelengkapan SBAR dapat terisi 100%	Supervise dan peneguran secara langsung	pkrs	1 minggu

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	99,32%	100%	99,31%		Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		PDSA
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	≥ 80%	68,75%	70,34%	67,74%		
5	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	-	-	-		
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0,65%	0%	1,29%		Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	2 Kejadian	1 kejadian	2 kejadian		PDSA
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam	100%	40,41%	77,94%	73,43%		PDSA
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	78,08%	88,24%	100%		PDSA
5.	Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan tepat waktu (kemenkes, direktur, dinkes)	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

Tabel 3.68 PDSA Capaian Angka Kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan waktu visite dokter spesialis Tidak Mencapai $\geq 80\%$ yakni 64.52%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai $\geq 80\%$
Plan	1. Rencana: Meningkatkan angka Kepatuhan visite dokter spesialis Tidak Mencapai $\geq 80\%$ 2. Harapan Kepatuhan visite dokter spesialis Mencapai target $\geq 80\%$ 3. Tindakan Koordinasi dengan komite medik & Kepala bidang pelayanan
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kedatangan visite dokter kepada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian visite dokter spesialis yang belum mencapai $\geq 80\%$ dari 44 pasien yang di observasi sebanyak 30 dokter visite kepada pasien BPJS dengan waktu visite jam 16.00 – 19.30 dan 10 dokter tidak visite
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Tidak tercapaianya kepatuhan visite dokter spesialis disebabkan oleh masih adanya jam praktik dokter di luar rs / dokter masih operasi Follow-up dan Rencana Lanjutan Reminder dokter oleh komite medik dan kapid pelayanan

Tabel 3.69 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reminder dokter oleh komite medik dan kapid pelayanan	Meningkatkan angka visite dokter	Semua pasien di rawat inap dapat tervisite 1x sehari	Pengaktifan kembali rapat koordinasi komite medik	Komite medik	1 minggu

Tabel 3.70 PDSA Capaian Kematian Pasien > 48 jam di Rawat Inap 3B pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Kematian Pasien di rawat inap 3B tidak mencapai $< 0.24\%$
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan kematian pasien > 48 jam
Plan	1. Rencana: Mengurangi kematian pasien > 48 jam di Rawat Inap 3B 2. Harapan: Angka kematian pasien di IRNA 3B dapat sesuai standar $< 0.24\%$ 3. Tindakan a Evaluasi kinerja petugas IRNA 3B oleh Kepala Ruang b Pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai dengan SPO c Bekerja sama dengan spesialis emergency untuk penanganan lebih lanjut
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kematian pasien > 48 jam di Rawat Inap 3B 2. Kinerja petugas dalam menangani pasien di IRNA 3B
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil dari capaian kematian pasien > 48 jam yakni 0.64% dan belum mencapai target $< 0.24\%$ disebabkan oleh pasien di rawat inap 3B mengalami perburukan kondisi
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Hasil capaian indikator untuk Bulan Maret Tahun 2024 diperoleh capaian belum sesuai target yang ditentukan Follow-Up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya

Tabel 3.71 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan softskills dan hardskills petugas IRNA 3B	Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada	Tercapainya pengurangan angka Kematian Pasien Di IRNA 3B	Peningkatan pengetahuan melalui seminar maupun pembahasan	Ka.ruang IRNA 3B Kapid medis	Satu bulan

		pasien yang dalam kondisi buruk		studi kasus bersama		
--	--	---------------------------------	--	---------------------	--	--

Tabel 3.72 PDSA Capaian Kejadian pulang paksa pasien Rawat Inap 3B pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Kejadian pulang paksa pasien rawat inap 3B Tidak Mencapai 0 kejadian.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan pasien meminta pulang paksa
Plan	1. Rencana: Mengurangi Kejadian pulang paksa pada pasien rawat inap 3B 2. Harapan: Kejadian pulang paksa dapat sesuai standar 0 kejadian 3. Tindakan: Koordinasi dengan Ka. Tim untuk memaksimalkan KIE kepada pasien untuk mencegah terjadinya pulang paksa
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Jumlah dan penyebab pasien melakukan pulang paksa
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Kejadian pulang paksa belum mencapai 0 kejadian, dari 155 pasien yang di observasi ditemukan 2 pasien menyatakan pulang paksa dengan: 1. 1 pasien BPJS karena alasan pribadi 2. 1 pasien umum karena alasan biaya
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Proses KIE pada pasien sudah dilakukan dengan maksimal namun pasien tetap ingin KRS sebelum advice KRS diberikan Follow-up dan Rencana Lanjutan Peningkatan edukasi pasien APS terkait risiko yang terjadi karena perawatan yang belum paripurna

Tabel 3.73 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningatan edukasi pasien APS	Mencegah terjadinya APS pada pasien rawat inap 3B	Seluruh pasien IRNA 3B dapat diberikan perawatan sampai selesai	Peningkatan KE mengenai KIE terkait risiko APS	PKRS	1 minggu

Tabel 3.74 PDSA Capaian Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 jam di Rawat Inap 3B pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam Tidak Mencapai 0%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam
Plan	1. Rencana: Mengurangi angka Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam 2. Harapan Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam dapat tercapai 0% 3. Tindakan Meningatkan kepada perawat asisten bahwa sebelum dokter selesai visite semua berkas pasien harus dilengkapi
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kelengkapan pengkajian awal medis rawat inap ≤ 24 jam
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24jam belum mencapai 0%, dari 152 pengkajian awal medis yang di observasi ditemukan 87 pengkajian awal medis yang tidak di isi lengkap pada bagian di bawah ini : 1. Riwayat Alergi (40 RM) 2. Riwayat Kesehatan (31 RM) 3. Alloanamnesis (34 RM)

	4. Riwayat penggunaan obat (35 RM) 5. Vital sign (27 RM) 6. Status Fisik (29 RM) 7. Edukasi pada lembar KIE (58 RM) 8. TTD pasien (83 RM) 9. TTD dokter (28 RM)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP $\geq$ 24jam disebabkan oleh masih banyaknya kolom pada pengkajian awal medis yang belum terisi lengkap Follow-up dan Rencana Lanjutan Mengingatkan kepada perawat asisten bahwa sebelum dokter selesai visite semua berkas pasien harus dilengkapi

Tabel 3.75 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Mengingatkan dokter melalui perawat asistennya Ketika di rawat inap	Dokter dapat patuh dalam pengisian asesmen awal medis	Semua pengkajian awal medis pasien dapat terisi < 24 jam	Koordinasi bersama kepala ruang untuk meningkatkan budaya mengingatkan dokter	Kepala ruangan komite mutu	1 minggu

Tabel 3.76 PDSA Capaian Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR di Rawat Inap 3B pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR Tidak Mencapai 100%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Rencana: Meningkatkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR 2. Harapan: Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR dapat tercapai 100% 3. Tindakan Peningkatan supervisi Sbar oleh pkr
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pengisian SBAR oleh petugas rawat inap 3B
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil rata-rata capaian Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar 100% dari 32 form yang di observasi ditemukan 5 SBAR yang tidak terisi lengkap pada : 1. Tidak terisi untuk bagian recommendation 2. Tidak ada stemple dr Jaga 3. Tidak ada TTD dr Jaga 4. Tidak ada jam 5. Tidak ada tanggal konsul
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar disebabkan oleh masih banyaknya SBAR yang tidak terisi lengkap Follow-up dan Rencana Lanjutan Supervise kepatuhan dan peneguran staff secara langsung

Tabel 3.77 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi kepatuhan dan peneguran staff secara langsung	Agar kepatuhan PPA dalam mengisi SBAR dapat meningkat	Kelengkapan SBAR dapat terisi 100%	Supervise dan peneguran secara langsung	pkr	1 minggu

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.78 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	96,59%	100%	100%	98,86%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	≤ 5%	2,26%	0%	0%	0.75%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kejadian kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3.	Kejadian operasi salah pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Kejadian salah tindakan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6.	Ketidaklengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7.	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8.	Angka ketidaklengkapan informconsent	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
9.	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengisian <i>surgical safety checklist</i> sesuai standar	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
11	Angka ketidaklengkapan laporan operasi	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.79 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Bulan Maret Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
.	Ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0%	0	0	0	0	Dipertahankan
3.	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan
4.	Kejadian efek samping selama sedasi moderat	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan
5.	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan
6.	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0	0	0	0	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Keterangan
			Jan	Feb	Mar	

1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	95,86%	96,13%	PDSA
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	95,48%	94,48%	98,06%	PDSA
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-	PDSA
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	≥ 80%	88,32%	88,52%	91,04%	Dipertahankan
5	Waktu tanggap SC Cito	≥ 80%	92,86%	100%	93,33%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥ 80%	-	-	60%	PDSA
1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	Perdarahan 0% Pre-eklampsia 0% Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia 0% Sepsis ≤ 0%	Perdarahan 0% Pre-eklampsia 0% Sepsis ≤ 0%	dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	dipertahankan
3.	Kepatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 Jam	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	97,83%	100%	100%	dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.81 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh tim ponek yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤	Perdarahan 0% Pre-eklampsia %	Perdarahan 0% Pre-eklampsia %	Perdarahan 0% Pre-eklampsia %	Perdarahan 0% Pre-eklampsia %	dipertahankan

		30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	Sepsis ≤ 0%	Sepsis ≤ 0%	Sepsis ≤ 0%	Sepsis ≤ 0%	
3.	Tidak terbinanya jejaring PONEK (tiap triwulan 1x)	0%	Kegiatan Bersama IBI	Kegiatan Bersama IBI	Kegiatan Bersama IBI	Kegiatan Bersama IBI	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.82 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-	-	Dipertahankan
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Ketidakpatuhan pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≥ 24 Jam	0%	8,40%	0%	0%	8,40%	Dipertahankan
3.	Kepuasan pelanggan	≥80%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	0 kejadian	1 kejadian	3 Kejadian	2 kejadian	2 kejadian	PDSA
5.	Ketidakpatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	0%	0%	0%	0%	0%	dipertahankan

Tabel 3.83 PDSA Capaian Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata capaian kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir belum mencapai target 0 kejadian.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir
Plan	1. Rencana: Mengurangi kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir 2. Harapan: Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir mencapai 0 kejadian 3. Tindakan: Meningatkan kepada petugas untuk KIE ibu untuk IMD setelah proses persalinan.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Monitoring ibu setelah proses persalinan
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil capaian kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir pada bulan Maret 2024 dari 66 ibu yang diobservasi ditemukan 3 ibu yang tidak melakukan IMD dikarenakan 2 bayi kondisi buruk dan 1 bayi sesak nafas.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi dikarenakan 2 bayi mengalami kondisi buruk dan 1 bayi sesak nafas. Follow-up dan Rencana Lanjutan Meningkatkan skill petugas di Neonatologi untuk bayi yang mengalami perburukan kondisi, agar IMD pada bayi baru lahir dapat dilakukan.

Tabel 3.84 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan skill petugas di	Meningkatkan skill petugas di	Skill petugas dapat terasah	Koordinasi bersama	Kepala ruangan	1 bulan

	Neonatologi untuk bayi yang mengalami perburukan kondisi	Neonatologi untuk bayi yang mengalami perburukan kondisi	ketika bayi mengalami perburukan kondisi dan IMD pada bayi dapat terlaksanakan	kepala ruang dan komite medik		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

11. ICU

Tabel 3.85 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-		
4	Kepatuhan waktu visite dokter (07.00 – 14.00)	≥ 80%	71,43%	100%	90,63%		dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0%	0%	0%	0%	dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian dokumen kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3.	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

12. RADIOLOGI

Tabel 3.86 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-				PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	< 3%		0 %	0%	0 %	Dipertahankan
2.	Kejadian keluhan DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0 kejadian		0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3.	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %		100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Angka ketidaklengkapan formulir permintaan radiologi	0%		0 %	0 %	0 %	Dipertahankan
5.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian		0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

13. LABORATORIUM

Tabel 3.87 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,91%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Pelaporan nilai kritis ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%	-	-	-	-	
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Waktu tunggu hasil	100%	97,62%	99,2%	97,62%	97,62%	PDSA

	elayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin						
2.	Kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Angka Kerusakan Sampel Darah	0%	0,83%	0,52%	0,83%	0,83%	PDSA
4.	Angka ketidaklengkapan formulir permintaan ke laboratorium	0%	5,44%	5,46%	5,44%	5,44%	PDSA
5.	Kejadian kesalahan pemindahan hasil laboratorium ke SIMRS	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6.	Kejadian Ketidaktepatan waktu pemeliharaan alat KSO laboratorium oleh teknisi dari vendor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian Keterlambatan Backup alat error dalam waktu 1x24 jam.	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8.	Kejadian keterlambatan hasil laboratorium cito ≥ 30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
BDRS							
7.	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8.	Reaksi tranfusi darah	< 0,01%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
9.	Kejadian keterlambatan penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10.	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

Tabel 3.89 PDSA Capaian Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata capaian waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin belum mencapai standar 100%
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium belum mencapai standar
Plan	1. Rencana: Menambah capaian waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin 2. Harapan: Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin mencapai standar 100% 3. Tindakan: Koordinasi dengan seluruh tim di unit terkait pelayanan di laboratorium
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Monitoring waktu tanggap petugas dalam pembuatan hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil capaian waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin pada bulan Maret 2024 belum mencapai target 100%. Dari 4620 pasien yang diobservasi 4510 (97.62%) pasien yang terlayani dengan waktu kurang 2 jam dimana sisanya belum tepat waktu dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Masih ditemukan pasien yang belum terlayani lebih dari 2 jam dalam pengambilan hasil kimia darah & darah rutin pada bulan Maret 2024 Follow-up dan Rencana Lanjutan Koordinasi antar tim di unit kerja

Tabel 3.90 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi antar tim di unit kerja	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	Semua pasien yang datang di untuk mengambil hasil lab dapat dilayani ≤ 120 menit	Peningkatan Kerjasama antar tim	Ka. Ruang Laboratorium	2 Minggu

Tabel 3.91 PDSA Capaian Angka Kerusakan Sampel Darah pada Triwulan 1 Tahun 2024

Problem	Rata-Rata capaian angka kerusakan sampel darah belum mencapai standar 0%
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan kerusakan sampel darah belum mencapai standar
Plan	1. Rencana: Mengurangi angka hasil kerusakan sampel darah 2. Harapan: Angka kerusakan sampel darah mencapai 0% 3. Tindakan: a. Evaluasi kinerja petugas oleh kepala ruang b. Merefresh petugas terkait SPO pengambilan sampel darah c. Koordinasi dengan seluruh tim di unit terkait pelayanan di laboratorium
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Pengambilan sampel darah sesuai dengan SPO yang berlaku 2. Monitoring sampel darah yang diambil oleh petugas
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan hasil capaian angka kerusakan sampel darah pada bulan Maret 2024 belum mencapai target 0%. Dari 2041 pasien yang diobservasi ada 17 pasien yang mengalami kerusakan sampel darah ini dikarenakan faktor berikut ini: 1. Pengambilan Darah yang tidak sesuai takaran (tidak sesuai SPO) 2. Sampel darah yang mengalami clotting
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Masih ditemukannya kerusakan sampel darah dikarenakan pengambilan darah yang dilakukan oleh petugas tidak sesuai takaran dan adanya sampel darah yang mengalami clotting Follow-up dan Rencana Lanjutan Merefresh petugas terkait SPO pengambilan sampel darah, Koordinasi antar tim di unit kerja

Tabel 3.92 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Merefresh petugas terkait SPO pengambilan sampel darah	SPO pengambilan darah dapat diterapkan oleh petugas lab	Petugas Laboratorium	Sosialisasi SPO terkait pengambilan sampel darah	Ka.ruang Laboratorium Kabid keperawatan	Satu bulan
2	Koordinasi antar tim di unit kerja	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	Semua pasien yang datang di untuk mengambil hasil lab dapat dilayani ≤ 120 menit	Peningkatan Kerjasama antar tim	Ka. Ruang Laboratorium	2 Minggu

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%			100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien	100%			100%	100%	Dipertahankan

	jatuh						
3	Kepuasan pasien	≥ 80%			88%	88%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kejadian kesalahan tindakan fisioterapi	0 kejadian			0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Ketidaklengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	0%			0%	0%	Dipertahankan
3.	Ketidaklengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	0%			0%	0%	Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.94 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan terhadap formularium nasional	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kepuasan pasien	≥ 80%		-	-	-	PDSA
Indikator Mutu Prioritas-Unit							
1.	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	0 Kejadian		21 kejadian	15 kejadian	12 kejadian	PDSA
2.	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 Kejadian		33 Kejadian	11 kejadian	15 kejadian	PDSA
3.	Kejadian perubahan pemberian antibiotik profilaksis menjadi teraupetik	0 kejadian		0 Kejadian	5 kejadian	2 kejadian	PDSA

16. GIZI

Tabel 3.95 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	Triwulan1	Triwulan1	Triwulan1	Triwulan1	Dipertahankan
3.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka ketidaklengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
5.	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.96 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	93,75%	94,68%	82,76%	94,22%	PDSA
2.	Kelengkapan informed concent tindakan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kelengkapan general concent	100%	100%	100%		100%	Dipertahankan
4.	Kejadian nomor rekam medis ganda	0	4 kejadian	5 kejadian	1 kejadian	4 kejadian	PDSA
5.	Kejadian SEP tidak	0	0 kejadian	0 kejadian	0	0 kejadian	Dipertahankan

	diterbitkan				kejadian		
6.	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl,)	0%	62,50%	93,42%		77,96%	PDSA
7.	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	0%	94,74%	14,84%		54,79%	PDSA

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.97 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Baku mutu limbah cair	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD 11, 51 mg/l b. COD 33, 30 mg/l c. TSS 5.1 mg/l d. PH 7.5	.a. BOD 14,09 mg/l b. COD 40,62 mg/l c. TSS 13,7 mg/l d. PH 7.6	a. BOD 12,8 mg/l b. COD 36,96 mg/l c. TSS 5.1 mg/l d. PH 7.5	a. BOD 12,8 mg/l b. COD 36,96 mg/l c. TSS 5.1 mg/l d. PH 7.5	Dipertahankan
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Angka ketidakpatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan

19. SDM

Tabel 3.98 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	100 %					Belum mengisi
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %					1 Tahun
3.	Angka turn over staf	≤10% / bulan	0,13%	0,46%	0,92%	0,13%	Dipertahankan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadian	0 kejadian	31 Kejadian	15 kejadian	15 kejadian	PDSA
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	0%	1,22%	2,68%		1,95%	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD: BLS/PPGD/GELS/ALS b. PONEK: PPGD c. ICU d. HD e. IKO	100%	1,31%	33,5%		17,41%	PDSA
7.	Kepuasan karyawan	≥ 80 %					Triwulan 1
8.	Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.99 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %	87,50%	100%	100 %	95,83%	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan	100%	92,59%	75%	100%	89,19%	Dipertahankan
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	100%	100%	97,96%	100%	99,32%	Dipertahankan

4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	98,89%	100%	99,63%	Dipertahankan
----	--	------	------	--------	------	--------	---------------

21. DRIVER

Tabel 3.100 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Angka ketersediaan ambulance sesuai kebutuhan ≤30 menit	100%					Belum mengisi
2.	Kepuasan pengguna ambulance	≥80%					Belum mengisi
3.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulace	100%					Belum mengisi
4.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%					Belum mengisi

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.101 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Triwulan 1 Tahun2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.102 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
		ATEM					
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	≤ 80%		100%	83,78%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	100%		86,84%	100%	93,42%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
IPSRS							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non medis ≤ 15 menit	100%		8,7%	10,10%	9,4%	PDSA
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset < 10 detik	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan

24. LAUNDRY

Tabel 3.103 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kejadian linen hilang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 1x24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kejadian terdapat benda asing di linen	0 kejadian	0 kejadian	7 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	PDSA
4.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.104 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kejadian kehilangan set instrumen	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai standar	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

3.	Waktu tunggu pelayanan sterilisasi steam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5.	Persentase set instrumen yang sudah dibersihkan dan tepat waktu dari unit yang dikembalikan ke CSSD	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6.	Persentase hasil biological test negative pada BMHP reuse	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7.	Terpasangnya label ED pada instrumen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.105 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤ 2/3 tempat sampah	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 2x dalam sehari	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan

27. KEAMANAN

Tabel 3.106 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	0 kejadian	5 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai ketentuan	100%					Belum mengisi terkendala dengan pasien yang keluar masuk

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.107 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	100%	97,44%	56,63%	40,58%	64,88%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	1,03%	0,55%	0%	0,79%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
4.	Kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.108 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %					Belum mengisi
2.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60 %		97,46%	100%	98,73%	Dipertahankan
3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75 %		54,19%	88,02%	71,1%	PDSA
4.	Kepatuhan HH	≥ 85%	75,36%	73,57%	73,20%	74,46%	PDSA
5.	Kepatuhan APD	≥ 80%	91,78%	95,56%	93,68%	93,67%	Dipertahankan
6.	Angka infeksi daerah operasi	0%		0%	0,53%	0%	PDSA
7.	Angka kejadian VAP pada pasien ICU	0%		0%	0%	0%	Dipertahankan
8.	Angka kejadian infeksi pada pemasangan CVC pada pasien ICU	0%		0%	0%	0%	Dipertahankan
9.	Angka phlebitis	≤ 1,5%		10,19%	0,72%	5,45%	PDSA
10.	Kepatuhan penempatan pasien infeksius	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan

30. PKRS

Tabel 3.109 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Angka ketidakpatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok	0%			86,61%	86,61%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR	100%			50%	50%	PDSA
3.	Kepatuhan pelaksanaan edukasi terintegrasi & kolaborasi	100%		100%	100%	100%	Dipertahankan

31. VERIFIKATOR

Tabel 3.110 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Verifikator pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kesesuaian coding diagnosis dan tindakan sesuai dengan INA-CBGS	100%	99,77%	99,94%	99,99%	99,90%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas terhadap penyetoran rekam medis BPJS Kesehatan ≤ 24jam	100%	91,67%	90,72%	91,13%	91,17%	PDSA
3.	Kepatuhan DPJP dalam mengisi resume medis	100%	91,78%	95,17%	93,55%	93,5%	PDSA
4.	Ketidaklengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	0%	9,03%	2,07%	1,29%	4,13%	PDSA

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.111 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	35,26%	-	-	35,26%	PDSA
2.	Ketidakpatuhan update dokumen	0%	0%	-	0%	0%	Dipertahankan

	kerjasama dengan instansi eksternal						
3.	Kenaikan jumlah pasien baru	10% / bulan	58,33%	-	20,28	26,2%	Dipertahankan

33. CSO

Tabel 3.112 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Resptime CSO <30 mnt (WA)	100%					Belum mengisi
2.	kepatuhan petugas dalam mengumpulkan kuesioner complain dan kepuasan pelanggan (kunjungan ke IRNA)	100%					Belum mengisi

34. MOD-MPP

Tabel 3.113 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Keterangan
			Jan	Feb	Mar	
1	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	82,26%	75,61%	-	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Angka ketidaklengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	0%			0%	Dipertahankan
4	Angka ketidaklengkapan form Dischard planning	0%			0%	Dipertahankan

35. TB di IRJA

Tabel 3.114 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB di IRJA pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1	Ketidakpatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	0%					Belum mengisi
2	Kejadian tidak terpantaunya pasien TB oleh PIC TB	0 kejadian					Belum mengisi

36. ASURANSI CENTER

Tabel 3.115 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1	Ketepatan Maturitas klaim BPJS	100%					Belum mengisi

37. KEUANGAN

Tabel 3.116 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10menit	<5%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Ketepatan waktu pembayaran kepada pihak rekanan	100%					Tidak bias diukur karena yang menangani Keuangan PT
5	Jumlah piutang ≥1m / bulan	0%	1%	0.3%		0%	PDSA

38. TIM HIV

Tabel 3.117 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1	Kejadian tidak teridentifikasi pasien HIV pada pasien bedah	0 Kejadian		0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian pasien drop out pengobatan HIV	0 kejadian		0 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

39. KB

Tabel 3.118 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Ketidakpatuhan pengisian kartu K4 KB	0%		0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca Keguguran	50%		22%	14,79%	18,4%	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	100%					Belum mengisi
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	30%		100%	100%	100%	Dipertahankan

40. STUNTING

Tabel 3.119 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	100%	0%	100%	0%	33,33%	PDSA
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	0%	0%	0%	0%	PDSA

41. IT - SIM RS

Tabel 3.120 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Triwulan 1 Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Bulan			Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar		
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan 1 minggu sekali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	83,33%	74.67%	87,5%	85%	PDSA
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	100%	33.33%	80%	90%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	100%	63,64%	100%	100%	88%	PDSA

- E. Permasalahan Rumah Sakit
- Beberapa kendala di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo :
- 1. Pemanfaatan ketepatan koding dan resources untuk klaim
 - 2. Penggunaan COB

F. Profil SDM
Komposisi dan Distribusi SDM
Tenaga Medis

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Dokter Umum/Gigi	11	0	11
	Dokter IGD	8	0	8
	Dokter Gigi	1	0	1
	Dokter MCU	1	0	1
	Dokter Ruangan	1	0	1
2	Dokter Spesialis	42	2	44
	IPD	3	1	4
	Anak	2	1	3
	Obgyn	3	0	3
	Bedah Umum	3	0	3
	Bedah Anak	1	0	1
	Bedah Syaraf	1	0	1
	Bedah Plastik	1	0	1
	Bedah Mulut	0	0	0
	Konservasi Gigi	1	0	1
	Orthopaedi & Traumatologi	3	0	3
	Urologi	2	0	2
	Paru	2	0	2
	Syaraf	3	0	3
	Jantung & Pembuluh Darah	2	0	2
	Mata	2	0	2
	THT	1	0	1
	Kulit & Kelamin	1	0	1
	Kesehatan Jiwa	2	0	2
	Rehabilitasi Medik	1	0	1
	Anastesiologi	3	0	3
	Patologi Klinik	1	0	1
	Patologi Anatomi	1	0	1
	Radiologi	2	0	2
	Emergency Medicine	1	0	1
3	Dokter Manajemen	1	1	2
	Direktur	0	1	1
	Kepala Bidang Pelayanan Medis	0	0	0
	Kepala Bidang Penunjang Medis	1	0	1
TOTAL		54	3	57

Tenaga Psikologi Klinis

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Tenaga Psikologi Klinis	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Tenaga Keperawatan

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	S2 Keperawatan	0	1	1
2	S1 Keperawatan	59	8	67
3	D4 Keperawatan	2	0	2
4	D3 Keperawatan	90	9	99
TOTAL		151	18	169

Tenaga Kebidanan

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	S1 Kebidanan	4	0	4
2	D4 Kebidanan	8	3	11
3	D3 Kebidanan	9	0	9
TOTAL		21	3	24

Tenaga Kefarmasian

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	APOTEKER	11	1	12
2	TTK	22	2	24
	S1 Farmasi	6	0	6
	D3 Farmasi	15	2	17
	D3 Analis Farmasi	1	0	1
	SMK Farmasi	1	0	1
TOTAL		34	3	37

Tenaga Kesehatan Masyarakat

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Epidemiolog Kesehatan	0	0	0
2	Tenaga Promosi Kesehatan dan Perilaku	1	0	1
3	Pembimbing Kesehatan Kerja	0	0	0
4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	0	3
5	Tenaga Biostatistik Kependudukan	0	0	0
6	Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	0	0	0
TOTAL		7	0	7

Tenaga Kesehatan Lingkungan

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Tenaga Sanitasi	0	0	0

2	Entomolog	0	0	0
3	Mikrobiolog	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Tenaga Gizi

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Nutrisionis	4	1	5
2	Dietisien	0	0	0
TOTAL		4	1	5

Tenaga Keterapian Fisik

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Fisioterapis	4	0	4
	S1	2	0	2
	D4	0	0	0
	D3	1	0	1
2	Okupasi Terapis	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
3	Terapis Wicara	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
4	Akupuntur	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
TOTAL		4	0	4

Tenaga Keteknisian Medis

no	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	18	1	19
	S1	0	0	0
	D4	4	0	4
	D3	14	1	15
2	Teknik Kardiovaskuler	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
3	Teknologi Medis	1	0	1
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	1	0	1
4	Teknisi Pelayanan Darah	0	0	0

	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
5	Refraksionis Optisien/Optometriss	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
6	Teknisi Gigi	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
7	Penata Anastesi	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
8	Terapis Gigi dan Mulut	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
9	Audiologis	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
TOTAL		19	1	20

Tenaga Teknis Biomedika

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Radiografer	6	2	8
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	6	2	8
	Tenaga Terampil	0	0	0
2	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	12	1	13
	S1	0	0	0
	D4	2	0	2
	D3	10	1	11
3	Fisikawan Medik	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
4	Radioterapis	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
5	Ortotik Prostetik	0	0	0
	S1	0	0	0
	D4	0	0	0
	D3	0	0	0
TOTAL		18	3	21

Tenaga Kesehatan Tradisional

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	0	0	0
2	Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Tenaga Non Kesehatan

No.	Jenis Tenaga	Februari		
		Tidak Tetap	Tetap	Total
1	Cleaning Service	41	1	42
2	Parkir	12	0	12
3	Laundry	6	0	6
4	CSSD	4	0	4
5	Dapur	9	1	10
6	IPSRS	2	1	3
7	Adm. Jaminan	2	0	2
8	Keuangan	1	0	1
9	Kasir	9	0	9
10	Humas Marketing	1	0	1
11	CSO	2	0	2
12	Staf Manajemen	1	0	1
13	Pendaftaran	17	0	17
14	Sekretariat	0	1	1
15	SDM	3	3	3
16	Gudang Umum	1	0	1
17	Rumah Tangga	0	0	0
18	Security	10	1	11
19	Driver	6	0	6
20	IPAL/B3	3	0	3
21	Tukang	4	0	4
22	Pemulasaran Jenazah	0	0	0
23	IT	3	0	3
TOTAL		137	8	145

b. Update STR/SIP Teprogres & Legalitas Habis kurang dari 6 Bulan

Beberapa staf sudah proses pengurusan perpanjangan SIP, untuk yang berwarna merah menunggu proses terbit SIP

No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
Terproses					
1	dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	400.722.2/SIP-DS/292/424.072/2024	13 Maret 2024	08 Maret 2029
2	dr. Akhmad Zainul	Dokter	400.722.2/SIP-	05 Maret	01 Maret

No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
	Arifin, Sp.N., M.Kes	Spesialis Neurologi	SD/288/424.072/2024	2024	2029
3	dr. Nejoa Ermaq Fatreciano	Dokter Umum	400.722.2/SIP-DUA/545/424.072/2024	02 Maret 2024	01 April 2029
4	Siti Kholifah, S.Kep.Ns	Perawat	500.16.7.2/131/SIP-P/III/424.086/2024	08 Maret 2024	18 Juni 2028
5	Anggun Den Ayu, Amd.Kep	Perawat	500.16.7.2/155/SIP-P/III/424.086/2024	18 Maret 2024	14 Maret 2029
6	Dimas Kurniansyah, S.Kep.Ns	Perawat	500.16.7.2/151/SIP-P/III/424.086/2024	14 Maret 2024	30 Agustus 2027
7	Muhammad Akhwanudin, S. Kep., Ns	Perawat	500.16.7.2/SIP-P/III/424.086/2024	08 Maret 2024	04 Maret 2029
8	Lilis Ernawati., S.Kep Ns	Perawat	500.16.7.2/12/SIP-P/III/424.086/2024	08 Maret 2024	04 Maret 2029
9	Nanda Faiza Awaliyah, Amd. Kep	Perawat	500.16.7.2/132/SIP-P/III/424.086/2024	08 Maret 2024	04 Maret 2029
10	M. Ifan Ramadhan Nur Safitra Amd. Rad	Radiografer	500.16.7.2/006/SIK-R/III/424.086/2024	08 Maret 2024	01 Maret 2029
11	Fina Fitriana Dwi Nur, Amd. RMIK	Perekam Medis	500.16.7.2/006/SIK-PM/III/424.086/2024	18 Maret 2024	13 Maret 2029
12	Rizqi Gitari Fernanda, Amd.Kep	Perawat	500.16.7.2/150/SIP-P/III/424.086/2024	14 Maret 2024	11 Maret 2029
13	Dhisma Fitri Rahmadhani Amd. Kep	Perawat	500.16.7.2/137/SIP-P/III/424.086/2024	08 Maret 2024	05 Maret 2029
14	Aslah Fortuna Ramadhan, Amd. Kep	Perawat	500.16.7.2/174/SIP-P/III/424.086/2024	22 Maret 2024	18 Maret 2029
15	Dandi Agus Prasetyo A.md.Rad	Radiografer	500.16.7.2/007/SIK-R/III/424.086/2024	08 Maret 2024	05 Maret 2029
16	Windy Silegar Maelani, S. Kep., Ns	Perawat	500.16.7.2/171/SIP-P/III/424.086/2024	20 Maret 2024	18 Maret 2029
17	Tansah Sinawang Sakinah, S.Tr.Kes	Analisis Kesehatan	500.16.7.2/011/SIP-ATLM/III/424.086/2024	18 Maret 2024	13 Maret 2029
18	Rodeyah A.Md.Kep	Perawat	500.16.7.2/134/SIP-P/III/424.086/2024	08 Maret 2024	06 Maret 2029
19	Intania Cahya Andini, A.Md.Kep	Perawat	500.16.7.2/145/SIP-P/III/424.086/2024	14 Maret 2024	11 Maret 2029
20	Lianda Agnes Puspita Amd.Kep	Perawat	500.16.7.2/169/SIP-P/III/424.086/2024	20 Maret 2024	16 Oktober 2027
21	Yudita Anggraini Amd.Kep	Perawat	500.16.7.2/127/SIP-P/III/424.086/2024	08 Maret 2024	08 Juni 2028
22	Ns. Dewi Muslimatul Qorin, S.Kep	Perawat	500.16.7.2/183/SIP-P/III/424.086/2024	27 Maret 2024	26 Maret 2029
23	Mukhammad Fakhrizal Baihaqi, A.Md.Kes	Radiografer	500.16.7.2/005/SIK-R/II/424.086/2024	27 Maret 2024	26 Maret 2029
Masa Berlaku Kurang dari 6 Bulan					
1	Shinta Aprilia Rizky Wulandari S.Farm. Apt	Apoteker	19960429/SIPA_35.14/146/2019	05 November 2019	29 April 2024
2	drg. Normayanti, Sp.KG	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	446/SIP-DS/21/424.072/2021	10 Maret 2021	30 April 2024
3	dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K)	Dokter Spesialis Bedah Plastik	446/SIP-DS/71/424.072/2019	07 November 2019	19 Mei 2024
4	Siti Mas Miranda Anggraeni, S.Kep., Ns	Perawat	503/122/SIP-P/III/424.086/2023	09 Maret 2023	19 Juni 2024
5	Indri Ayu Wandhani, Amd. Kep	Perawat	446/SIP/320/424.072/2020	02 Desember 2020	26 Juni 2024
6	dr. Fitri Indahyanti, Sp.P, MMRS	Dokter Spesialis Paru	446/SIP-DS/09/424.072/2021	19 Februari 2021	07 Juli 2024
7	Siti Khumairoh, Amd. Kep	Perawat	446/SIP/213/424.072/2020	05 Agustus 2020	29 Agustus 2024

No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
8	drg. Syafrini Farrahdebi	Dokter Gigi	446/SIP-DRG/24/424.072/2019	03 September 2019	31 Agustus 2024
9	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	446/SIP-DS/77/424.072/2019	18 Desember 2019	10 Oktober 2024
10	Ayu Indra Irmia, Amd. Farm	TTK	446/SIP TTK /9/424.72/2019	01 April 2019	16 Oktober 2024
11	Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb	Bidan	446/SIK-B/188/424.072/2020	15 Oktober 2020	17 Oktober 2024
12	Kasio Widiyanto, S. Kep., Ns	Perawat	446/SIP/321/424.072/2020	02 Desember 2020	01 November 2024
13	Debi Firmanasia, Amd. Kep	Perawat	446/SIP/214/424,072/2020	28 Agustus 2020	13 November 2024
14	Novi Lianti Indra., S. Keb.Bd	Bidan	503/118/SIP-B/VI/424.086/2022	16 Juni 2022	15 November 2024
15	Antika Setya Narutama, S.Kep., Ns	Perawat	503/338/SIP-P/VI/424.086/2022	07 Juni 2022	16 November 2024
16	Ida Nihayatul Afifa, S.Kep., Ns	Perawat	503/052/SIP-P/II/424.086/2023	03 Februari 2023	19 November 2024

G. Program Nasional (PROGNAS)

I. PROGNAS HIV

a. Fasilitas Pelayanan HIV/AIDS

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	kondisi	KET
1	Reagen Pemeriksaan anti-HIV	Laboratorium	3 Reagen	baik	-
2	Formulir persetujuan dan penolakan pemeriksaan HIV/AIDS	Rekam Medis Poli spesialis	1 Set	Baik	-
3	Ruang Poli	Poli Spesialis Penyakit dalam	1 ruang	Baik	-

Analisis :

- 1. Secara umum kondisi fasilitas dan perlatan untuk HIV masih belum lengkap, secara bertahap akan dilakukan kelengkapan inventaris kebutuhan pelayanan HIV/AIDS.
- 2. Untuk ARV masih belum tersedia maka pasien dengan HIV reaktif harus di rujuk.
- 3. Jumlah Formulir persetujuan dan penolakan pemeriksaan HIV/AIDS terbatas sehingga formulir disediakan di rekam medis dan poli Spesialis saja.

Rencana tindak lanjut:

- 1. Koordinasi dengan bagian pengadaan terkait cetak formulir persetujuan dan penolakan pemeriksaan HIV/AIDS.
- 2. Koordinasi dengan dinas kesehatan kab. pasuruan terkait ketersediaan dan stock reagen HIV/AIDS dengan melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan HIV/AIDS.

b. PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Melakukan skrining pasien dengan HIV atau AIDS	• Melakukan inisiatif petugas untuk memeriksakan pasien terduga HIV • Melakukan observasi • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
2	Mengurangi dan mencegah penyebaran HIV/AIDS	• Melakukan edukasi kepada pasien • Melakukan tes HIV • Melakukan observasi • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
3	Meningkatkan fungsi pelayanan <i>Voluntary Counseling and Testing</i> (VCT)	• Melakukan Edukasi • Melakukan observasi • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi

4	Meningkatkan fungsi pelayanan <i>Prevention Mother to Child Transmision (PMTCT)</i>	• Melakukan edukasi kepada pasien • Melakukan tes HIV • Melakukan observasi • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuatrencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
5	Meningkatkan fungsi pelayanan <i>Anti Retro Viral Therapy (ART)</i> atau bekerja sama dengan RS yang ditunjuk	• Melakukan edukasi kepada pasien • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi • Kolaborasi dengan rumahsakitrujukan
6	Meningkatkan fungsi pelayanan <i>Infeksi Oportunistik (IO)</i>	• Melakukan edukasi kepada pasien • Melakukan tes HIV • Melakukan observasi • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi • Kolaborasi dengan DPJP politerkait
7	Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan factor resiko <i>Injection Drug Use (IDU)</i>	• Melakukan edukasi kepada pasien • Melakukan tes HIV • Melakukan observasi • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
8	Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang, yang meliputi : Pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.	• Melakukan kolaborasi dengan unitterkait. • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi

Analisis dalam hal Pengembangan Pelayanan:

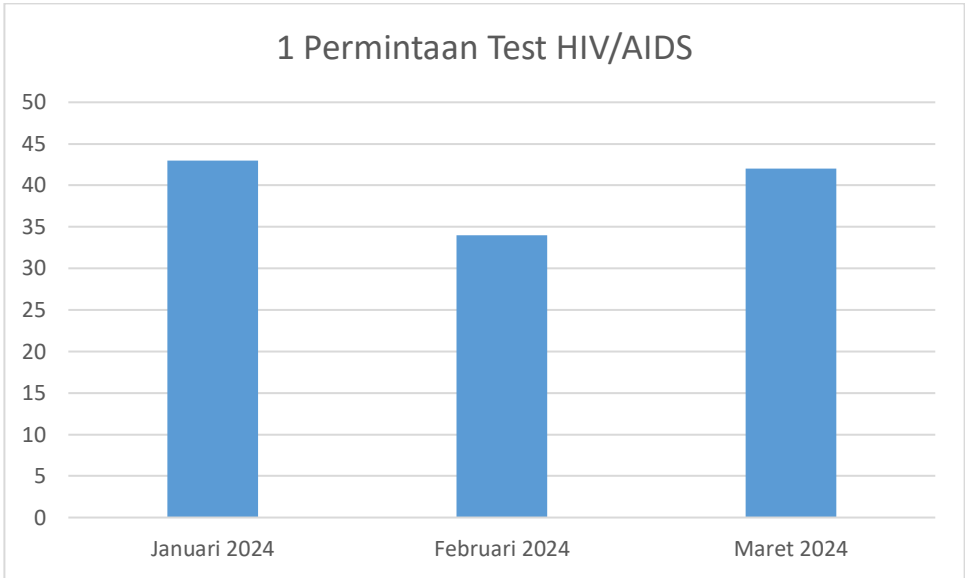
1. Melakukan edukasi mendalam terkait dilakukanya test HIV/AIDS kepada pasien dengan cara melakukan pendekatan kepada pasien dengan HIV/AIDS.

c. KINERJA PRODUKTIVITAS

1. Jumlah permintaan Tes HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1	Permintaan Test HIV/AIDS	43	34	42

GRAFIK 1
JUMLAH PERMINTAAN TEST HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI-MARET 2024



Analisis Jumlah Permintaan Test HIV/AIDS:

Pada bulan Januari 2024 terdapat 43 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Februari 2024 terdapat 34 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Maret 2024 terdapat 42 permintaan testing HIV/AIDS

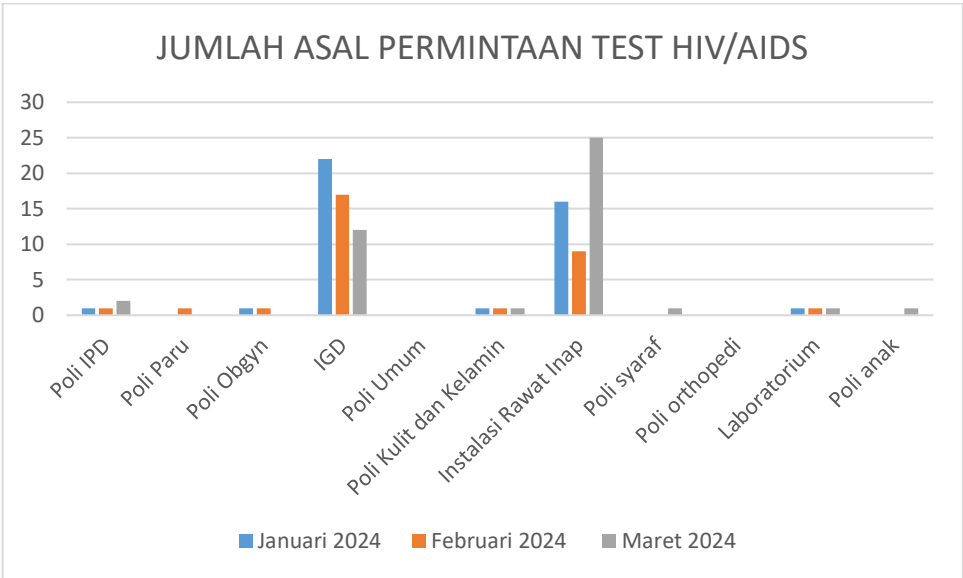
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
3. Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
4. Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan masyarakat (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.
5. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasien TB yang status HIV nya tidak diketahui
6. Melakukan edukasi dan sosialisasi terduga TB yang status HIV nya tidak diketahui.

2. ASAL PERMINTAAN TES HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1	Poli IPD	1	1	2
2	Poli Paru	0	1	0
3	Poli Obgyn	1	1	0
4	IGD	22	17	12
5	Poli Umum	0	0	0
6	Poli Kulit dan Kelamin	1	1	1
7	Instalasi Rawat Inap	16	9	25
8	Poli syaraf	0	0	1
9	Poli orthopedi	0	0	0
10	Laboratorium	1	1	1
11	Poli anak	0	0	1

GRAFIK 2
JUMLAH ASAL PERMINTAAN TEST HIV/AIDS DI RUMAH
SAKIT PRIMAHUSADA
BULAN JANUARI-MARET 2024

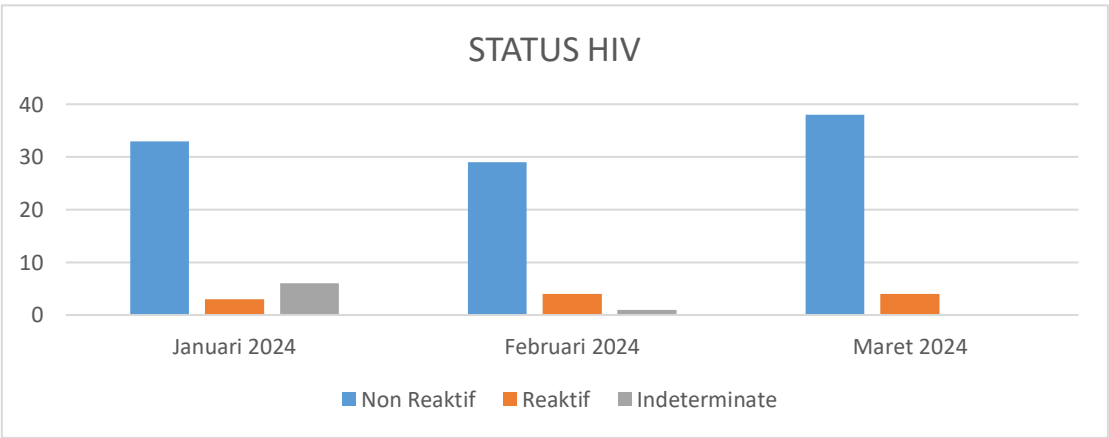


- Analisis Asal Permintaan Tes HIV/AIDS**
- Peningkatan permintaan test HIV/AIDS terdapat di IGD pada bulan Januari 2024.
- Rencana dan Tindak Lanjut:**
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
 3. Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
 4. Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.

3.STATUS HIV

No	URAIAN	BULAN		
		Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1	Non Reaktif	33	29	38
2	Reaktif	3	4	4
3	Indeterminate	6	1	0

GRAFIK 3
STATUS HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI-MARET 2024



- Analisis Status HIV/AIDS:**
- Pada bulan Januari 2024 terdapat 33 non reaktif HIV/AIDS, 3 pasien reaktif HIV/AIDS dan 6 indeterminate. Pada bulan Februari 2024 terdapat 29 non reaktif HIV/AIDS, 4 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 indeterminate. Pada bulan Maret 2024 terdapat 38 non reaktif HIV/AIDS, 4 pasien reaktif HIV/AIDS dan 0 indeterminate.
- a. Apabila hasil positif : Bila hasil A1 reaktif. A2 rektif dan A3 reaktif
- Apabila hasil Negatif :

- 1. Bila hasil A1 non reaktif
- 2. Bila hasil A1 reaktif tapi pada pengulangan A1 dan A2 non reaktif
- 3. Bila salah satu reaktif tapi tidak berisiko

dan apabila Hasil indeterminate

- 1. Bila dua hasil reaktif
- 2. Bila hanya 1 tes reaktif tapi berisiko atau pasangan berisiko

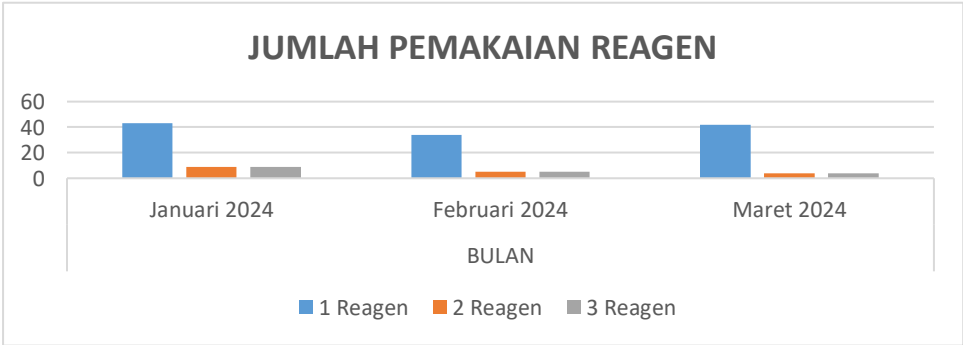
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Tindak lanjut hasil positif
 - a. Rujuk ke pengobatan HIV
- 2. Tindak lanjut hasil negatif
 - a. Bila hasil negatif dan berisiko dianjurkan pemeriksaan ulang minimum 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama
 - b. Bila hasil negatif dan tidak berisiko dianjurkan perilaku sehat
- 3. Tidak lanjut hasil indeterminate
 - a. Tes perlu diulang dengan spesimen baru minimum setelah dua minggu dari pemeriksaan yang pertama
 - b. Bila hasil tetap indeterminate, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR
 - c. Bila tidak ada akses ke pemeriksaan PCR, rapid tes diulang 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama.
 - d. Bila sampai satu tahun tetap “indeterminate” dan faktor risiko rendah, hasil dinyatakan sebagai negative.

4. JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN

No	URAIAN	BULAN		
		Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1	1 Reagen	43	34	42
2	2 Reagen	9	5	4
3	3 Reagen	9	5	4

GRAFIK 4
JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN BULAN JANUARI-MARET 2024



Analisis jumlah pemakaian reagen:

Pada bulan januari 2024 terdapat 43 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 9 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 9 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan Februari 2024 terdapat 34 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 5 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 5 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan Maret 2024 terdapat 32 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 4 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 4 pasien menggunakan jenis reagen 3.

Rencana tindak lanjut:

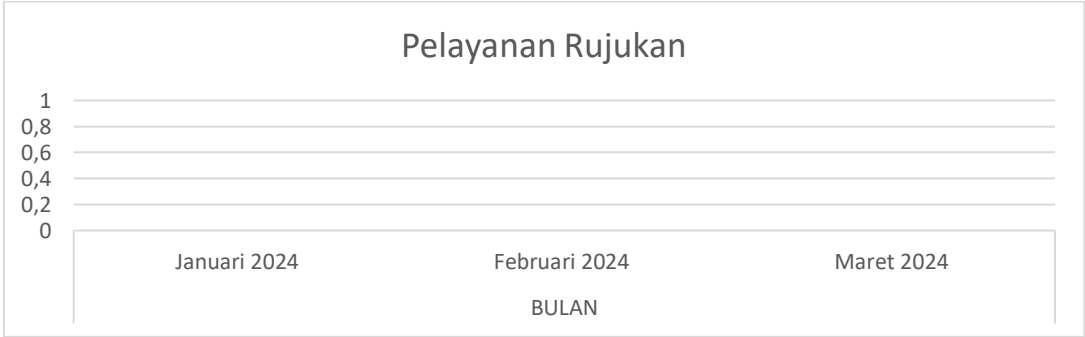
- 1. Pemeriksaan dilakukan secara serial dengan menggunakan 3 jenis reagen yang berbeda sesuai

- dengan pedoman nasional.
2. Penyimpanan reagen HIV dilakukan sesuai dengan instruksi yang tertera dilembar informasi dan digunakan sebelum tanggal kedaluwarsa.

5. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1	Pelayanan Rujukan	0	0	0

GRAFIK 5
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS
DI RUMAH SAKIT PRIMAHUSADA
BULAN JANUARI-MARET 2024



Analisis Pelayanan rujukan pasien dengan HIV/AIDS

Pada bulan Januari 2024 ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV. Pada bulan Februari 2024 ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV. Pada bulan Maret 2024 ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV.

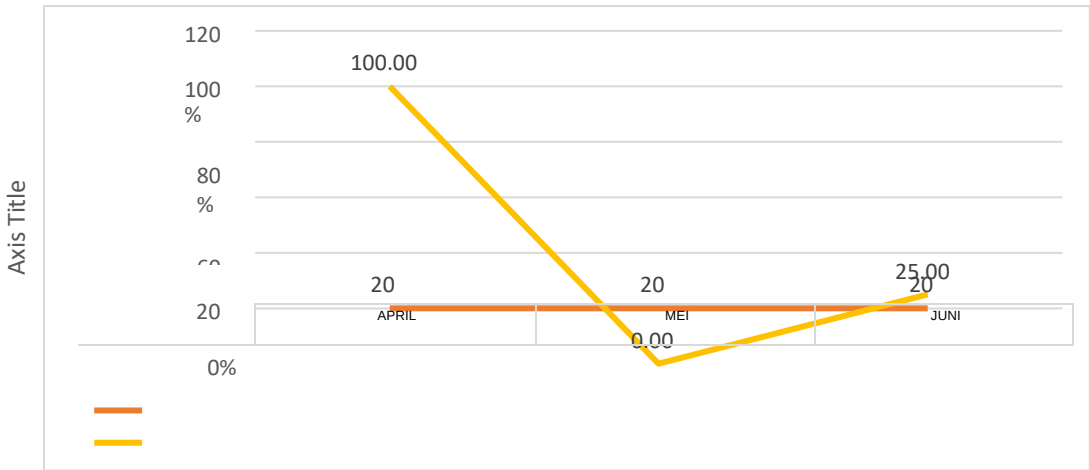
Rencana Tindak Lanjut:

Penemuan kasus HIV lebih dini meningkatkan akses perawatan dan pengobatan yang memadai sehingga mengurangi angka kematian.

a. KUNCI INDIKATOR MUTU HIV/AIDS

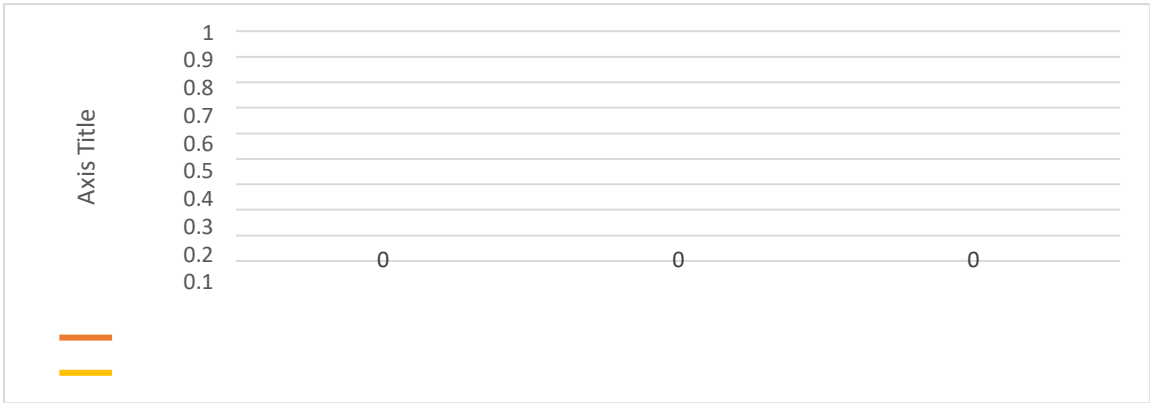
INDIKATOR MUTU	JAN	FEB	MAR
Kejadian tidak teridentifikasi pasien HIV pada pasien bedah	0%	0%	0%
Angka kesakitan HIV/ AIDS	100%	0%	0%

GRAFIK 6
KUNCI INDIKATOR MUTU ANGKA KESAKITAN HIV/ AIDS
DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI-MARET 2024



STANDARD	20%	20%	20%
CAPAIAN	100.00%	0.00%	25.00%

GRAFIK 7
KUNCI INDIKATOR MUTU KEJADIAN TIDAK TERIDENTIFIKASI PASIEN HIV/AIDS PADA PASIEN BEDAHDI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN **JANUARI-MARET 2024**



	JANUARI	FEBRUARI	MARET
STANDARD	0	0	0
CAPAIAN	0	0	0

Analisis kunci indikator mutu HIV/AIDS:

Pada bulan Januari 2024 ada 3 angka kesakitan HIV/AIDS. Pada bulan Februari 2024 ada 4 angka kesakitan HIV/AIDS

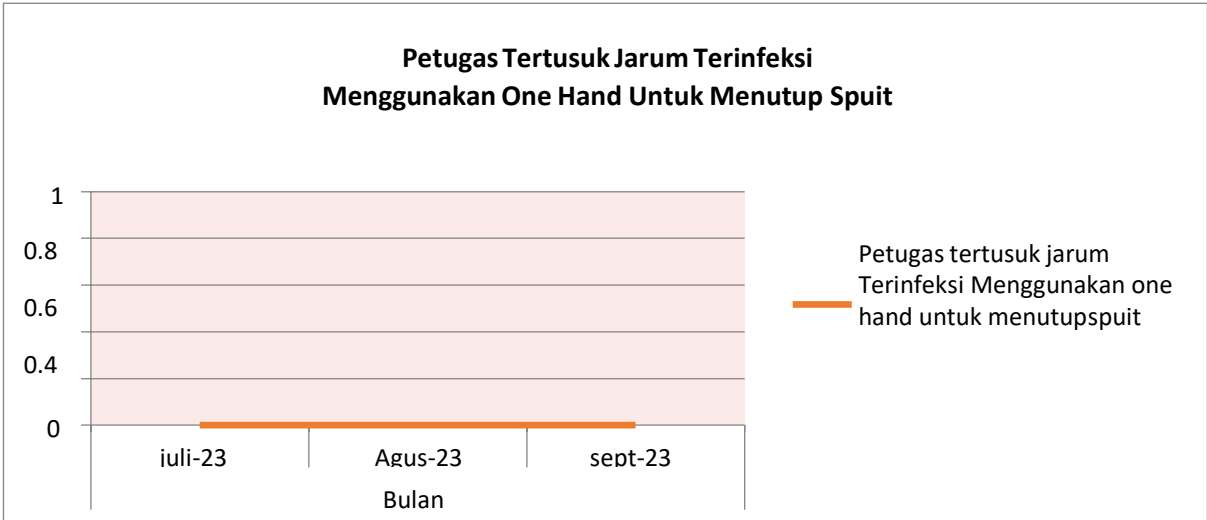
Rencana Tindak Lanjut:

- a. Melakuakn upaya pencegahan meliputi beberapa aspek yaitu penyebaran informasi, promosi penggunaan kondom, skrining darah pada donor darah, pengendalian IMS.
- b. Mengedukasi dan penyebaran informasi perlu menekankan manfaat tes HIVdan pengobatan ARV.

d. KESELAMATAN KERJA

No	Kejadian	Risiko	Upaya mencegah risiko	Bulan		
				Jan 24	Feb 24	Mar 24
1	Petugas Tertusuk jarum	Terinfeksi	Menggunakan one hand untuk menutup spuit	0	0	0

GRAFIK 8
KESELAMATAN KERJA HIV/AIDS DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN **JANUARI-MARET 2024**



Analisis Keselamatan kerja:

Pada bulan Januari 2024 tidak ada petugas yang tertusuk jarum. Pada bulan Februari 2024 tidak ada petugas yang tertusuk jarum.

Rencana Tindak Lanjut:

- a. Perlindungan dan kesehatan karyawan dengan melaksanakan tatalaksana pasca pajanan
- b. Praktik penyuntikan yang aman.
- c. Alat Pelindung Diri (APD)

e. EVALUASI JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan Tim HIV/AIDS adalah:

No	Kegiatan	Pemenuhan*
1	Pendidikan dan pelatihan HIV	Sesuai jadwal

f. ANALISIS KESELURUHAN DAN SARAN

- 1. Pada Bulan Oktober 2022 sampai Januari 2024 tidak dilakukan perubahanSDM pada Tim HIV.
- 2. Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah Kunci indikator mutu HIV
- 3. Kordinasi dengan Tim untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan ditembusi oleh direktur Rumah Sakit.
- 4. Tidak terjadinya kecelakaan kerja, seperti tertusuk jarum oleh tenaga kesehatan. Dengan lebih savety menggunakan one hand saat melakukan tindakan, dan melakukan 5 moment mencuci tangan

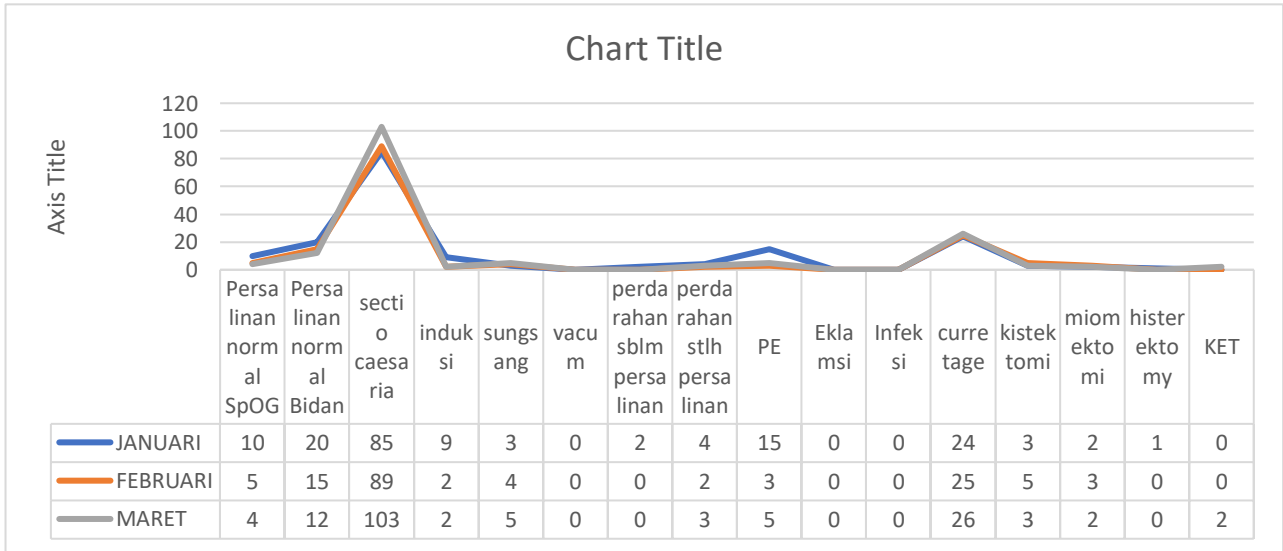
II. PROGNAS PONEK

1. Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	10	5	4
	b. Persalinan Normal Bidan	20	15	12
	c. <i>SectioCaesaria</i>	85	89	103
2	Persalinan dengan tindakan			
	a. Induksi / Drip	9	2	2
	b. Sungsang	3	4	5
	c. Vacuum	0	0	0
3	Persalinan dengan Komplikasi			
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	2	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	4	2	3
	c. PE	15	3	5
	e. Eklamsi	0	0	0
	f. Infeksi	0	0	1
4	Kebidanan :			
	a. Curretage	24	25	26
	b. Kistektomi	3	5	3
	c. Miomektomi	2	3	2
	d. Histerectomy	1	0	0
	e. KET	0	0	2

GRAFIK 1

JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN MATERNAL DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA BULAN MARET 2024



- Evaluasi :
- Persalinan normal dengan Sp.Og untuk bulan maret jumlahnya turun dari bulan kemarin karena persalinan bulan ini turun banyak dilakukan tindakan SC sesuai

- dengan indikasi
2. Terjadinya penuruanan persalinan dengan bidan dari bulan sebelumnya dikarenakan rujukan yang datang ke IGD merupakan rujukan yang membutuhkan Tindakan SC kegawatdaruratan
 3. Untuk kasus persalinan sc dalam bulan ini naik dari bulan kemarin, karena rujukan emergency dari IGD naik.
 4. Persalinan dengan induksi sama dengan bulan sebelumnya. Untuk induksi sendiri di berikan kalau benar-benar ada indikasi yang sesuai dengan kriteri dilakukan induksi supaya pasiennya aman.
 5. Kasus persalinan sungsang bulan ini naik dari bulan sebelumnya, dan itu lodingan dari poli yang sudah jauh-jauh hari sudah di rencanakan operasi dan ada pula yang dari rujukan.
 6. Tidak ada kasus persalinan dengan tindakan persalinan dengan vacum tidak pernah dilakukan.
 7. Kasus perdarahan sebelum persalinan untuk bulan ini tidak ada.
 8. Kasus perdarahan setelah melahirkan pada bulan maret naik dari bulan sebelumnya dan merupakan pasien post sc yang kontraksinya kurang maksimal.
 9. Pasien dengan Preeklampsia bulan ini jumlahnya naik dari bulan sebelumnya dan kebanyakan pasien rujukan dari bidan atau klinik.
 10. Infeksi pada bulan ini lebih banyak dari bualn kemarin atau 1 kasus yang terjadi yaitu ILO dikarenakn pasien jarang mobilisasi dan tidak mau mengkonsumsi telur.
 11. Tindakan curretage bulan ini naik dari bulan sebelumnya
 12. Tindakan miomektomi pada bulan Maret menurun dari bulan sebelumnya.
 13. Tindakan kistektomi pada bulan maret menurun dari bulan sebelumnya
 14. Kasus histerektomi untuk bulan ini tidak ada kejadian
 15. Kasus KET pada bulan maret lebih banyak dari bulan sebelumnya.

Rencana dan Tindak Lanjut

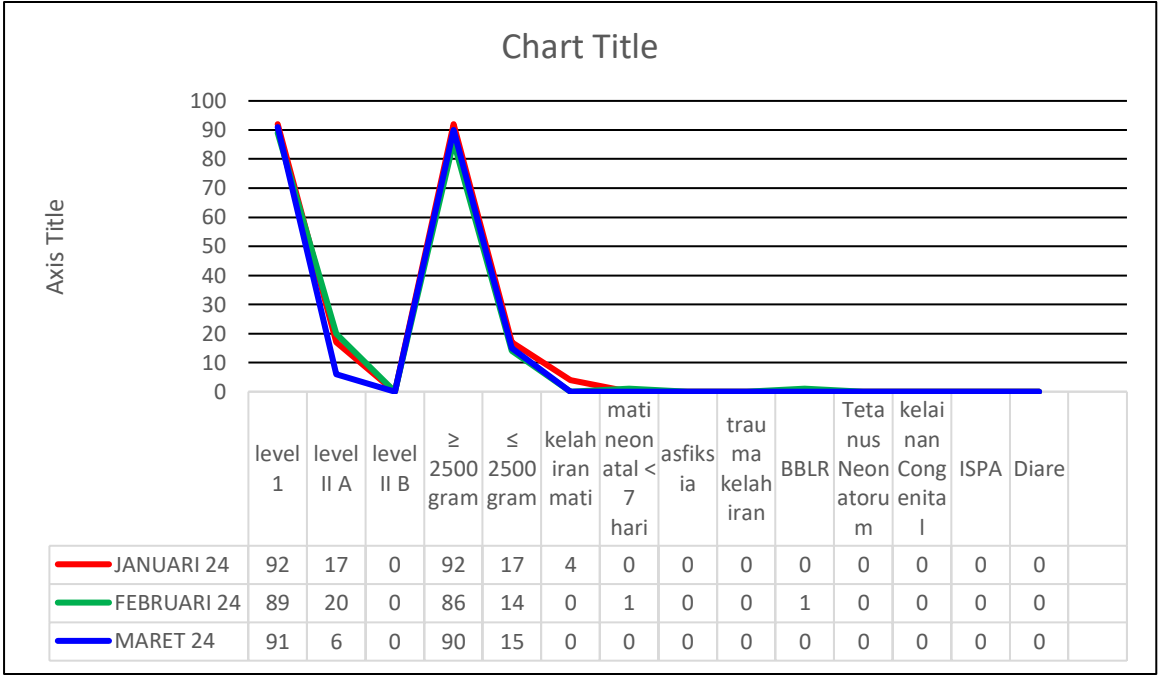
7. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit untuk melakukan promosi dan mengenalkan dokter-dokter obgyn yang ada di prima husada sukorejo
8. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya kehamilan di trimester 1, 2 dan 3 kehamilan.
9. Mengadakan kelas ibu hamil dan memberi materi dan edukasi terkait kehamilan dan persalinan

2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	Jumlah pasien neonatal			
	d. Level 1	92	86	91
	e. Level II A	17	20	6
	f. Level II B	0	0	0
2	Bayi Lahir Hidup			
	c. ≥ 2500 gram	92	86	90
	d. ≤ 2500 gram	17	14	15
3	Kematian neonatal			
	c. Kelahiran Mati	4	0	0
	d. Mati Neonatal < 7 Hari	0	1	0
4	Sebab Kematian Neonatal			
	a. Asphyxia	0	0	0

	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	0	1	0
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

GRAFIK 2
JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN NEONATAL DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN MARET 2024



Evaluasi

- 1. Untuk perawatan bayi level 1 bulan ini naik dari bulan sebelumnya karena jumlah persalinan bulan ini juga naik
- 2. Perawatan bayi level II A menurun dari bulan sebelumnya dan bayi hanya membutuhkan incubator saja. Hal ini di karenakan rata-rata bayi sehat dan Sebagian besar rawat gabung.
- 3. Perawatan bayi level II B tidak ada bulan ini.
- 4. Terdapat kenaikan jumlah di bulan ini untuk bayi yang BB nya lebih dari 2500 karena jumlah persalinan bulan ini juga naik.
- 5. Untuk bulan ini jumlah bayi lahir hidup dengan berat badan ≤ 2500 gram jumlahnya nemingkat dengan bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kasus partus prematurus imminens (PPI) pada ibu hamil
- 6. Untuk kelahiran mati bulan ini tidak ada atau nihil
- 7. Untuk kematian neonatal < 7 hari pada bulan ini tidak ada sama sekali
- 8. Bayi yang meninggal dengan untuk bulan ini tidak ada.

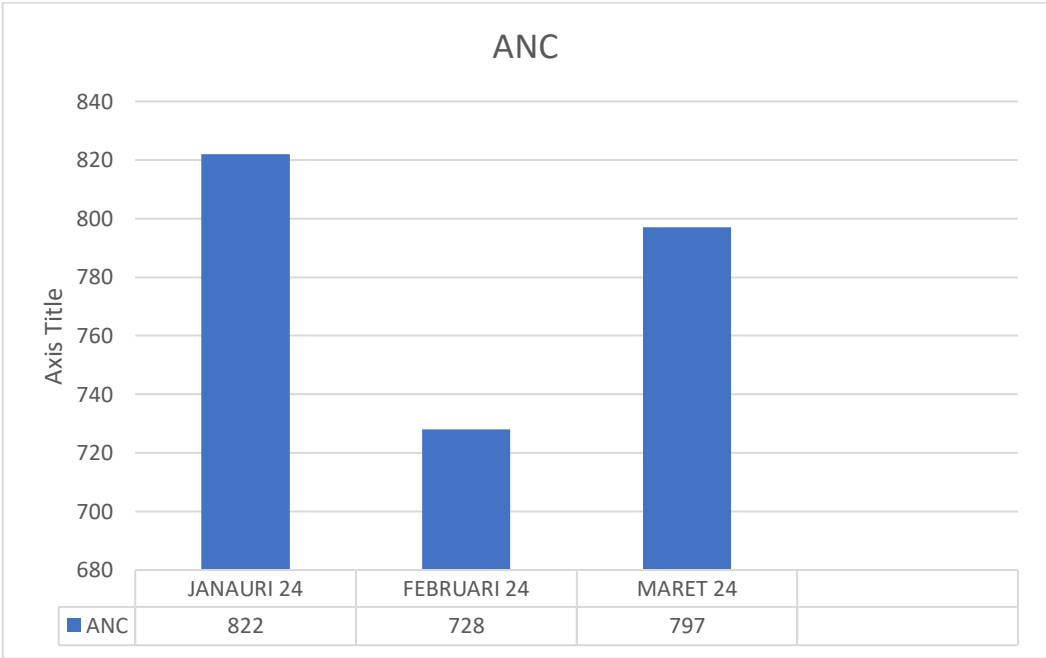
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi dan persiapan persalinan agar tidak terjadi infeksi neonatus karena ketuban mekonial.

Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	ANC	822	728	797

GRAFIK 3
JUMLAH PELAYANAN ANTE NATAL CARE (ANC) DI RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA BULAN MARET 2024



Evaluasi

Terdapat kenaikan jumlah pelayanan Ante Natal Care, pada bulan maret 2024 sebanyak 797 pasien.

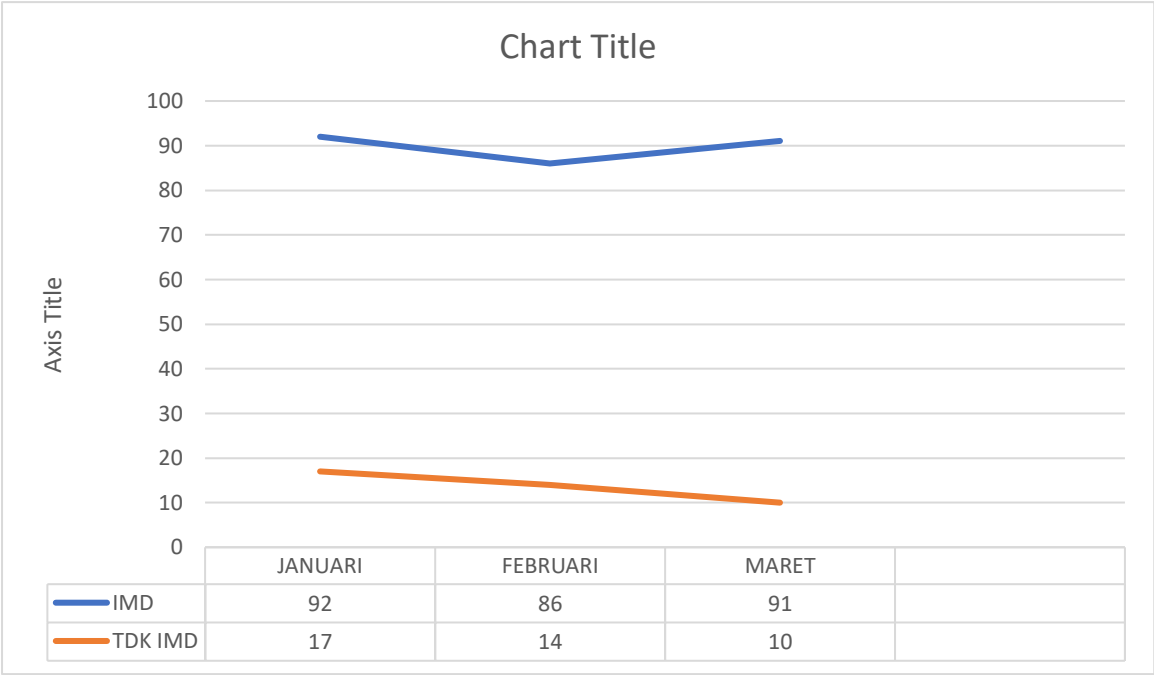
Rencana dan Tindak Lanjut

Melakukan promosi terkait senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilanya.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		BULAN MARET 2024
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	
1	IMD	92	86	91
2	Tidak IMD	17	14	10

GRAFIK 4
JUMLAH PELAYANAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN MARET 2024



Evaluasi

- 1. Untuk bulan ini jumlahnya naik dari bulan sebelumnya dalam pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kelahiran di rumah sakit prima husada Sukorejo dan bayi dalam keadaan sehat sehingga bisa memungkinkan untuk dilakukan IMD.
- 2. Terjadi penurunan dalam pelayan tidak dilakukan IMD. Hal ini dikarenakan bayi tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD atau bayi sakit.

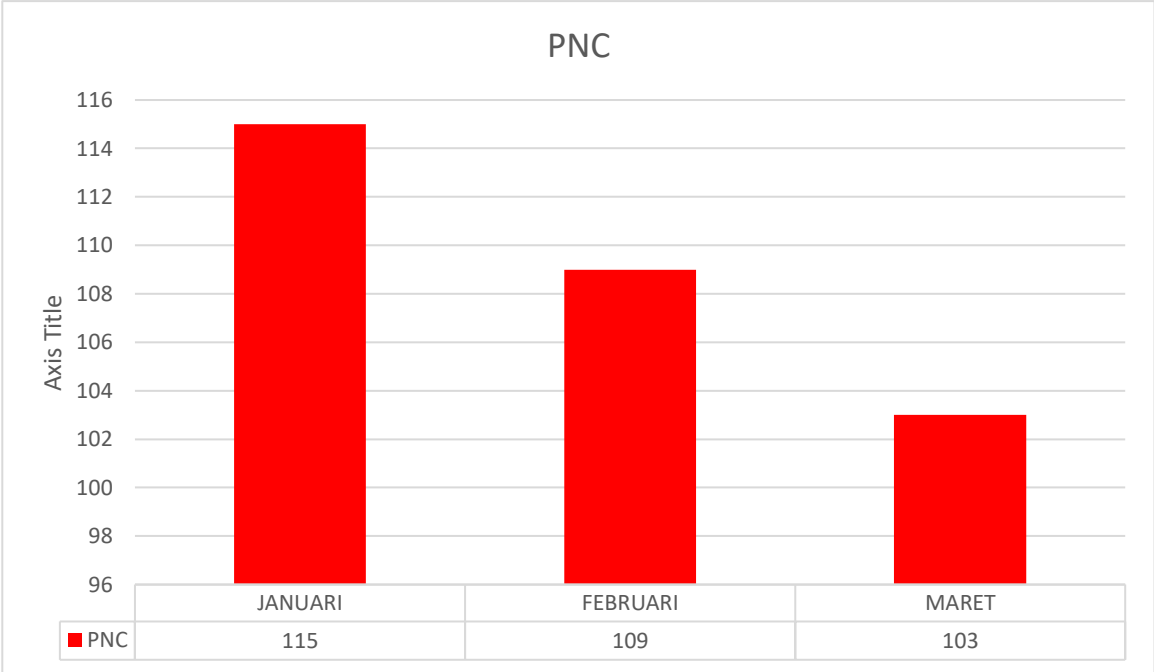
Rencana dan Tindak Lanjut

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

Pelayanan Post Natal Care (PNC)

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	PNC	115	109	103

GRAFIK 5
JUMLAH PELAYANAN POST NATAL CARE (PNC) DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN MARET 2024



Evaluasi

Terdapat Penurunan jumlah kunjungan pasien PNC. Pada bulan ini sebanyak 103 pasien. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pasien bersalin di rumah sakit prima husada sukorejo.

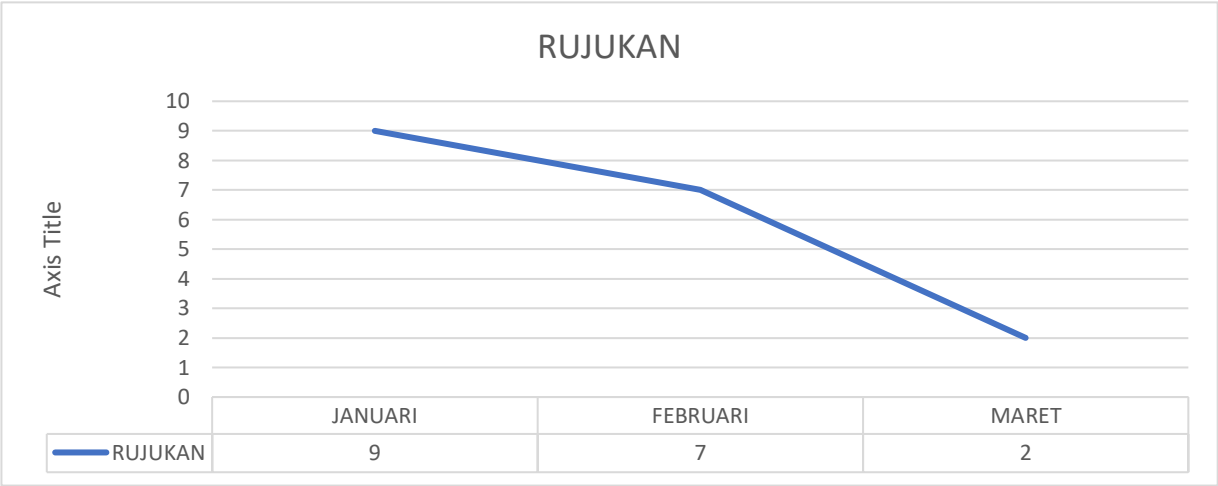
Rencana dan Tindak Lanjut

Melakukan promosi kegiatan tentang pelayanan post natal Care, dengan bekerjasama dengan bidan sekitar rumah sakit.

Pelayanan Jejaring Rujukan (Rujukan eksternal)

No	Pelayanan	JUMLAH			TUJUAN RUJUK
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024	
1	Rujukan eksternal	9	7	2	1. RS Supraoen Malang 2. RSUD Grati
TOTAL		9	7	2	

GRAFIK 7
PELAYANAN JEJARING RUJUKAN (RUJUKAN EKSTERNAL) RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA BULAN MARET 2024



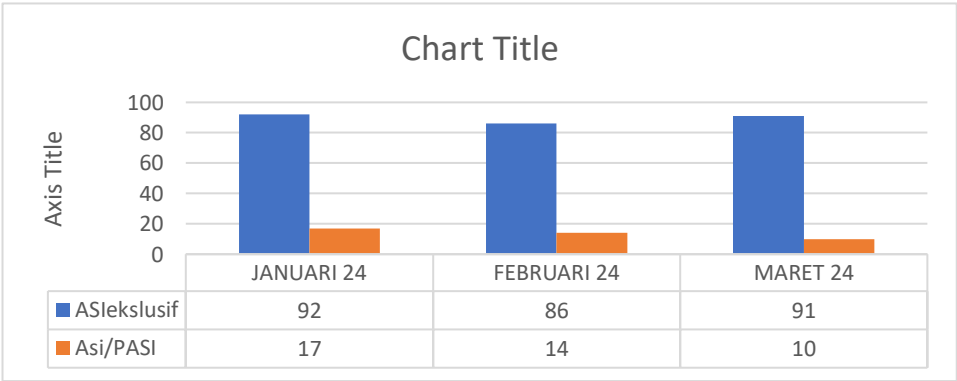
Evaluasi :
Untuk bulan ini ada rujukan keluar yaitu 2 dan menurun dari bulan kemarin, rujukan bayi yang sebagian besar karena long NICU dan membutuhkan perawatan lebih lanjut.

Tindak Lanjut :
Meningkatkan jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

Pelayanan Pemberian ASI Ekslusif

No	Pemberian ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2024	BULAN MARET 2024
1	Asieksklusif	90	86	91
2	Asi /PASI	12	14	10

GRAFIK 7
PELAYANAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN MARET 2024



Evaluasi

- 3. Terdapat peningkatan pada pelayanan pemberian ASI Eksklusif pada bulan maret 2024, Hal ini dikarenakan jumlah persalinan naik jadi bayi yang ASI Eksklusif juga naik.
- 4. Terdapat penurunan jumlah pasien yang diberikan susu formula pada bulan kemarin sama bulan ini. Karena bayi yang dilahirkan sakit dan harus perawatan di rs dulu dan asi belum keluar

Rencana dan Tindak Lanjut

Dilakukan Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

MUTU

No	Indikator	Standar	Bulan		
			Jan	Feb	Mar
1.	Angka kematian ibu	0 %	0	0	0
2.	Angka kematian bayi	0 %	4	1	
3.	Kejadian perdarahan post partum pada ibu pasca persalinan	0	4	2	3
4	Kejadian partus lama pada ibu saat persalinan	0	2	2	2
5	Kejadian eklamsi pada ibu hamil	0	0	0	0
6	Kejadian pre eklamsia pada ibu hamil	0	15	3	5
7	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	1

Evaluasi

- 1. Untuk kasus kematian ibu bulan ini tidak ada
- 2. Untuk kematian bayi menurun pada bulan ini dikarena bayi lahir bblr dan sudah dilakukan perawatan
- 3. Untuk kejadian perdarahan post partum pada paska melahirkan naik dari bulan kemarin, kebanyakan rata-rata pasien yang habis oprasi SC dan uterusnya tidak kontraksi secara maksimal
- 4. Untuk kasus partus lama pada bulan ini meningkat, di karenakan awalnya pasien ingin persalinan normal setelah buka lengkap pasien tidak bisa mengedan dan tenaganya habis jadi pasien akhirnya SC.
- 5. Untuk kasus eklamsi bulan maret tidak ada sama sekali
- 6. Untuk kejadian pre eklamsia pada bulan maret terjadi kenaikan dari bulan kemarin, rata-rata merupakan pasien rujukan dari bidan
- 7. Untuk kejadian infeksi nifas tidak ada kasus sama sekali pada bulan Februari

Rencana dan Tindak Lanjut

Kerja sama dengan unit-unit yang bersangkutan dan PJ mutu rumah sakit untuk menekan mutu supaya tidak sampai meningkat dan keselamatan pasien terjaga.

III. PROGNAS STUNTING

I. Fasilitas Pelayanan Stunting

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	KET
1	Alat Pengukuran Antropometri	Poli Spesialis Anak, Poli Gizi	3 Set	baik	
2	Formulir Assessment Gizi	Rekam Medis Poli Gizi	1 Set	Baik	
3	Ruang Poli	Poli Spesialis Anak	1 Ruang	Baik	

Analisis :

1. Secara umum kondisi fasilitas dan peralatan untuk Stunting masih belum lengkap, secara bertahap akan dilakukan kelengkapan inventaris kebutuhan pelayanan Stunting
2. Untuk alat pengukuran antropometri di poli gizi masih belum tersedia.

Rencana Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan bagian pengadaan terkait menyediakan perlengkapan antropometri.
2. Koordinasi dengan dinas kesehatan kab. Pasuruan dengan melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan Stunting.

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Melakukan skrining pasien Stunting dan Wasting	• Melakukan inisiatif petugas untuk memeriksakan pasien Stunting dan Wasting • Melakukan observasi • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi

		• Melakukan edukasi kepada pasien • Melakukan skrinning gizi • Melakukan observasi
	Mencegah terjadinya	
2	Stunting dan Wasting pada Anak	• Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
3	Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang, yang meliputi : Pelayanan gizi, pencatatan dan pelaporan.	• Melakukan kolaborasi dengan unit terkait. • Melakukan Monitoring • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi

Analisis dalam hal Pengembangan Pelayanan:

1.
- Melakukan edukasi mendalam terkait dilakukanya Assessment Gizi kepada pasien dengan cara melakukan skrinning gizi.

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

1. Jumlah Pasien Stunting, Wasting, Underweight, dan Gizi Buruk Rawat Inap

No	Masalah Gizi	BULAN		
		Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1	Stunting	0	0	0
2	Wasting	0	0	0
3	Underweight	0	0	0
4	Gizi Buruk	0	0	0

Analisis Jumlah Pasien Stunting, Wasting, Underweight, Gizi Buruk

Pada bulan Januari, Februari, Maret tidak terdapat pasien anak yang mengalami masalah gizi.

Rencana Tindak Lanjut Pasien Stunting, Wasting, Underweight, Gizi Buruk

Petugas medis melakukan pemantauan asupan makan pasien, perubahan berat badan selama rawat inap dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi fisik klinis pasien.

2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staff, pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting

Kegiatan	Januari	Februari	Maret
Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya	Pemberian edukasi tentang pemberian ASI Eksklusif untuk Ibu Menyusui di ruang maternitas sebagai upaya pencegahan stunting dan	Pemberian edukasi tentang gizi ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting di kelas ibu hamil dolina	Pemberian edukasi tentang gizi ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting di kelas ibu hamil dolina

pencegahan dan penanganan stunting dan wasting	wasting		
---	----------------	--	--

Analisis:
 Penyuluhan diadakan di ruang maternitas yang ditujukan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia anak 2 tahun sebagai salah satu upaya pencegahan penanganan stunting

Rencana Tindak Lanjut :
 Sosialisasi tentang stunting dan wasting perlu terus ditingkatkan dengan disertai pemberian contoh makanan untuk ibu menyusui, ibu hamil dan MPASI untuk baduta. Pemberian sosialisasi menggunakan media edukasi yang menarik sehingga kelompok sasaran dapat memahami materi yang akan disampaikan.

3. Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Lokasi	Januari	Februari	Maret
Program 1000 HPK	Penyuluhan terkait 1000 Hari Pertama Kehidupan	Poli Anak dan Poli Kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
Suplementasi asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	1. Kelas Bumil Dolina 2. Poli Kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di kelas ibu hamil dolina	Telah dilakukan di poli kandungan
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil yang terindikasi KEK	Kelas Bumil Dolina	Belum dilakukan penyuluhan	Telah dilakukan di kelas ibu hamil dolina	Telah dilakukan di kelas ibu hamil dolina
Promosi dan Konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Poli Kandungan dan Poli Anak, Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	-	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi memberikan	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi memberikan	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi memberikan PMT bagi

			PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit
Pemantauan Pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak
Pemberian Vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu
Pemberian Makanan Tambahan Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Rumah Sakit	Telah diberikan PMT untuk pasien gizi buruk di bulan Januari selama rawat inap.	Telah diberikan PMT untuk pasien gizi buruk di bulan Februari selama rawat inap.	Telah diberikan PMT untuk pasien gizi buruk di bulan Maret selama rawat inap.
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Posyandu	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk	Posyandu	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing

	mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil		obat cacing pada ibu hamil	obat cacing pada ibu hamil	pada ibu hamil
--	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------

Analisis :
 Sebagian besar intervensi gizi spesifik yang dapat dilaksanakan di Rumah Sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi pada intervensi gizi spesifik berupa pemberian taburia dan vitamin A pada balita, pemberian obat cacing pada ibu hamil masih belum dilakukan karena ketresediaan taburia, obat cacing, dan vitamin A terdapat pada faskes 1. Pemberian edukasi kepada ibu hamil di kelas Ibu Hamil DOLINA dilaksanakan sebagai Upaya pencegahan stunting sejak dini.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit.

4. Pemberian Tablet Besi Folat bagi Ibu Hamil

Bulan	Januari	Februari	Maret
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli Kandungan	822	728	797

Analisis:
 Seluruh ibu hamil yang melakukan kunjungan di poli kandungan di rumah sakit prima husada malang telah mendapat tablet tambah darah. Terutama pada kehamilan trimester pertama. Jumlah distribusi tablet besi folat pada bulan Januari sebanyak 822, Februari 728 dan Maret 797.

Rencana Tindak Lanjut:

- Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
- Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

5. Angka Capaian Ibu yang melakukan IMD dan Mendapat Konseling ASI Eksklusif

Bulan	Januari	Februari	Maret
Jumlah Ibu yang melahirkan dan mendapat konseling ASI Eksklusif	171	115	174

Analisis :
 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif.

Rencana Tindak Lanjut:
 Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi

6. Jumlah Balita yang mendapat imunisasi

Bulan	Januari	Februari	Maret
Jumlah balita yang mendapat imunisasi	92	84	91

Analisis:

Balita yang datang untuk melakukan imunisasi adalah balita yang telah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya imunisasi oleh dokter anak dan perawat pada saat kunjungan sebelumnya. Balita yang datang telah mendapat imunisasi lengkap meliputi imunisasi BCG, DPT 1-3, POLIO 1-3, IPV, dan Campak yang merupakan imunisasi lengkap dasar yang wajib diberikan kepada setiap balita.

Rencana Tindak Lanjut :

Memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi kepada keluarga pasien agar jumlah balita yang datang untuk imunisasi di poli anak terus meningkat untuk mendukung program pemerintah dalam pemberian imunisasi lengkap sebagai upaya pencegahan stunting.

7. Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu dan Bayi

Mendukung pemeliharaan ruangan (pojok laktasi) agar memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu menyusui.

Analisis :

Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada sukorejo.

Rencana Tindak Lanjut :

Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.

8. Pelayanan Rujukan Pasien Stunting dan Wasting

Bulan	Januari	Februari	Maret
Jumlah baduta stunting dan wasting yang dirujuk di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan Januari tidak ada pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi

Rencana Tindak Lanjut :

Tetap memberikan asuhan gizi yang baik pada pasien dengan masalah gizi Stunting, Wasting, Underweight, dan Gizi Buruk serta melakukan monitoring dan evaluasi asupan makan pasien.

IV.KUNCI INDIKATOR MUTU

INDIKATOR MUTU	Januari	Febru ari	Maret
Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada Balita	0%	0%	0%
Kepatuhan petugas melakukan KIE Kelompok pada ibu Balita 1x dalam sebulan	100%	100%	100%
Kepatuhan Pembinaan Jejaring Pengelolaan Gizi Pasien Stunting dan Wasting tiap 3 Bulan Sekali	0%	100%	0%
Kepatuhan Pencatatan Pelaporan Sesuai waktu yang di tentukan	100%	100%	100%

Analisis Kunci Indikator Mutu Stunting di Rumah Sakit Prima Husada

Pada bulan Januari prevalensi Stunting sesuai dengan target capain mutu stunting ≤14%. Pembinaan Jejaring Pengelolaan Gizi Pasien Stunting sudah dilakukan pada Triwulan I di Bulan Januari dan akan dilakukan di Triwulan berikutnya

IV. PROGNAS PKBRS

I. Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Alat Kontrasepsi
		MARET
1.	MOW	10
2.	IUD NOVA T	3
3.	IUD BKKBN (Andalan)	8
4.	IMPLANT BKKBN	-
5.	SUNTIK KB 3 BULAN BKKBN	-
6.	PIL BKKBN	-
7.	KONDOM BKKBN	-

II. Evaluasi :

- 1. Peserta MOW bulan februari 2024 sebesar 10 peserta
- 2. Peserta KB IUD Andalan 8 peserta
- 3. Peserta KB IUD nova T 3 peserta

III. Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
- 4. Melakukan edukasi kepada pasien yang akan bersalin dan pasca keguguran tentang pelayanan KB

IV. Rencana Tindak Lanjut :

Dengan adanya persiapan jika ada keterlambatan stok alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN maka Rumah sakit menyediakan obat kontrasepsi dari pihak swasta demi mencegah terjadinya kekosongan stok alat dan obat kontrasepsi

B. PELAYANAN KB PASCA SALIN DAN PASCA KEGUGURAN

I. Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien
		maret 2024
1.	MOW	10
2.	IUD	11

II. Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Keguguran

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien
		maret 2023
1.	MOW	0
2.	IUD	0

IV. Evaluasi :

Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada triwulan pertama mengalami penurunan. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada triwulan pertama meningkat setiap bulannya.

V. Analisis :

Penurunan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan dikarenakan sasaran KB sudah belum mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan. Capaian pelayanan KB pasca keguguran meningkat dikarenakan peserta sudah mengetahui pentingnya KB pasca keguguran.

VI. Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

V. PROGNAS TB DOTS

1. Fasilitas TB DOT'S

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi
1	Mikroskop	Labolatorium	1	Baik
2	Lampu Bacaradiologi	Poli Paru	1	Baik
3	Timbangan	Poli Paru	1	Baik
4	Stetoskop	Poli Paru	1	Baik
5	Exhause	Poli Paru	1	Baik
6	Spirometri	Poli Paru	1	Baik

Evaluasi:

- 1) Pada bulan januari terdapat penambahan alat spirometry.
- 2) Perlu adanya maintenance sarana dan prasarana di poli paru secara rutin.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1) Koordinasi dengan bagian IPSRS untuk kalibrasi dan servise alat penunjang medis non elektrik maupun yang elektrik sesuai jadwal yang sudah diberikan keperawatan.

2. Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Rumah sakit melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit beserta monitoring dan evaluasinya melalui kegiatan : a. Promosi kesehatan b. surveilans tuberkulosis c. pengendalian factor risiko d. penemuan dan penanganan kasus e. pemberian kekebalan f. pemberian obat pencegahan.	• Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien tentang tuberkulosis • Melakukan Observasi kegiatan • Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
2	Melakukan pelatihan pelayanan dan upaya penanggulangan tuberkulosis	• Menyusun jadwal • Membuat proposal kegiatan • Membuat undangan kegiatan • Membuat daftar hadir • Membuat materi pelatihan • Membuat soal Pre dan Post test • Membuat Notulen pelatihan • Membuat sertifikat pelatihan • Melakukan evaluasi • Membuat laporan
3	Tersedia ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis	• Melakukan Observasi kegiatan • Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
4	Tersedia ruang pelayanan rawat inap dewasa bagi pasien tuberkulosis paru yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis	• Melakukan Observasi kegiatan • Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
5	Tersedia ruang pengambilan specimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis	• Melakukan Observasi kegiatan • Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
6	Tersedia ruang laboratorium tuberkulosis yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis	• Melakukan Observasi kegiatan • Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) • Menganalisa hasil monitoring

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
		● Membuat rencana tindak lanjut ● Melakukan Evaluasi
7	Kepatuhan staf medis terhadap Panduan praktik klinis tuberculosis	● Melakukan Observasi kegiatan ● Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) ● Menganalisa hasil monitoring ● Membuat rencana tindak lanjut ● Melakukan Evaluasi
8	Terlaksana proses skrining pasien tuberculosis saat di pendaftaran	● Melakukan Observasi kegiatan ● Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) ● Menganalisa hasil monitoring ● Membuat rencana tindak lanjut ● Melakukan Evaluasi
9	Kepatuhan staf dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan pasien atau specimen	● Melakukan Observasi kegiatan ● Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) ● Menganalisa hasil monitoring ● Membuat rencana tindak lanjut ● Melakukan Evaluasi
10	Kepatuhan pengunjung terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan pasien.	● Melakukan Observasi kegiatan ● Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) ● Menganalisa hasil monitoring ● Membuat rencana tindak lanjut ● Melakukan Evaluasi
11	Rapat koordinasi dengan manajemen rumah sakit	Melaporkan hasil kegiatan pelayanan Tuberkulosis
12	Rapat koordinasi dengan IGD, Poli Penyakit Paru, Poli anak, Poli penyakit dalam, Instalasi Rawat Inap, ICU, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium	Membahas hasil mutu pelayanan Tuberkulosis dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kasus.
13	Rapat kordinasi Tim Pelayanan Tuberkulosis Rumah Sakit	Membahas kegiatan pelayanan Tuberkulosis. ● Melakukan Monitoring (oleh Tim TB) ● Menganalisa hasil monitoring ● Membuat rencana tindak lanjut ● Melakukan Evaluasi

Analisis

- 1) Melaksanakan program penanggulangan tuberculosis baik Promosi kesehatan, surveilans tuberculosis, pengendalian factor risiko, penemuan dan penanganan kasus, pemberian kekebalan serta pemberian obat pencegahan.
- 2) Adanya ruang pengambilan specimen sputum
- 3) Kepatuhan staf medis harus sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) tuberculosis
- 4) Dilakukanya rapat koordinasi Tim Pelayanan Tuberkulosis Rumah Sakit.

3. Kinerja Produktivitas

A. Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tubercolosis

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien
		Maret
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	42

Evaluasi :

- 1) Pada bulan maret 2024 ini dilakukannya promosi kesehatan dengan cara offline.

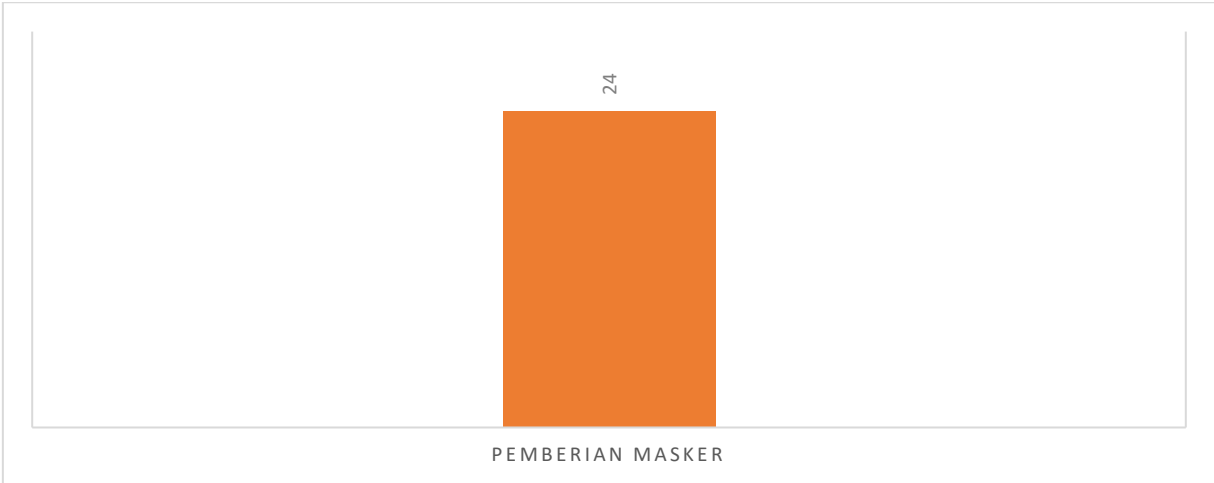
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Meningkatkan promosi Kesehatan pada pasien paru di poli tentang tuberculosis.

B. Skrining Pasien

No	Jenis Skrining	Jumlah Pasien
		Maret
1.	Pemberian Masker	40

Grafik 2
Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada
Bulan maret 2024



Evaluasi :

1) Pada bulan maret 2024 pasien sudah terbiasa memakai masker sehingga pemberian masker pada pasien sebanyak 24 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut

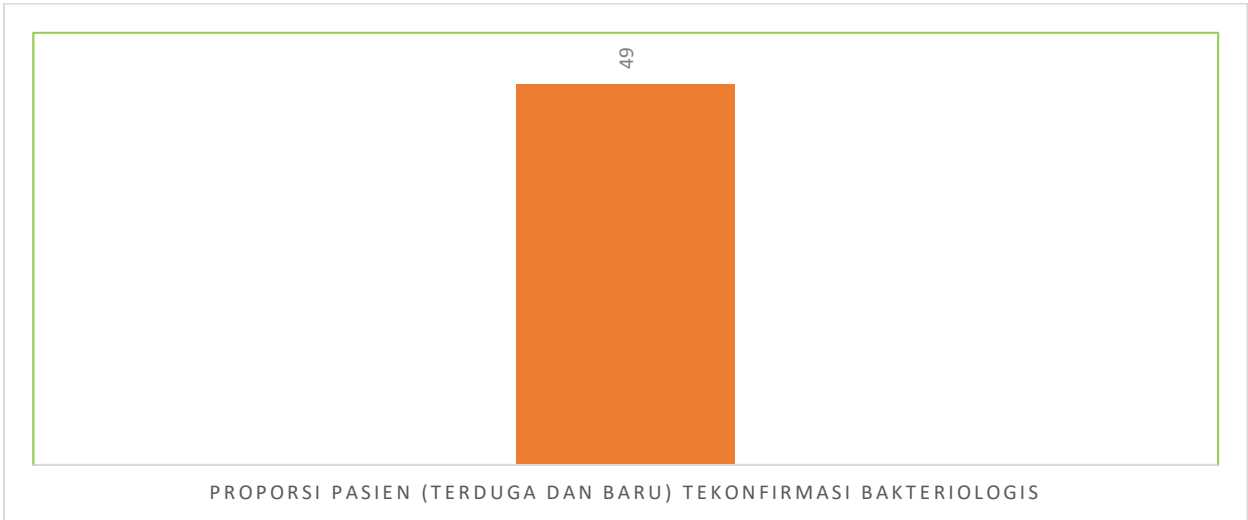
1) Memfasilitasi ketersediaan masker

2) Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

C. Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

No	Jenis skrining	Jumlah Pasien
		maret
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	49 Pasien

Grafik 3
Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Di RS Prima Husada
Bulan Maret 2024



Evaluasi :

- 1) Pada bulan November terjadi penurunan jumlah proporsi Pasien terduga TB dengan Pasien baru TB terkonfirmasi bakteriologis,

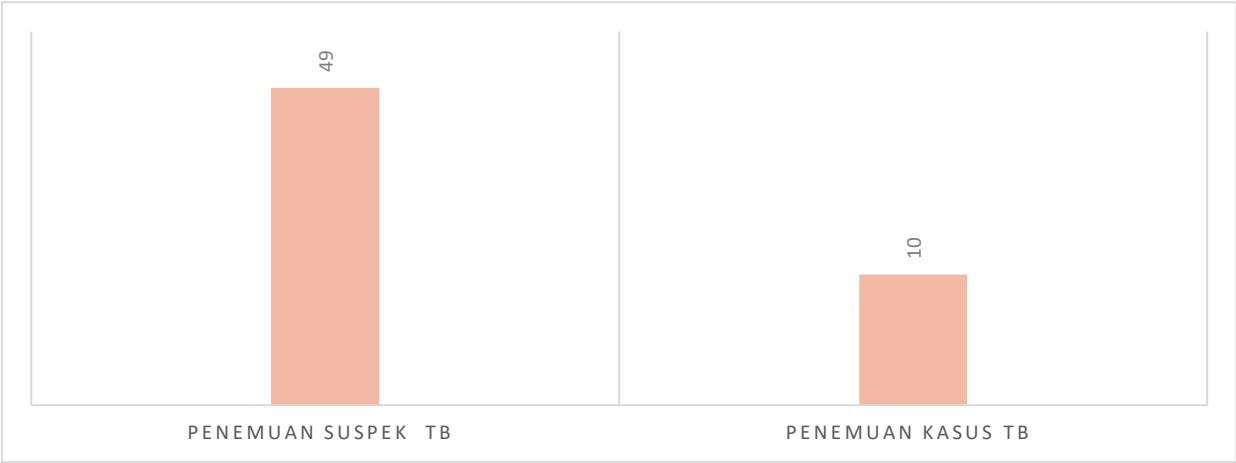
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

D. Penemuan Kasus TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		Maret
1.	Penemuan suspek TB	49
2	Penemuan kasus TB	10

Grafik 4
Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



Evaluasi

- 1) Di bulan Maret terjadi peningkatan Kembali jumlah suspek TB dan kasus TB positif.

Rencana Dan Tindak Lanjut

- 1) Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

E. Pemberian Obat Pencegahan

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		februari
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0

Grafik 5
Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima Husada februari 2024



Evaluasi :

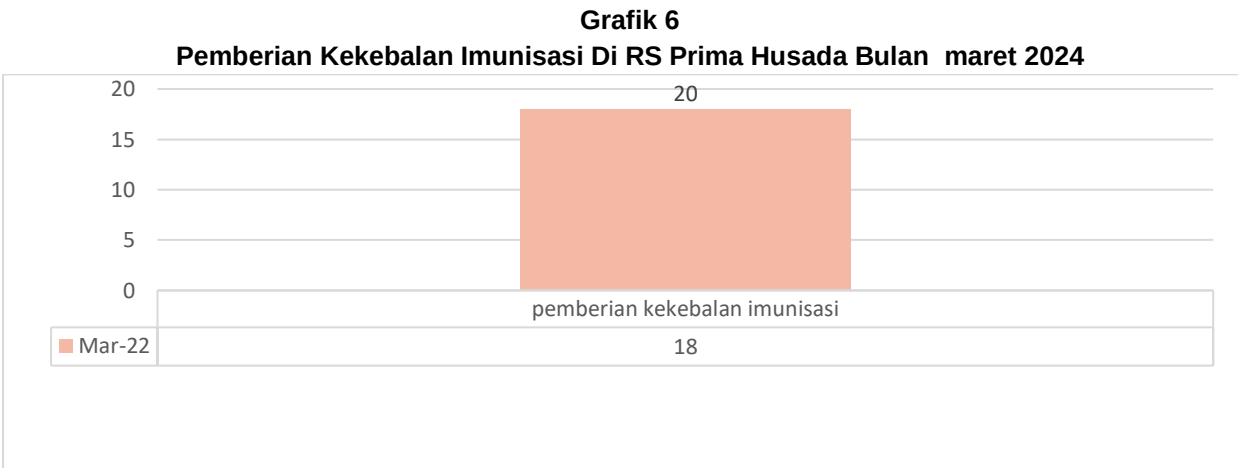
- 1) Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2) Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

F. Pemberian Kekebalan Imunisasi

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		maret
1.	Pemberian kekebalan imunisasi	20



Evaluasi :

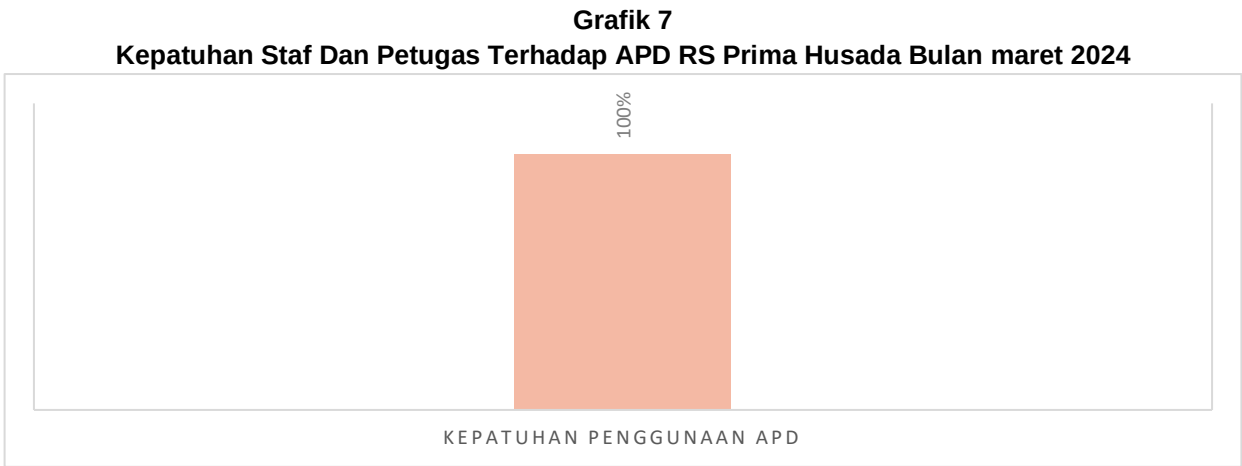
- 1) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi dibulan maret 2024 meningkat terdapat 20 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2) Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya.

G. Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		februari
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%



Evaluasi :

- 1) Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

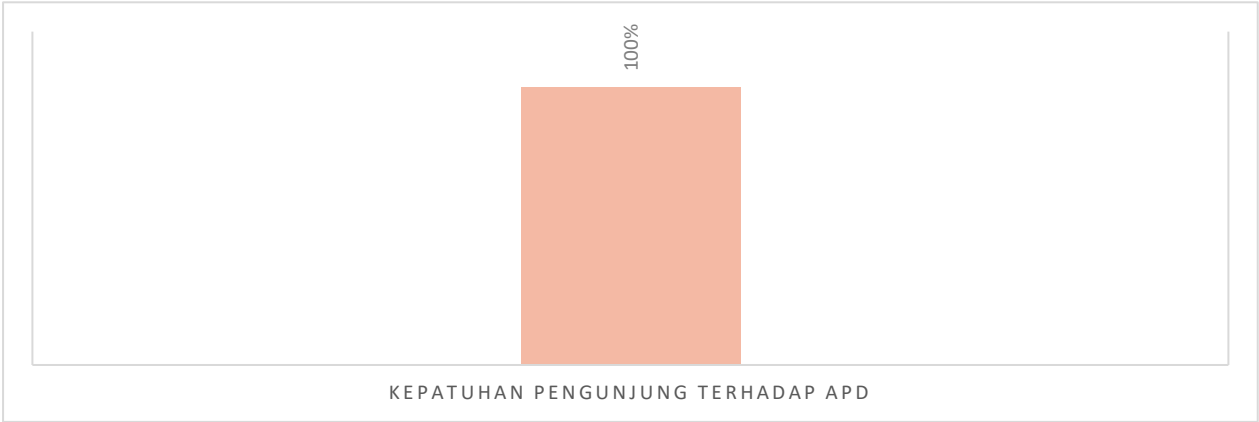
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

H. Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		maret
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%

Grafik 8
Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada Bulan maret 2024



Evaluasi :

- 1) Kemudian pada bulan maret kepatuhan terhadap penggunaan APD terus stabil dalam kepatuhan penggunaan APD

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi.

I. Penempatan Pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		maret
1.	Penempatan pasien TB	100%

Grafik 9
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan maret 2024



Evaluasi :

- 1) Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

- 2) Dari bulan ke bulan mengalami stabilitas yang baik dalam penempatan pasien TB diruang isolasi.

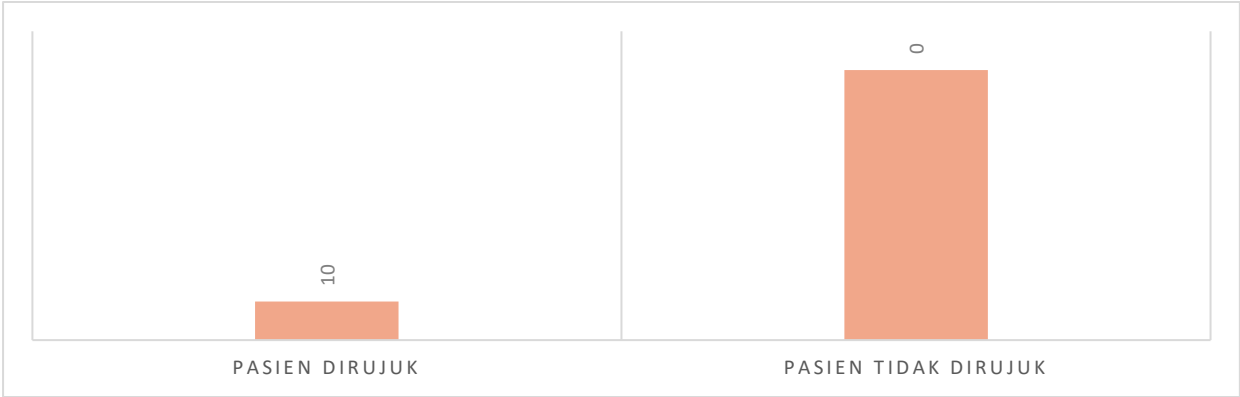
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan penempatan dengan benar

j. Pasien TB Yang Di Rujuk

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		maret
1.	Pasien TB yang dirujuk	10
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	0

Grafik 10
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Maret 2024 ada 10 pasien yg dirujuk

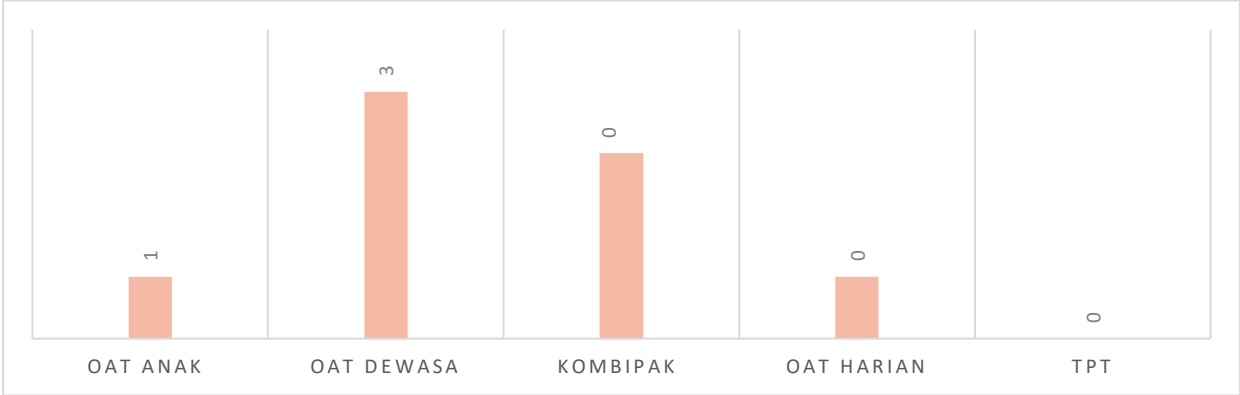
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

k. Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		maret
1.	OAT Anak	1
2.	OAT Dewasa	3
3.	Kombipak	0
4.	OAT Harian	0
5.	TPT	0

Grafik 11
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan maret 2024



Evaluasi :

1) Setiap 3 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinas kesehatan

Rencana dan Tindak Lanjut :

1) Menetapkan pengambilan obat setiap ada pasien tb baru

I. Pasien paru dan ekstra paru

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		Maret
1.	Pasien paru	6
2.	Pasien Ekstra paru	4

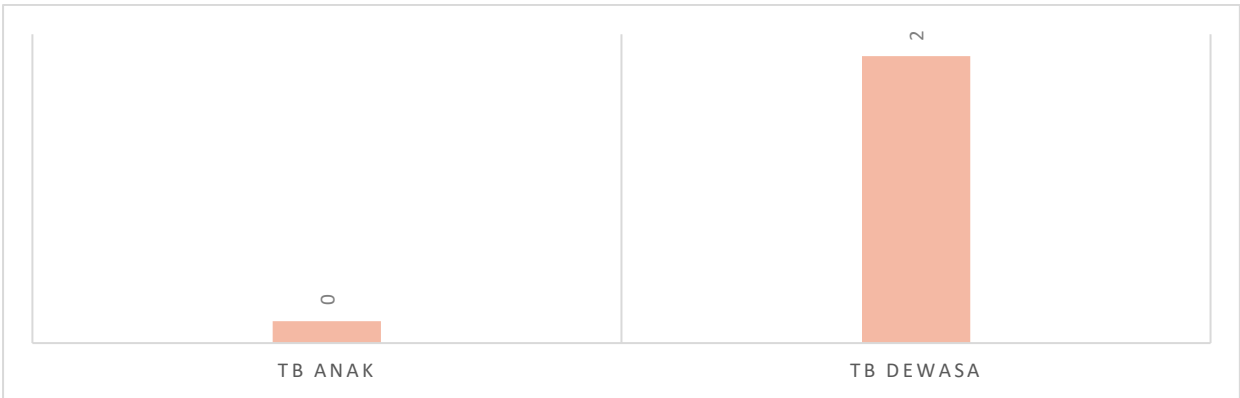
Grafik 12
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan maret 2024



m. Pasien Anak Dan Pasien Dewasa

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		Maret
1.	Pasien Anak	4
2.	Pasien Dewasa	6

Grafik 13
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan maret 2024



Evaluasi :

1) Pada bulan maret tidak ada pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

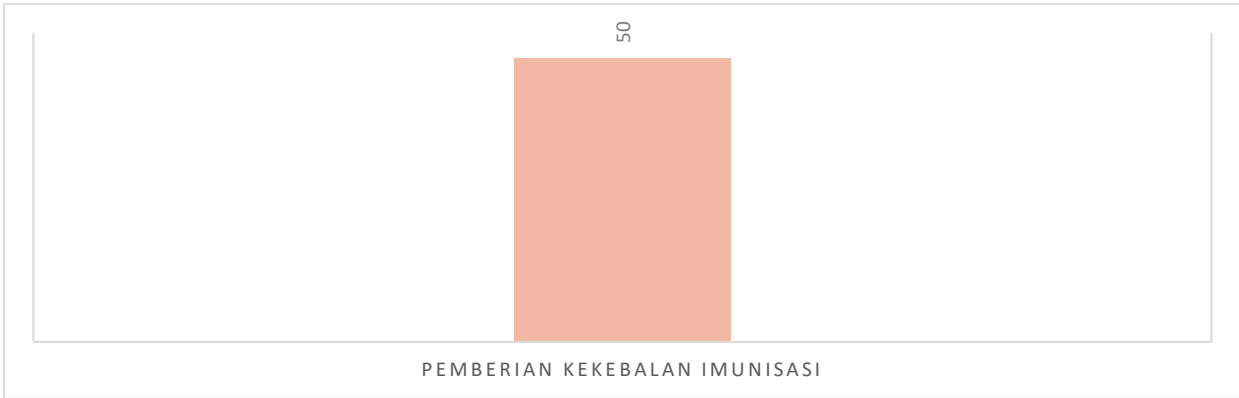
Rencana dan Tindak Lanjut :

1) Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

n. Pasien TB Keseluruhan Dengan Kategori

No	Kegiatan	Jumlah Pasien
		maret
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	50

Grafik 14
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan maret 2024



- Evaluasi :
- 1) Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC
- Rencana dan Tindak Lanjut :
- 1) Mempertahankan penempatan dengan benar

o. Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1	dr. Novita Maulidya, Sp. P	Tn. A	V		
		Tn. R	V		
		Tn. W	V		
2	dr. Fitri Indahyanti, Sp. P	Tn.. H	V		
		Ny. T	V		
		Ny. F	V		
		Ny. S	V		

- Evaluasi :
- 1) Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan.
- Rencana dan Tindak Lanjut :
- 1) Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Sukorejo

4. Mutu

No	Pengukuran mutu	Standar	Hasil
1	Angka pasien terkonfirmasi bakteriologis Bulan Maret 2024	100%	11

- Analisis
- 1) Terjadi penurunan angka pasien tenkonfirmasi bakteriologis pada bulan februari yang diiringi dengan peningkatan jumlah tes TB, hal ini berdampak positif karena banyaknya pasien yang sadar akan pentingnya skrinning TB ketika pasien memiliki gejala batuk dan sesak nafas dan terjadi peningkatan pada bulan Juni.
- Rencana tindak Lanjut
- 1) Tetap mempertahankan angka penurunan pasien tenkonfirmasi bakteriologis yang diiringi dengan peningkatan jumlah tes TB

5. Evaluasi Jadwal Kegiatan Instalasi

Jadwal kegiatan Instalasi bulan ini adalah:

No	Kegiatan	Pemenuhan*
1	Validasi Laporan TB DOTS Bulan Maret 2024	Sesuai jadwal
2	Order OAT dan BHP TB DOTS	Sesuai jadwal

- Pemenuhan diisi dengan: sesuai jadwal/ditiadakan/direncanakan mundur/dijadwal ulang/dst.

Analisis

- 1) Validasi laporan dan pengorderan OAT dan BHP TB DOTS dilakukan sesuai dengan jadwal dan keperluan

Rencana Tindak Lanjut

- 1) Pengorderan obat TB dilakukan oleh Tim IFRS, sehingga harus selalu difasilitasi oleh ambulance saat melakukan permintaan OAT dan BHP TB DOTS

H. Kemajuan Piutang

a. Data Piutang yang Belum Terbayar Bulan Maret

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
											0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	
		a	b	c	(a-b-c= d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h						Total
	PERIODE MARET 2024 :															
1	Asuransi	299.355.334	166.336.848	2.798.971	130.219.516	250.361.489	69.715.320	1.784.982	178.861.187	309.080.703	286.856.102	1.109.304	18.792.022	-	2.323.276	309.080.703
2	Perusahaan	261.755.100	234.277.907	5.237.864	22.239.330	153.315.512	89.068.510	6.806.376	57.440.626	79.679.955	79.590.456	89.500	-	-	-	79.679.956
3	Mandiri Inhealth	67.844.936	48.659.684	4.673.156	14.512.096	20.064.767	-	-	20.064.767	34.576.863	34.576.863	-	-	-	-	34.576.863
4	Jasa Raharja	190.119.398	190.119.397	1	0	239.943.438	134.245.104	1	105.698.333	105.698.333	105.698.333	-	-	-	-	105.698.333
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.832.469.986	451.214.360	- 189	1.381.255.815	432.467.486			432.467.486	1.813.723.301	1.807.860.498	949.222	-	2.798.532	2.115.049	1.813.723.301
									Total Saldo	2.342.759.156	2.314.582.252	2.148.026	18.792.022	2.798.532	4.438.325	2.342.759.156

b. Update IKS

NO	INSTANSI	BERLAKU MULAI	BERAKHIR SAMPAI	LINGKUP	TENTANG	KET
1	RS PRIMA HUSADA MALANG	01/10/2022	01/10/2025	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	SUDAH ADA FILE PKS
2	RS BHAYANGKARA PUSDIK BRIMOB	06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PELAYANAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI	SUDAH ADA FILE PKS
3	RS MITRA SEHAT MEDIKA	06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
4	RSI MASYITOH BANGIL	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
5	RS ASIH ABYAKTA	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
6	RS SAHABAT	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
7	PMI KAB. PASURUAN	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
8	IDI CAB KAB. PASURUAN	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
9	IBI CAB KAB. PASURUAN	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
10	ASKLIN PASURUAN RAYA	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
11	PPNI CAB KAB. PASURUAN	'06/09/2022	06/09/2027	FASKES	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH ADA FILE PKS
12	KLINIK IDAMAMUK	16/06/2021	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	FILE SCAN
13	PUSKESMAS SUKOREJO (PENANGGULANAGAN TB, HIV/AIDS)	22/01/2019	22/01/2024	FASKES	PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKOLOSIS (TB) DAN HIV/AIDS	FILE SCAN

14	RS PERSADA HOSPITAL	10/10/2022	10/10/2027	FASKES	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
15	RSUD BANGIL KAB. PASURUAN	14/01/2019	31/12/2024	FASKES	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
16	RSUD BANGIL KAB. PASURUAN (PA)	12/04/2021	12/04/2024	FASKES	PEMERIKSAAM LABORATORIUM (PATOLOGO ANATOMI)	FILE SCAN
17	RSUD SAIFUL ANWAR MALANG (ADDENDUM KE-1)	23/04/2021	23/04/2024	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN	FILE SCAN
18	PERSADA HOSPITAL	10/10/2022	10/10/2027	FASKES	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
19	PT PRODIA WIDYAHUSADA	03/05/2021	02/05/2024	FASKES	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SAPEL DARAH	FILE SCAN
20	PMI KAB. PASURUAN	01/01/2019	19/01/2024	PMI	PELAYANAN DARAH TRANSFUSI (PASIEEN BPJS & ASURANSI)	FILE SCAN
21	PMI KAB. SIDOARJO	01/10/2021	30/09/2026	PMI	PELAYANAN DARAH	FILE SCAN
22	DINAS KB & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB.PASURUAN(BKKBN)	11/01/2021	31/12/2024	KOMUNITAS	PERMBERIAN ALAT KONTRASEPSI	FILE SCAN
23	DISPENDUKCAPIL PASURUAN (BUPATI)	19/08/2022	19/08/2027	KOMUNITAS	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK (AKTA KKELAHIRAN, AKTA KEMATIAN, KK, KIA)	FILE SCAN
24	FATAYAT NU ANAK CABANG SUKOREJO	18/01/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	KOMUNITAS	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DUTA ONLINE PEDULI IBU DAN ANAK (DOLINA)	File Terbaru 2022 di kak Sufi
25	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)	25/05/2019	31/12/2024	KOMUNITAS	PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDAN	FILE SCAN
26	MUSLIMAT ANAK CABANG SUKOREJO	18/01/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	KOMUNITAS	PROGRAM KESEHATAN USIA LANJUT (F-KUL)	FILE SCAN
27	KEMENTRIAN AGAMA (KEMENAG) KAB.PASURUAN	03/01/2019	31/12/2022	KOMUNITAS	BIMBINGAN DAN EDUKASI PELAYANAN KEROHANIAN	FILE SCAN

28	DINKES KAB. PASURUAN PENANGGULANGAN TB	01-01-2019	01-01-2024	KOMUNITAS	PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKOLOSIS (TB)	FILE SCAN
29	PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)	19/01/2019	19/01/2024	KOMUNITAS	PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERAWAT	FILE SCAN
30	LIPPO GENERAL INSURANCE	18/09/2019	18/09/2024	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
31	PT AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR)	28/02/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
32	PT ASTRA AVIVA LIFE	18/05/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
33	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA	15/07/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
34	PT ASURANSI ASTRA BUANA	01/09/2020	31/08/2024	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
35	PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA - ADMEDIKA	13/04/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	HARD FILE
36	PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA (MANDIRI INHEALTH)	01/02/2021	31/01/2024	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
37	PT ASURANSI JIWASRAYA	13/02/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
38	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA (ASURANSI MAG)	18/11/2019	27/01/2024	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
39	PT ASURANSI RELIANCE	20/08/2019	19/08/2024	ASURANSI	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	FILE SCAN
40	PT ASURANSI SINAR MAS	04/09/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP	FILE SCAN

41	PT FWD LIFE INDONESIA	21/10/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
42	PT INOVA CARE INDONESIA	13/01/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
43	PT INTERNATIONAL SERVICES PACIFIC CROSS (ASURANSI)	03/10/2022	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	HARD FILE
44	PT LIPPO GENERALI INSURANCE	18/09/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
45	PT PAN PACIFIC INSURANCE	31/08/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
46	SINARMAS	04/09/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP	SOFT FILE SCAN TIDAK ADA
47	PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL (APLN)	30/10/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN (PENGobatan)	FILE SCAN
48	PT ASURANSI JASA INDONESIA	28/08/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
49	LIPPO GENERAL INSURANCE	18/09/2019	18/09/2024	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
50	PT TIRTA SUKSES PERKASA CLUB	09/01/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	RUJUKAN ASUHAN PASIEN	FILE SCAN
51	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	27/10/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
52	PT UNIPLASTINDO INTERBUANA	08/06/2021	08/06/2024	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
53	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA (YEMI)	04/01/2021	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN

54	PT INDO ANEKA ATSIRI PANDAAN	27/10/2022	27/10/2024	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
55	PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA (JAI)	01/06/2021	30/05/2024	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
56	KUD SUMBER REJO SAMPOERNA SKJ	09/01/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
57	PT CISAURA MOUNTAIN DAIRY (COB-BPJS)	02/06/2020	02/06/2024	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	SDH FU VIA WA DAN BERJALANAN SAMPAI 2024
58	PT PLN (APLN)	24/02/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
59	PT AMERTA INDAH OTSUKA	05/04/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
60	PT DUTA PUTRI BERSAUDARA	20/02/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
61	PT HANJAYA MANDALA SAPOERNA TBK	2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
62	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR CBP MAKMUR	27/07/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
63	PT KARYA MANUNGGA JATI	27/08/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
64	PT KARYA SUTARINDO	12/08/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
65	PT KARYA TUGAS ANDA	13/02/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
66	PT NAYAKA ERA HUSADA	28/01/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN

67	PT PHILLIP MORRIS INDONESIA	2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
68	PT PHILLIP MORRIS SAMPOERNA INTERNATIONAL SERVICE CENTER (PMSISC)	2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
69	PT SAMPOERNA INDONESIA SEMBILAN	2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
70	PT SUPRA ALUMUNIUM	20/04/2020	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
71	BPJS KESEHATAN	01/12/2020	31/12/2024	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN	SUDAH PERPANJANG
72	BPJS KETENAGAKERJAAN	15/12/2024	31/12/2024	ASURANSI	PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH PERPANJANG
73	PT YAMINDO	22/08/2019	SAMPAI ADANYA PEMBERITAHUAN TERTULIS	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
74	PT YAZAKI	01/06/2021	30/05/2024	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
75	PT YANMAR	01/04/2022	01/04/2024	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN
76	KLINIK AISYIYAH PANDAAN	06/09/2022	06/09/2027	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN	Sudah komitmen bersama ada file
77	KLINIK ANDAMARI	06/09/2024	06/09/2027	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN	Sudah komitmen bersama ada file
78	KLINIK DAHLIA	06/09/2024	06/09/2027	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN	Sudah komitmen bersama ada file
79	KLINIK KESIRA WARASBLAS	06/09/2025	06/09/2027	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN	Sudah komitmen bersama ada file

80	RS ASIH ABYAKTA	06/09/2022	06/09/2027	FASKES	RUJUKAN ASUHAN PASIEN	Sudah komitmen bersama ada file
81	RS BHAYANGKARA BRIMOB	06/09/2022	06/09/2027	FASKES	LABORATORIUM DAN RADIOLOGI	Sudah komitmen bersama ada file
82	RS SAHABAT	06/09/2022	06/09/2027	FASKES	RUJUKAN PASIEN DAN PENUNJANG	Sudah komitmen bersama ada file
83	PT YAMINDO/YADIN	01/4/2022	01/04/2024	PERUSAHAAN	PELAYANAN KESEHATAN	FILE SCAN

BAB IV
DATA UTILITAS UNIT

A. Pelayanan Medis

1. Tabel Data Kamar Operasi Bulan Februari Tahun 2024

No	Jenis Operasi	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Jumlah
1	Kecil	0	20	0	0	0	20
2	Sedang	1	94	0	1	0	96
3	Besar	3	214	7	2	5	231
4	Khusus	2	63	9	0	6	80

2. 10 Tindakan Operatif Bulan Maret Tahun 2024

No	Deskripsi	Jumlah
1	Sectio Caesarea	91
2	Excisi	56
3	Debridement	48
4	URS	35
5	Phaco	30
6	ORIF	27
7	Herniotomy	24
8	Eksterpasi dan Graft	20
9	TURP	19
10	Laparotomy	13

3. 10 Besar Diagnosa Operatif Bulan Maret Tahun 2024

No	Deskripsi	Jumlah
1	Soft Tissue Tumor	45
2	Hidronefrosis + Batu Ureter	30
3	Katarak	30
4	Diabetic Foot	28
5	Gravida dengan Penyulit BSC	25

6	Hernia	24
7	Pterygium	20
8	BPH	19
9	Gravida dengan Penyulit Kala 1 Fase Laten	19
10	Gravida dengan Penyulit KPD	15

4. Data Instalasi Rawat Jalan Bulan Maret Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Umum		BPJS Kes		BPJS TK		MCU		Jasa Raharja		Asuransi Swasta		Perusahaan		Total		Total
		Px Baru	Px Lama	Px Baru	Px Lama	Px Baru	Px Lama	Px Baru	Px Lama	Px Baru	Px Lama	Px Baru	Px Lama	Px Baru	Px Lama	Px Baru	Px Lama	
1	Anak	62	294	29	446	0	0	0	0	0	0	5	58	0	0	96	798	894
2	Saraf	8	32	47	1490	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	55	1533	1588
3	Penyakit Dalam	51	57	53	2020	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	109	2103	2212
4	Bedah Umum	13	35	68	611	0	5	0	0	0	3	0	5	0	0	81	659	740
5	Orthopedi	11	21	18	235	2	43	0	0	0	5	1	5	0	0	32	309	341
6	Kandungan	99	300	51	333	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	151	645	796
7	Mata	8	21	54	720	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	63	747	810
8	Jantung	6	16	22	869	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	28	897	925
9	Jiwa	0	9	17	234	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	17	245	262
10	THT	20	21	38	107	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	60	134	194
11	Kulit dan Kelamin	7	14	27	172	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	37	191	228
12	Rehab Medik	0	1	0	380	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	383
13	Paru	4	19	10	591	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	14	613	627
14	Urologi	7	23	30	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	431	468
15	Gigi Spesialist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bedah Plastik	0	2	0	26	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	34	34
17	Bedah syaraf	0	0	0	9	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	14
18	Gigi umum	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	12	12
19	Umum dan MCU	8	28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	14	35	49

20	Konservasi Gigi	0	0	7	31	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	8	33	41
21	Komplementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bedah Anak	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Total		304	900	471	8697	2	54	0	0	0	17	19	161	6	3	802	9832	10634

5. Data Kunjungan Rawat Inap Bulan Maret Tahun 2024

No	Kelas Perawatan	Jumlah Pasien							
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Perusahaan	BPJS Iktu Ibu	Total
1	VVIP	0	0	0	0	0	0	0	0
2	VIP	9	15	0	10	1	15	0	50
3	Kelas I	5	295	0	12	1	0	0	313
4	Kelas 2	8	53	22	1	0	0	0	84
5	Kelas 3	20	651	0	0	10	0	0	681
6	ICU	0	21	0	0	1	0	0	22
7	Maternitas	4	171	0	0	0	0	0	175
8	Perinatologi	3	27	0	0	0	0	86	116
9	NICU	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Isolasi	1	65	0	1	0	0	0	67
11	ICU COVID	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		50	1298	22	24	13	15	86	1508

6. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD) Bulan Maret Tahun 2024

a. Kunjungan Berdasarkan Cara Bayar

No	Keterangan Cara Bayar	Jumlah
1	BPJS	1220
2	JKK	36
3	UMUM	131
4	Asuransi Lain	68
5	Perusahaan	12
Total		1484

b. Kunjungan Berdasarkan Status Pasien

No	Status Pasien	Jumlah	Keterangan
1	Rawat jalan	110	-
2	Rawat inap	1384	-
3	Rujuk	17	1. RSUD Bangil (6) 2. RS Soetomo Surabaya (4) 3. RSSA Malang (3) 4. RS Karsa Husada Batu (2) 5. RS Siloam (1) 6. RS Lavalet (1)
4	Meninggal	19	-
5	APS	5	Dengan alasan terbanyak adalah tidak mau di rujuk ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

B. Penunjang Medis

3.1 INSTALASI LABORATORIUM

Tabel 3.1.1 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Bulan Maret 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Hematologi	1.937	2.069	2.417
2.	Faal Hemostasis	985	945	874
3.	Fungsi Hati	514	551	525
4.	Lemak Darah	361	438	352
5.	Ginjal Hipertensi	1.383	1.466	1.520
6.	Gula Darah	2.445	2.277	2.679
7.	Jantung	626	524	619
8.	Elektrolit	808	764	979
9.	Imunoserologi	480	452	578
10.	Endokrinologi	95	72	70
11.	Reproduksi	39	27	34
12.	Urinalisis	315	343	332
13.	Analisa Feses	26	22	11
14.	Tumor	6	9	6
15.	Mikrobiologi	11	23	5
16.	Rapid Covid-19	149	120	96
17.	Swab PCR Covid-19	4	0	0
Total		10.341	10.102	11.097

Analisa:
Pemeriksaan laboratorium mengalami kenaikan pada pemeriksaan rutin, hal ini diakibatkan oleh peningkatan kunjungan pada pasien rawat jalan maupun rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut:
Mempertahankan pelayanan laboratorium yang sudah berjalan dengan penyesuaian stok laboratorium.

Tabel 3.1.2 Jumlah Sampel Lab Dirujuk Berdasarkan Jenis Pemeriksaan Bulan Maret 2024

No	JENIS PEMERIKSAAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	PCR Swab	4	0	0
2	FNAB	15	14	16
3	HISTO PA	133	131	104
4	SITOLOGI	0	1	0
5	PAP SMEAR	2	2	0
TOTAL		154	148	120

Analisa:
Pemeriksaan rujukan yang dikirim mengalami penurunan dibandingkan pada bulan sebelumnya .

Rencana Tindak Lanjut:
Pemeriksaan yang dirujuk diharapkan bisa di buat acuan untuk pemeriksaan sendiri tanpa dirujuk ditempat rujukan.

Tabel 3.1.3 Jumlah Sampel Dirujuk Berdasarkan Rumah Sakit Rujukan Bulan Maret 2024

NO	RUMAH SAKIT	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	RS Prima Husada Malang	10	20	10
2	RSSA	14	21	34
3	RSUD Bangil	1	2	2
4	RS Lavallete	3	0	0
TOTAL		28	43	46

Analisa:
Rujukan sampel terbanyak dikirim ke RS Saiful Anwar karena kelengkapan layanan, selanjutnya RS Prima Husada Malang yang masih berada dalam satu naungan PT dengan RS Prima Husada Sukorejo, dan selanjutnya adalah ke RSUD Bangil karena dekat jangkauannya.

Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan penambahan jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan secara mandiri di RS Prima Husada Sukorejo dengan mempertimbangkan ketersediaan alat yang sudah tersedia, jumlah reagen sekali pemesanan dan jumlah pasien yang telah melakukan dan perkiraan yang akan melakukan pemeriksaan di RS Prima Husada Sukorejo.

Tabel 3.1.4 Jumlah Pemakaian Kantong Darah di BDRS Bulan Maret 2024.

NO	JENIS GOLONGAN DARAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	A	8	16	8
2.	B	23	20	11
3.	O	32	51	37
4.	AB	0	1	0
TOTAL		63	88	56

Analisa:
Jumlah permintaan kebutuhan kantong darah didapatkan menurun dari bulan sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut:
Penyesuaian stok darah yang dilakukan oleh staff laboratorium terkait kebutuhan kantong darah.

Tabel 3.1.5 Jumlah Kejadian Kerusakan Darah di BDRS Bulan Maret 2024

NO	JENIS GOLONGAN DARAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	A	0	0	0
2.	B	0	0	0
3.	O	0	0	0
4.	AB	0	0	0
Total		0	0	0

Analisa:
Tidak ada kejadian kerusakan kantong darah di BDRS selama 3 bulan terakhir.

Rencana Tindak Lanjut:
Mempertahankan angka capaian tidak adanya kejadian kantong darah di BDRS. Namun perlu dipertimbangkan untuk kejadian pemesanan kantong darah ke BDRS yang tidak jadi dipakai dan apabila melewati tanggal kadaluarsa belum terpakai juga akan menjadi beban biaya.

3.2 INSTALASI GIZI

Tabel 3.2.1 Jumlah Pemesanan Diit Bulan Maret 2024

No	Nama Diit	Januari	Februari	Maret
1.	Diabetes Mellitus	197	182	194
2.	Rendah garam	221	234	26
3.	Jantung	32	48	39
4.	Rendah serat	520	498	502
5.	TKTP	492	503	551
6.	Makanan Biasa	-	-	-
7.	Makanan Lunak	-	-	-
8.	Rendah Lemak	146	184	197
9.	Rendah Protein	85	74	93
10.	Bubur Halus	33	29	21
11.	Cair	61	78	69
12.	Rendah Purin	48	31	54
13.	Tinggi Protein	-	-	-
14.	Blender	22	19	15
Total		1.857	1.880	

Analisa:
Jumlah pemesanan diit secara keseluruhan meningkat disbanding dengan bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada peningkatan jumlah pasien rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut:
Meningkatnya jumlah permintaan berkaitan dengan peningkatan jumlah bahan makanan. Hal ini perlu diantisipasi dengan penyimpanan bahan makanan terutama yang mudah rusak.

Tabel 3.2.2 Jumlah Konsultasi Gizi Berdasarkan Jenis Kunjungan BulanMaret 2024

NO.	KONSULTASI GIZI	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Rawat Inap	1.549	1.498	1.704
2	Rawat Jalan	32	28	34
Total		1.581	1.526	1.738

Analisa:
Terjadi peningkatan jumlah konsultasi yang dilakukan oleh Ahli Gizi baik rawat inap dan rawat jalan. Hal ini dikarenakan peningkatn jumlah kunjungan baik rawat inap dan rawat jalan.

Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan evaluasi terkait inovasi untuk terus meningkatkan konsultasi rawat jalan secara aktif. Hal ini didukung dengan penambahan jenis pelayanan konsultasi menggunakan whatshaap massanger secara personal ke pasien.

3.3 UNIT STERILISASI

Tabel 3.3.1 Jumlah Penggunaan Mesin Sterilisasi Bulan Maret 2024

N o	JENIS ALAT STERILISAIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Memert	192 x	170x	195x
2	Autoclave	17 x	12x	14x

Analisa:
Terjadi peningkatan jumlah penggunaan mesin sterilisasi dibandingkan bulan lalu. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah kunjungan rawat inap dan operasi di IKO.

Rencana Tindak Lanjut:
Mempertimbangkan ketersediaan instrument apabila terjadi peningkatan penggunaan mesin sterilisasi, hal ini bisa berdampak pada peningkatan penggunaan listrik.

Tabel 3.3.2 Jumlah Produksi Kassa Steril Bulan Maret 2024

No	Jenis Kassa	Januari	Februari	Maret
1	Kassa IKO	330 pouches	330 pouches	330 pouches
2	Kassa Deepress	190 pouches	190 pouches	190 pouches
3	Kassa Bigkass	120 pouches	120 pouches	120 pouches
4	Kassa Tampon Inferior	40 pouches	40 pouches	40 pouches
5	Kassa Tampon Posterior	40 pouches	40 pouches	40 pouches
6	Kassa Ruangan	320 pouches	320 pouches	320 pouches

Analisa:
Jumlah produksi oleh Unit Sterilisasi ke Farmasi memang tidak ada perubahan walaupun kunjungan meningkat. Namun frekuensi permintaan unit ke unit farmasi menjadi lebih pendek sehingga penyiapan banyak yang terjadi di luar jadwal yang telah disepakati.

Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan evaluasi terkait penggunaan kassa di tiap unit dan mengantisipasi unit yang sering meminta kassa diluar jadwal.

3.4 UNIT LAUNDRY

Tabel 3.4.1 Jumlah Pencucian Linen Bulan Maret 2024

NO	JENIS LINEN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Linen Infeksius	4.436,6	4.326,1	4.686,5
2	Non Infeksius	1.195,0	866,5	1.114,8
Total		5.621,6	5.192,6	5.801,3

Analisa:
Terjadi peningkatan pencucian linen baik linen infeksius dan non infeksius. Hal ini dikarenakan peningkatn jumlah kunjungan baik rawat inap dan rawat jalan.

Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan evaluasi terkait jumlah persediaan stock linen di Unit dan Laundry. Serta melakukan evaluasi terkait jumlah penyediaan chemical yang akan digunakan.

Tabel 3.4.2 Jumlah Penggunaan Chemical Bulan Maret 2024

No	JENIS CHEMICAL	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Chemical Clax Buit Lite	20	20	20
2.	Chemical Clax 100 Ob	20	50	30
3.	Chemical Clax Sunril Ultra	50	25	50
4.	Chemical Clax Soft	50	30	35
5.	Pewangi Kispray (300 ml)	12,5	5	5

Analisa:
Penggunaan chemical berdasarkan jenis fluktuatif setiap bulannya. Dikarenakan jumlah kunjungan rawat inap, rawat jalan dan operasi di IKO yang meningkat seharusnya semua jenis chemical juga meningkat.

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu dilakukan evaluasi penggunaan chemical penyebab fluktuatifnya di masing-masing jenis.

3.5 UNIT REKAM MEDIS

Tabel 3.5.1 Indikator Kinerja Rumah Sakit Bulan Maret 2024

Indikator	Januari	Februari	Maret
BOR	79.21	81.18	90.77
ALOS	3.30	3.32	3.43
TOI	0.62	0.54	0.25
BTO	10.46	10.13	11.48

Analisa:
Terjadi peningkatan capaian BOR, ALOS, BTO dan penurunan pada TOI hal ini disebabkan peningkatan kunjungan rawat inap pada bulan Maret 2024. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan standar Depkes.

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu dilakukan evaluasi terkait ketersediaan jumlah tempat tidur.

3.6 INSTALASI RADIOLOGI

Tabel 3.6.1Jumlah Pemeriksaan Radiologi Berdasarkan Jenis Bulan Maret 2024

Jenis Pemeriksaan		Januari	Februari	Maret
USG	Abdomen/Urologi	414	347	320
	Abdomen Cito	2	-	-
	Thorax	2	-	2

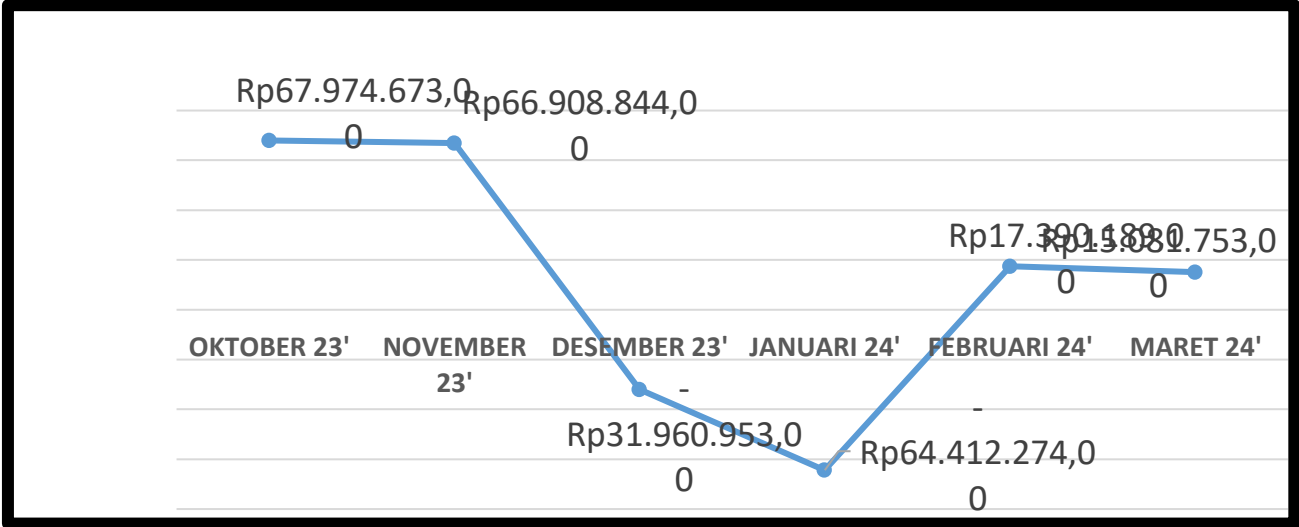
	Mammae	10	8	6
	Thyroid/Colli	41	-	32
	Testis	17	-	12
	Parotis	-	-	-
	Vaskuler	3	6	2
	Ankle	-	-	-
	Femur	-	-	-
	Kepala	3	-	1
	Mandibula	-	1	1
	Total	492	362	376
RADIO DIAGNOSTIK	Skull	12	13	13
	Thorax	998	980	1.115
	Extermitas Atas	129	98	96
	Extermitas Bawah	103	112	108
	Kub/Bno	134	112	105
	Pelvis	17	18	15
	Babygram	27	25	23
	Cervical	4	1	3
	Thoracolumbal	2	3	4
	Lumbosacral	70	55	74
	Ivp + Kontras	-	-	-
	Uretrografi	-	-	-
	Colon In Loop	-	-	-
	Panoramic	8	13	14
	Waters	11	3	1
	Total	1.515	1433	1.571
CT SCAN	Kepala	101	57	102
	Kepala Dengan Kontras	6	1	4
	Kepala Trauma	30	10	42
	Thorax	-	-	-
	Thorax Dengan Kontras	-	-	-
	Abdomen	4	-	1
	Abdomen Dengan Kontras	1	-	-
	Pelvis	-	-	-
	Vertebrae	-	-	-
	Cervical Vertebrae	-	-	-
	Lumbosacral	-	-	-
	Thoracal Vertebrae Non Kontras	-	-	-
	Thorax Vertebrae	-	-	-
	Cruris	-	-	-
	Lumbosacral Vertebrae	-	-	-
	Ekstermitas Lain	-	-	-
	Total	142	68	149

Analisa:
 Secara keseluruhan berdasarkan jenis pemeriksaan radiologi jumlahnya meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh jumlah kunjungan yang meningkat baik rawat inap dan rawat jalan. Walaupun sempat ada kerusakan sikring pada CT Scan sehingga menyebabkan merujuk ke RS lain untuk melakukan CT Scan beberapa hari.

Rencana Tindak Lanjut:
Meningkatkan pelayanan di Radiologi dengan menjaga sarana dan prasarana, melakukan maintanance rutin bekerjasama dengan Tim IPSRS.

3.7 INSTALASI FARMASI

Grafik 3.7.1 Laporan Hasil Stok Opname Bulan Maret 2024



Analisa:
Didapatkan hasil stok opname pada bulan Maret 2024 selisih lebih Rp 15.081.753. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal utama:
a. Kartu Stock yang tidak ditulis saat barang masuk ataupun keluar.
b. Ketidakpahaman staf farmasi terkait peletakan buffer stok.

Rencana Tindak Lanjut:
Meningkatkan kepatuhan staf dalam penulisan kartu stok, untuk melakukan penilaian keakuratan monitoring menggunakan sistem.

Tabel 3.7.1 Jumlah Pelayanan Resep Bulan Maret 2024

No	BULAN	JENIS RESEP DEPO FARMASI 2024						TOTAL RESEP
		Umum		BPJS		Asuransi Swasta		
		Racikan	Non Racikan	Racikan	Non Racikan	Racikan	Non Racikan	
2	JANUARI	373	2.151	2.564	21.013	0	200	26.301
		2.524		23.577		200		
3	FEBRUARI	356	1.777	2.333	19.272	6	358	24.102
		2.133		21.605		364		
4	MARET	422	2.236	2.726	21.313	0	197	27.091
		2.658		24.039		394		

Analisa:
Didapatkan peningkatan pelayanan resep secara signifikan pada bulan Maret dibandingbulan sebelumnya hal ini dikarenakan jumlah kunjungan juga meningkat baik BPJS, Umum ataupun Asuransi lainnya.

Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan evaluasi terkait waktu tunggu ketika terjadi peningkatan jumlah resep namun jumlah SDM terbatas.

I. MONITORING DAN EVALUASI

Tabel 4.1 Supervisi Bidang Penunjang Bulan Maret 2024

NO	MONITORING	EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	SDM (Staf)	Instalasi Laboratorium	
		- Adanya IKP KTC ketidaksesuaian penginputan hasil	- Perlu dilakukan <i>double cross check</i> sebelum melakukan Tindakan.

		laboratorium dan identifikasi pasien yang kurang benar.	Mengingatkan staf yang bersangkutan.
		Instalasi Gizi	
		- Adanya staf sakit dan cuti melahirkan,	- Dilakukan perbantuan dari Unit CS Pantry berkoordinasi dengan SDM dan Kepala Unit CS.
		Unit Sterilisasi	
		- SDM kurang 1 orang.	- Pengajuan SDM, sudah dilakukan rekrutmen per April 2024 staf orientasi masuk.
		Unit Laundry	
		- Adanya staf sakit secara bersamaan.	- Dilakukan perbantuan dari Unit CS berkoordinasi dengan SDM dan Kepala Unit CS.
2.	Produktivitas Kinerja Laboratorium	Instalasi Laboratorium	
		- Pengiriman hasil pelayanan pemeriksaan PA yang dirujuk sudah sesuai dengan PKS. - Pemeriksaan yang membutuhkan rujukan ke Area Malang terkendala driver/ kurir yang searah.	
3.	Fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Instalasi Laboratorium	
		- Penggeseran alat DL Mindray karena adanya penambahan alat DL dari Enseval. - Kebocoran pada AC di Ruang Analisa Laboratorium. - Kebocoran pada alat Indiko, adanya kerusakan pada sparepart.	- Sudah diketahui IPSRS - Sudah dilakukan perbaikan oleh IPSRS - Sudah dilakukan pengorderan oleh vendor.
		Instalasi Gizi	
		- Terdapat kerusakan pada Thermostat Chiller untuk penyimpanan bahan makanan.	- Sudah dilakukan perbaikan oleh IPSRS dan tinggal menunggu pengadaan Thermostat.
		Unit Sterilisasi	
		- Pengajuan pengadaan mesin plasma. - Pembangunan ruang sterilisasi baru belum selesai.	- Sudah melakukan pengajuan ke PT DPM menunggu tindak lanjut. - Melakukan pembersihan secara berkala menjadi tanggung jawab shift akibat terlalu banyak debu akibat renovasi.
		Unit Laundry	

		- Mesin cuci Kanaba sering terjadi kerusakan sehingga menghambat pencucian mesin cuci	- Pengajuan mesin cuci baru ke PT DPM, menunggu tindak lanjut.
		-	-
4.	Mutu	Instalasi Laboratorium	
		- Terdapat IKP, KTC karena kesalahan penginputan hasil laboratorium dan identifikasi pasien	- Mengingat staf terkait.
		Unit Laundry	
		- Masih ada kejadian linen tercampur limbah underpad	- Koordinasi dengan kepala unit terkait dan PPI.
5.	PPI	Instalasi Laboratorium	
		- Telah dilakukan Pelatihan Internal PPI BDRS oleh staf lab yang melakukan Pelatihan Eksternal. - Kepatuhan penggunaan APD Staf yang kurang.	- Evaluasi aplikasi dari pelatihan yang telah diterima di dalam kegiatan pelayanan. - Melakukan sosialisasi dan peneguran kepada staf terkait.
		Unit Sterilisasi	
		- Kepatuhan penggunaan APD Staf yang kurang.	- Melakukan sosialisasi dan peneguran kepada staf terkait.
		Unit Laundry	
		- Kepatuhan penggunaan APD Staf yang kurang.	- Melakukan sosialisasi dan peneguran kepada staf terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Pengembangan layanan baru sudah berjalan dibawah pengawasan manajemen rumah sakit
2. Pencapaian target layanan diimbangi dengan efisiensi di berbagai bidang

1.2 Saran

1. Dengan adanya pengembangan layanan baru, harus diimbangi dengan peralatan dan SDM yang memadai
2. Pencapaian target dengan penembangan layanan di beberapa unit untuk menambah nilai jual layanan rumah sakit

BAB VI PENUTUP

Demikian laporan Bulan Maret 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Maret tahun 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Pasuruan, 15 April 2024
Direktur RS Prima Husada,



 **Dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS**